

АНАЛИЗ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

*Шорогаева Б.А., Шериева Т. М., Кабилдина Н.А., Шакирова А.Ф.,
Рубцова Л. Н., Николаева А. А.*

КГКП «Областной онкологический диспансер» (ООД), Караганда, Казахстан

Задачи исследования: анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗН) в Карагандинской области за 3 года (2008-2010гг.).

Материалы и методы исследования. Изучены данные медицинской документации по данным орг-метод отдела ООД. Применялись клинические, лабораторные, эндоскопические, ультразвуковые, рентгенологические, цитоморфологические, социальные (анкетирование), эпидемиологические, статистико-математические методы исследования. По мере необходимости больным назначались другие инструментальные методы исследования.

Результаты. Анализ динамики заболеваемости, смертности, запущенности, болезненности ЗН имеет большое значение для принятия обоснованных решений и планирования тенденции противораковой борьбы. В этой связи изучение эпидемиологических аспектов и прогнозирование заболеваемости ЗН представляет научный и практический интерес. На основе правильного прогнозирования возможно успешное планирование и проведение превентивных мероприятий, а также построение алгоритма по организации противораковой борьбы.

Всего за последние 3 года (2008-2010гг.) в ООД выявлено 8668 больных со злокачественными новообразованиями. Все они обследованы и пролечены в диспансерном, хирургических, радиологических, химиотерапевтическом отделениях ООД. Заболеваемость ЗН по области за 2008-2010гг. составила 217,8; 223 и 222,4, тогда как в среднем по Республике она составила соответственно 180,7; 182,6 и 181,3. Хотя наш регион по заболеваемости за этот период занимает традиционные 7 - 6 места, тем не менее, уровень заболеваемости достаточно высок. Структура онкологической заболеваемости (оба пола) выглядит следующим образом: 1 ранговое место занимал рак легкого, составив 27,1 и 27,6 за 2008-2009гг., в 2010 году си-

туация немного поменялась, на 1 место вышел рак молочной железы, составив 27,1 на 100 тысяч населения. На 2-3 местах ЗН кожи, молочной железы, также 4-5 места стабильно занимают ЗН желудка и ободочной кишки (за 3 года). За 2008-09гг. процент цитоморфологической верификации ЗН по области составил 88,2 и 91,3; заняв первые места по Республике, тогда как по РК показатели составили всего 80,4 и 80,6% соответственно. За последние годы по цитоморфологической верификации ЗН КООД лидирует, это не может не радовать специалистов онкологической службы. Запущенные стадии ЗН составили 24,1; 22,3 и 23,4%. Казалось бы, цифры на одном уровне держатся, но, к сожалению, наша область лидирует по этим показателям. Одна из главных причин запущенности ЗН – это поздняя обращаемость больных к врачам. Поэтому надо работать с населением в этой сфере, установить тесную связь с центром ЗОЖ, повышать санитарную грамотность, проводить агитационные мероприятия, увеличить количество выступлений в СМИ и т.д.

За этот период с впервые установленным диагнозом ЗН на учете на конец года состояли 53219 больных, из них 5272 умерли. У 481 пациент выявлены противопоказания к проведению специализированной терапии, отказались от лечения 406 и не закончили лечение 961 больной. Всего получили лечение: 2044 больных хирургическое, лучевая терапия - 421, химиотерапия - 497, комбинированное лечение - 623, комплексное - 655, химиолучевое - 8 и амбулаторное – 273 больных. Больные продолжают наблюдаться в диспансерном отделении КООД.

Выводы: Всего за последние 3 года отмечается рост заболеваемости ЗН по Карагандинской области, лидирующую позицию в общей структуре новообразований занял рак молочной железы.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ

Шакирова А.Ф.

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан

Задачи исследования. Оценка результатов лечения злокачественных опухолей яичников с выделением факторов прогноза.

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты лечения 436 больных раком яичников. Полученные результаты обработаны на персональном компьютере «Pentium-4» с привлечением программы STATISTICA 5.5. Расчеты выживаемости для групп проводили безинтервальным методом по Е. Kaplan - Р. Meier и интервальным методом – «таблицы жизни». Изучали показатели выживаемости в зависимости от стадии опухолевого процесса, морфологической характеристики, вида оперативного вмешательства, достоверность различий в группах определяли с помощью коэффициента Кокса (при сравнении пар) и коэффициента Гехана (для 3 и более групп сравнения). Зависимость плотности вероятности смерти (интенсивность смерти или функцию риска) определяли по экспоненциальной модели типа: $h(t) = -dS(t)/S(t) \cdot dt$, где интенсивность смерти характеризует риск смерти в момент (t). Рассчитывали также долевой вклад независимых факторов в разработанную модель.

Возраст больных раком яичников варьировал от 12 до 89 лет, средний – 54,3 года. Максимальное количество больных (72,8%) отмечено в возрастной группе старше 46 лет, пик заболеваемости приходится на 59 лет и старше – 40,9%. На долю распространенных форм рака яичников приходится большая часть (58%) всех случаев заболевания, со II стадией 21,4% больных, с I стадией – 20,6%.

Результаты. Независимо от стадии опухолевого процесса общая одногодичная выживаемость больных злокачественными опухолями яичников составила 66,7%, трехгодичная – 47,5%, 5-летняя – 37,8%. К третьему году жизни более половины больных погибают от прогрессирования опухолевого процесса. С увеличением стадии опухолевого процесса резко ухудшается выживаемость больных по наблюдаемым промежуткам времени. При I стадии рака яичников 3-х и 5-летняя выживаемость составляет 53% и 15%, соответственно, при II стадии она снижается до 15% и 7,5%. При III стадии 3-х и 5-летняя выживаемость больных снижается до 12% и 3%, а при IV стадии она составляет 10% и 3%. Сравнение по стадиям с I по IV достоверно ($\chi^2=24$; $p=0,0004$).

Оперативное лечение не проведено 156 (35,8%) больным из-за распространенности опухолевого процесса, тяжелых сопутствующих заболеваний. Основной части больных (41,5%) были выполнены радикальные операции: надвлагалищная ампутация матки с придатками с оментэктомией, экстирпация матки с придатками с оментэктомией.

Представляет интерес анализ случаев смерти у больных раком яичников. Первый пик плотности вероятности смерти приходится на 3-ий месяц, второй пик – на 12-ый месяц, третий более высокий – на 36-ой месяц, четвертый пик плотности вероятности смерти отмечается в 48 месяцев, пятый – в 56 месяцев. Больные не доживают до пятилетнего рубежа.

При использовании экспоненциальной регрессии (с оценкой по Коксу) выявлены факторы, определяющие плотность

вероятности смерти при раке яичников: стадия опухолевого процесса, морфологическая структура опухоли и комбинированное лечение ($p=0,000001$). Выявлено, что стадия процесса на 46,7% определяет плотность вероятности смерти, морфологическая форма опухоли – на 34,4% и комбинированное лечение – на 18,9%.

Выводы. Выживаемость больных зависит от стадии опухолевого процесса ($\chi^2=24$; $p=0,0004$), объема оперативного вмешательства ($p<0,001$), гистологической формы опухоли ($p<0,001$). Ожидаемая плотность вероятности смерти при злокачественных опухолях яичников зависит от стадии опухолевого процесса, морфологической структуры опухоли и варианта комбинированного лечения ($p=0,000001$).

БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ПЕРИАМПУЛЯРНОЙ ЗОНЫ

*Сейсембаев М.А., Баймаханов Б.Б., Рамазанов М.Е., Токсанбаев Д.С., Досханов М.О.
Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова,
г. Алматы, Республика Казахстан*

Цель. Улучшить результаты хирургического лечения больных с опухолями периапулярной зоны.

Материал и методы. С 2003 по 2010г в ННЦХ им. А.Н. Сызганова на лечении находилось 342 пациента с опухолями периапулярной зоны. Из них мужчин 185 (54,1%), женщин – 157 (45,9%), в возрасте от 28 до 88 лет. Всем больным было проведено комплексное обследование, включавшее УЗИ, КТ, ЭФГДС, МРХПГ ЭРХПГ, исследование опухолевых маркеров и, с целью верификации диагноза – биопсию опухоли. У 247 (72,2%) пациентов, опухоль располагалась в области головки поджелудочной железы, в 67 (19,6%) – в большом дуоденальном сосочке, у 25 (7,3%) – в терминальном отделе холедоха, у 3 (0,9%) – в двенадцатиперстной кишке.

Радикальные операции были выполнены 68 (19,9%) пациентам. В связи с нарушением проходимости общего желчного протока 42 пациентам выполняли предварительную декомпрессию желчных путей. Стандартная ПДР выполнена 59 больным, расширенная ПДР – 8, из них с частичной резекцией и пластикой воротной вены одному пациенту. Тотальная панкреатодуоденэктомия выполнена в одном случае, когда опухоль распространялась на головку и тело поджелудочной железы.

При радикальных операциях после удалении органокомплекса и лимфодиссекции все анастомозы выполнялись на одной петле с последовательностью: панкреато(панкреатико)еюно-, гепатоеюно- и гастроэюноанастомоз. При формировании панкреатодигестивного анастомоза, мы использовали панкреа-

тогастроанастомоз – 10 пациентам, панкреато(панкреатико)еюноанастомоз по типу микроэюностомии с целью декомпрессии в области анастомоза – 16 больным. С целью профилактики послеоперационного острого панкреатита и несостоятельности панкреатодигестивного анастомоза, во всех случаях проведено лечение сандостатином.

Результаты. Послеоперационные осложнения после отмечены у 16 (23,5%) пациентов. Послеоперационный острый панкреатит у 3 пациентов, частичная несостоятельность ПЕА у 9 пациентов и у одного частичная несостоятельность гепатоеюноанастомоза, а также в одном случае кровотечение из острой язвы желудочно-кишечного тракта и в двух случаях аррозивные кровотечения.

В послеоперационном периоде летальный исход отмечен в 9 (13,2%) случаях, причинами которой были: аррозивное кровотечение, ДВС-синдром, полиорганная недостаточность.

Выводы. Таким образом, больным с опухолями периапулярной зоны осложненной механической желтухой необходимо двухэтапного хирургического лечения, что позволяет в большинстве случаев произвести радикальные оперативные вмешательства, несмотря на исходное тяжелое состояние.

Применение аналогов сандостатина при оперативных вмешательствах на поджелудочной железе, предупреждает развитие острого панкреатита и несостоятельности панкреатодигестивного анастомоза, что способствует значительному снижению частоты послеоперационных осложнений и летальных исходов.

CLINICAL FEATURES OF UTERINE SARCOMA

*Sukhin V., Mihanovskij A., Sukhina E., Krugovaja I.,
Slobodjanjuk O., Fedorenko N., Granovskaja A.,
Grigoriev Institute of medical Radiology NAMS of Ukraine*

Background. Uterine sarcoma is a rare tumor, appearing in 4-9 % of patients and usually has a bad prognosis. That's why the objective of this work is to investigate the clinical features of the uterine sarcoma.

Material and methods. There were analyzed clinical data of 73 patients with uterine sarcoma stages I - IIIA, IVB (T1-3aNxM0-1) treated in clinic of the Institute of Medical Radiology from 1994 to 2010.

Results. The patients age was 28–78 years old, mean age – (54,7 ± 10,5) years old, median – 55,0 years old. The morbidity peak was at age category 50–59 years old (32,8 ± 5,5) %. At age younger than 30 years old was 1 patient – (1,4 ± 1,4) %, older than 70 years old – 6 patients (8,2 ± 3,2) %.

There were revealed, in our study prevailed patients with stage I – 49,3%. Stage II was in 24,7%, stage III – in 16,4%, stage IV – in 9,6% cases.

Analyzing histological structure of tumor there was defined that leiomyosarcoma was in 31 (42,5 ± 5,8 %) patients, endometrial stromal sarcoma – in 22 (30,1 ± 5,4 %), carcinosarcoma – in 16 (21,9 ± 4,9 %), other types: fibrosarcoma – in 1 (1,4 ± 1,4 %), и mixed type - in 3 (4,1 ± 2,3 %) patients.

Relapse of the disease was detected in 44 patients (60,2%).

Conclusion. The morbidity peak was at 50–59 years old. There have been met patients with I stage of disease the most frequently. Uterine sarcoma has an aggressive course, with a high frequency of recurrence.

ВЛИЯНИЕ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ С ОДНОВРЕМЕННЫМ И АДЪЮВАНТНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕМОЗОЛОМИДА И ПРОИЗВОДНЫХ НИТРОЗОМОЧЕВИНЫ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ГЛИОМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА (ЗГГМ)

Жумадуллаев Б.М., Ким В.Б., Быковская А.Н., Аитахунов М.Л.,
Тохмолдаева К.А., Алмабек А.Т., Каиназаров Ч.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, г.Алматы

До настоящего времени стандартом терапии ЗГГМ была лучевая терапия, а общая выживаемость (OS) оставалась крайне низкой. Включение в послеоперационной ЛТ производных нитрозомочевина немного улучшило результаты лечения ЗГГМ. В исследованиях проведенные Европейской организацией по изучению рака (EORTC) и Национальным институтом рака Канады (NCIC) получены результаты, указывающие на увеличение 2-летней выживаемости у взрослых больных с глиобластомой (ГБ), которые получили химиолучевую терапию и адъювантную химиотерапию темозоломидом.

Методы исследования: в исследования включены 41 детей в возрасте от 4-х до 17 лет, с впервые выявленной анапластической астроцитомой (АА) – 33 и ГБ – 8 детей, с показателем общего состояния по шкале Карновского не ниже 30 и с подтвержденным гистологическим диагнозом. Всего мальчики – 27 (65,8%), девочки – 14 (34,2%), из них: 4 – 9 лет – 16 детей, 10-14 лет – 18 детей и 15 – 17 лет – 7 детей (медиана возраста – 10,4 лет). Объем предшествующего оперативного лечения указывался нейрохирургом и подтверждался МРТ с КУ перед началом химиолучевого этапа терапии. Тотальное удаление опухоли – 12 (36,4%), частичное удаление – 18 (54,1%) и биопсия опухоли – 3 (9,1%).

Протокол лечения: ЛТ + темозоломид + фотемустин /или CCNU (1 цикл) + 6 циклов ПХТ (темозоломид+ фотемустин/ или ломустин). ЛТ проводился на линейном ускорителе спустя 2-3 недели после операции на зону опухоли с захватом здоровой ткани, отступая на 3 см от краев поражения в РОД=1,8 Гр, 5 фракции в неделю, до СОД=55 Гр. Одновременно с ЛТ в первую неделю облучения проводился один цикл ПХТ: - Темозоломид- 150 мг/м², в капсулах, в 1 – 5 дни; - Фотемустин - 100 мг/м², в/в, капельно – 1, 8 день (или CCNU- 120 мг/м² – 1 день, через 2 часа после приема темодала).

Результаты. По данным МРТ головного мозга с КУ полный эффект наблюдался у 7 (17,5%), частичный ответ – у 12 (30,0%),

стабилизация процесса – у 13 (32,5%) и прогрессирования заболевания – у 8 (20,0%) больных. При этом патологические неврологические симптомы заболевания после ХЛЛ этапа значительно регрессировали у 82,5% пациентов и активность по шкале Карновского повысились от 30- 60 до 60 – 100 у 70,0% больных, отмечалось улучшение качества жизни. В основном полный эффект был зарегистрирован у пациентов с «тотальным» удалением опухоли, но при МРТ с КУ перед ХЛЛ отмечались накопление контрастного вещества в виде линейности по краям удаленной первичной опухоли. Объективный ответ при проведении химиолучевого этапа и цикловой ХТ был получен у 32 (80,0%) пациентов. OS оценена у всех пациентов: 1-годичная OS для всей группы составила – 85,4±5,5%, 2-летняя выживаемость – 75,6±6,7%, при медиане наблюдения 16,6 мес. Выживаемость без прогрессирования заболевания (PFS) оценена у всех больных: 1- годичная PFS составила – 70,7±7,1% и 2-летняя PFS – 51,2±7,8%.

Выводы: Результаты лечения ЗГГМ напрямую зависят от объема хирургического и химиолучевого лечения. Полученные данные демонстрируют эффективность химиолучевого лечения и цикловой химиотерапии темозоломидом и производными нитрозомочевина в лечении детей с первично диагностированной АА и ГБ. Общая 2-летняя выживаемость составила 75,6±6,7%, а 2-летняя выживаемость без прогрессирования - 51,2±7,8%. Т.о., на основании литературных данных и данных собственного исследования в настоящее время стандартом лечения ЗГГМ у детей следует считать максимальное хирургическое удаление опухоли с последующим проведением ЛТ с одновременным и адъювантным применением темозоломида и производных нитрозомочевина.

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСТОРАКАЛЬНОЙ ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ ОКРУГЛЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКИХ ПОД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Чапаган Д.А.

КГКП «Областной онкологический диспансер» г. Караганда, Казахстан

Объемные образования легких являются одними из сложных диагностических задач. Трудность дифференциальной диагностики заключается в том, что рентгенологически определяемая тень в легком, может быть отображением более 70 заболеваний. Методом выбора всегда считалось проведение трансторакальной биопсии под контролем рентгеноскопии. В последние годы в диагностике округлых образований легких широко используется метод ультразвукового исследования, который при субплевральном локализации образования обладает высокой специфичностью и точностью.

Цель исследования – изучить возможность проведения трансторакальной пункционной биопсии округлых образований легкого под контролем ультразвукового исследования

Материалы и методы. Проведено ультразвуковое исследование легких с последующей трансторакальной пункцией у 157 больных с округлыми образованиями. Возраст пациентов от 53 до 82 лет. Исследование проводили в Карагандинском онкологическом диспансере.

УЗИ проводилось на аппарате Medison (Южная Корея) с конвексным датчиком 3,5-5 МГц. Трансторакальная пункция

проводилась после рентгенологического обследования и визуализации образования при эхографии. Положение больного при проведении трансторакальной пункции зависело от локализации образования в легком. Использовался метод «свободной рукой», когда направление пункции выбирается путем исследования в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, по отношению к образованию.

Результаты и обсуждение. Эффективная визуализация образования в легком, а также проведение трансторакальной пункционной биопсии возможно только при его субплевральном расположении. При проведении трансторакальной пункции под контролем рентгеноскопии глубина залегания опухоли с учетом мягких тканей грудной клетки должна быть не более 6-7см. А при проведении ее под контролем эхографии основное значение имеет месторасположение опухоли по отношению к висцеральной плевре.

Важным преимуществом трансторакальной аспирационной биопсии является возможность определения зоны опухоли, оптимальной для забора аспирационного материала, а также глубины введения пункционной иглы. Это позволяет избегать

зон распада в опухоли. Трансторакальная аспирационная биопсия под контролем цветового доплеровского картирования позволяет визуализировать сосудистые структуры, окружающие опухоль или определяющиеся внутри нее, и, следовательно, избегать их повреждения при взятии пробы из опухоли. Также большое значение имеет отсутствие лучевой нагрузки на врачей, проводимых данную манипуляцию и пациента, особенно при повторных пункциях.

В исследовании трансторакальная пункционная биопсия

проводилась при локализации образования в корне легкого, верхушечных сегментах, возле крупных сосудов. Размеры образования при проведении пункционной биопсии варьировали от 1 до 11 см.

Выводы. Трансторакальная пункционная биопсия под контролем ультразвукового исследования субплеврально расположенных округлых образований легких является информативным методом верификации диагноза.

ВОПРОСЫ ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА РОТОГЛОТКИ

Тулебаев Р.К., Исмагулова Э.К., Шагатаева Б.А.

*АО «Медицинский университет Астана», Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени М.Оспанова*

Целью нашего исследования является улучшение непосредственных и отдаленных результатов лечения рака ротоглотки.

Мы провели анализ результатов лучевого и химиолучевого лечения 117 больных раком ротоглотки с использованием гиперфракционированного облучения и стандартной лучевой терапии, а также комбинированного применения лучевой терапии и лекарственной с использованием цисплатина и фторурацила.

В зависимости от вида консервативного лечения больные были распределены на две группы: 1гр. - 80 больных, получивших лучевую терапию в самостоятельном варианте;

2гр. - 37 получили комбинированное лечение: неоадьювантную химиотерапию и лучевую терапию в двух режимах фракционирования (15 больным стандартная лучевая терапия и 22 – гиперфракционированное облучение).

Сравнительный анализ эффективности двух вариантов лучевой терапии: частота рецидивов после гиперфракционированного облучения (40,8%) оказалась ниже, чем после стандартного облучения (54,8%). Общая частота неудач лечения (остаточная опухоль, рецидивы заболевания, отдаленные метастазы) при гиперфракционировании составила 70,5% против 87,1% при обычном фракционировании.

Показатели общей выживаемости и безрецидивной выживаемости у больных после гиперфракционирования оказались выше (35,7%), чем после стандартного облучения (17,5%). Пятилетняя выживаемость после гиперфракционированного облучения среди больных с III и IV стадиями заболевания составила 52,8±8,1% и 21,8±6,2% против 22,5±5,1% и 8,3±4,0% после стандартного облучения. Общая 5-ти летняя выживаемость больных, перенесших лучевую терапию составила 25,4±2,9%, безрецидивная - 21,2±2,9%. Показатели общей

и безрецидивной 5-ти летней выживаемости у больных с IV стадией статистически значимо ниже (15,1%), чем показатели у больных с III стадией (34,3%). Рецидивы у больных с IV стадией отмечались в 1,3 раза чаще, чем с III.

Неоадьювантная химиотерапия рака ротоглотки показала значительную лечебную эффективность при использовании двух режимов облучения: показатели 5-ти летней общей и безрецидивной выживаемости больных после химиолучевой терапии составили 32,8% и 30,8% соответственно. Показатели 5-ти летней выживаемости у больных с III и IV стадией составили 41,7% и 25,7% соответственно. Проведение неоадьювантной химиотерапии и облучения в режиме гиперфракционирования вызывает большую эффективность по сравнению с аналогичной лекарственной терапией, сочетавшейся со стандартным курсом облучения. Так, 3-х летняя общая выживаемость составила 43,0±5,9% и 22,0±9,8%.

Таким образом, результаты проведенных клинических исследований показали несомненное преимущество методики гиперфракционированного облучения рака ротоглотки по 1Гр три раза в день с суточной дозой 3Гр. Расщепление курса лучевой терапии на три этапа с перерывами 14 - 17 дней позволило в пределах толерантности нормальных тканей подвести к опухоли СОД в среднем до 80Гр и увеличить 5-ти летнюю выживаемость больных с III-IV стадиями рака ротоглотки до 35,7±5,3% и 18,0±3,0% соответственно. Неоадьювантная химиотерапия рака ротоглотки показала значительную лечебную эффективность при использовании двух режимов облучения. Полная регрессия опухоли выявлена у 57,6% больных 4 подгруппы и у 55,6% больных в 3 подгруппе. Рецидивы выявлены у 42,1% больных 4 подгруппы и у 50,0% - 3 подгруппы. Показатели 5-летней общей выживаемости в 3 и 4 подгруппах составили 22,2±6,2% и 36,0±6,8% соответственно.

ВЫБОР РАДИКАЛЬНОГО МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЧАГОВЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ

Токсанбаев Д.С., Сахипов М.М., Чорманов А.Т., Баймаханов Ж.Б.

Алматы, ННЦХ им. А.Н. Сызганова

Отделение хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы

Резекционные вмешательства являются самым оптимальным объемом радикального хирургического вмешательства при первичном и метастатическом раке печени.

Цель. Провести анализ результатов радикальных резекционных вмешательств на печени при злокачественных очаговых образованиях на печени.

Материал и методы. С 2004 по 2011гг выполнено 51 анатомических и атипичных резекций печени по поводу первичного и метастатического рака печени. Всем больным было выполнено радикальное хирургическое лечение с удалением опухолевых узлов в пределах здоровых тканей. Размеры очагов варьировали от 5 до 27см в диаметре. Возраст пациентов был от 21 до 73 лет. Выполнены операции гемигепатэктомия:

РПГГЭ у 4(7,84%), ПГГЭ у 19(37,25%), ПГГЭ+ правосторонняя гемиколэктомия у 1(1,96%), РЛГГЭ у 1(1,96%) и ЛГГЭ у 5(9,8%) у больных. Левосторонняя кавальная лобэктомия (ЛКЛЭ) выполнена у 5(9,8%) и ЛКЛЭ+ атипичная бисегментэктомия у 1(1,96%) больного. Различные неанатомические резекционные вмешательства были произведены у 15(29,41%) больных. В данный анализ не включены резекционные вмешательства, выполненные по поводу холангиоцеллюлярного рака и рака желчного пузыря.

Результаты. Послеоперационные специфические осложнения после выполненных резекционных вмешательств развились у 9 (17,64%): острая печеночная недостаточность у 4(7,84%), формирование желчного свища у 1(1,96%), вну-

трибрюшное кровотечение отмечено у 4(7,84%) больных после выполненных неанатомических резекций печени. Послеоперационная летальность составила 3(5,88%) человек. Причиной послеоперационной летальности после оперативного лечения послужила острая печеночная недостаточность.

При выборе каждого из выполненных методов радикального хирургического лечения имели место свои показания и противопоказания для выполнения анатомических или нетипичных резекционных вмешательств. Учитывался размер и количество опухолевых образований, их расположение по отношению к сосудам. С применением современных специфических технологий, отработанной технике выделения элементов

ГДС и кавальных структур в группе больных с анатомическими резекциями удалось достоверно снизить общую операционную кровопотерю в среднем до 300-350мл.

Выводы. При наличии богатого опыта выполнения резекций печени, техническое оснащение операционного блока специфическим оборудованием операцией выбора для радикального лечения злокачественных очаговых поражений печени являются анатомические обширные резекции печени, которые в процессе отработки техники резекционных вмешательств на печени представляют снижение частоты послеоперационных специфических осложнений.

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДСКОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ Г.АЛМАТЫ НА ОСНОВАНИИ ОПРОСНИКА EORTC IN-PATSAT32

Кайдарова Д.Р., Хожаев А.А., Шатковская О.В., Балтаев Н.А.

Городской онкологический диспансер,

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова

Актуальность. Опросник EORTC IN-PATSAT32 представляет собой анкету, характеризующую удовлетворенность пациентов оказанной помощью в медицинском учреждении. Данный опросник содержит 32 вопроса с пяти возможными вариантами ответов, которые формируют три шкалы и один одиночный пункт. Первая шкала включает 11 вопросов и оценивает работу врачей, вторая шкала содержит также 11 пунктов и характеризует работу среднего медицинского персонала, третья шкала состоит из 9 вопросов и оценивает работу вспомогательного персонала и последний, 32-й пункт опросника характеризует общее впечатление пациента от пребывания в клинике. Важный аспект применения данного опросника заключается в возможности его использования для внутреннего аудита работы медицинского учреждения, с целью улучшения качества оказываемой медицинской помощи (КОМП).

Цель работы: мониторинг КОМП в Городском онкологическом диспансере (ГОД) г. Алматы.

Материал и методы. Для объективной оценки показателей КОМП согласно международных стандартов была проведена языковая и культурная адаптация опросника EORTC IN-PATSAT32. Динамическая оценка КОМП в ГОД г. Алматы проводилась, начиная с 2008 года ежегодно и, в свою очередь - ежеквартально. Созданная версия опросника EORTC IN-PATSAT32 заполнялась пациентами, находящимися на лечении во всех клинических подразделениях ГОД г. Алматы в конце каждого квартала.

Результаты. Сравнительная оценка показателей КОМП

в ГОД г. Алматы в динамике, начиная с 2008 года показала, что по всем шкалам опросника EORTC IN-PATSAT32 имеет место рост показателей, характеризующих улучшение КОМП, о чем говорят и результаты анкетирования за 3 квартала 2011 года. При этом, если в 2008 году по шкале, отражающей работу врачей средний балл составил $67,9 \pm 4,7$, то в 2010 году – уже $89,5 \pm 3,1$ ($p < 0,05$); по шкале, характеризующей работу среднего медицинского персонала – $62,8 \pm 4,8$ балла и $91,4 \pm 2,8$ балла ($p < 0,05$); шкале, оценивающей работу вспомогательного персонала – $64,1 \pm 4,8$ балла и $74,2 \pm 4,4$ балла ($p > 0,05$) и шкале, показывающей общее впечатление пациента от пребывания в клинике – $71,5 \pm 4,5$ балла и $90,6 \pm 2,9$ балла ($p < 0,05$) соответственно.

Заключение. После проведения согласно международных стандартов языковой и культурной адаптации опросника EORTC IN-PATSAT32 создана версия данного опросника, эквивалентная оригиналу инструмента с учетом этнолингвистических особенностей популяции. Динамический мониторинг КОМП в ГОД г. Алматы показал, что имеет место улучшение этих показателей как со стороны врачебного, так и сестринского персонала, складываясь в общую высокую оценку пациентами работы учреждения. При этом созданная версия опросника EORTC IN-PATSAT32 характеризуется высокими психометрическими свойствами, что позволяет широко применять ее для мониторинга КОМП в медицинских организациях.

ДОПЛЕРОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕТРОГРАДНОГО КРОВОТОКА В МАГИСТРАЛЬНЫХ ВЕНАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ

Цаюкова Н. А.

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан

КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан

Задачи исследования: выявление информативности доплерографических показателей ретроградного кровотока в магистральных венах нижних конечностей у больных раком молочной железы (РМЖ), получающих полихимиотерапию.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 62 пациентки РМЖ, средний возраст 56,2 года, получавших лечение в Карагандинском ООД в 2011 году. Первая стадия РМЖ диагностирована у $(43,5 \pm 6,3)\%$ больных, IIa стадия – у $(37,1 \pm 6,1)\%$, IIb стадия – у $(12,9 \pm 4,3)\%$, IIIa стадия – у $(4,8 \pm 2,7)\%$, IIIb стадия – у $(1,6 \pm 1,6)\%$ пациенток. На момент обследования $(53,2 \pm 6,3)\%$ больных получали неoadъювантную ПХТ от одного до трех курсов, $(30,6 \pm 5,9)\%$ пациенток были после

комбинированного, $(16,1 \pm 4,7)\%$ - после комплексного лечения. Инструментальное исследование включало ультразвуковое дуплексное и триплексное сканирование сосудов, которое выполнялось на УЗ-сканерах SonoAse (Medeson) с использованием конвексных датчиков 3,5-6,5 МГц и линейных датчиков с частотой 5-9 МГц. Ультразвуковое исследование выполнялось как минимум трижды во время нахождения в стационаре, а также спустя 2, 3 и 6 мес. после выписки. Количественный анализ венозного кровотока включал в себя оценку параметров: максимальной скорости кровотока (V_{max}), усредненной по времени средней скорости кровотока (TAV_{mean}), усредненной по времени максимальной скорости кровотока (TAV_{max}), объемной скорости

кровотока (Volume velocity – V vol). Объемную скорость кровотока рассчитывали по формуле:

где V vol – объемная скорость кровотока (мл/мин); π – константа, равная 3,14; D – диаметр вены (см); TAV mean – усредненная по времени средняя скорость кровотока (см/с). Использовали компьютерную программу «Statistica 5.5», проведено сравнение показателей по Т-критерию Стьюдента.

Результаты. Из 62 обследованных больных у 22 пациенток диагностировали тромбоз вен нижних конечностей.

Средний TAM max составил (8,7±0,9) см/с, средний пока-

$$V \text{ vol} = 60 \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot TAV \text{ mean}$$

затель V vol – (49,5±5,9) мл/мин. В группе больных РМЖ без тромбоза повышенный показатель V vol наблюдали в два раза чаще, а показатель TAM max – в два раза реже. При определении частоты встречаемости показателей TAM max и V vol у больных

раком молочной железы, получающих химиотерапию, выявлена следующая зависимость. В группе больных раком молочной железы без тромбоза повышенный показатель V vol наблюдали в два раза чаще, а показатель TAM max – в два раза реже.

При определении средних показателей TAM max и V vol у больных раком молочной железы, получающих химиотерапию, по группам сравнения выявили, что достоверной разницы средних показателей нет.

Риск возникновения тромбоза нижних конечностей у больных РМЖ достоверно коррелирует со всеми ультразвуковыми показателями. Прямая корреляционная зависимость тромбоза вен нижних конечностей выявлена при повышенном показателе TAM max (p<0,003) и V vol (p<0,003), обратная – выявлена при положительном ЦДК (p<0,003).

Выводы: В группе больных РМЖ с тромбозом повышенные скоростные показатели кровотока встречаются в два раза чаще, чем в группе пациенток без тромбоза (p<0,05).

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ У ЖЕНЩИН В ГОРОДЕ БАКУ

Ватанха С. С.

Национальный центр онкологии Минздрава Азербайджанской Республики,

Азербайджанская Республика, г.Баку

В структуре смертности населения земного шара от всех нозологических форм заболеваний смертность от злокачественных новообразований занимает 3-е место, а в ряде стран высокоразвитой индустрией конкурирует с показателями смертности сердечно-сосудистых заболеваниями [2, 10].

Рак молочной железы во многих частях земного шара является одной из наиболее часто встречающихся злокачественных опухолей у женщин. Кроме того, это одна из лидирующих причин смерти женщин от рака [1].

Примечательно, что с 1999 г. онкологические заболевания обогнали сердечно-сосудистые в качестве лидирующей причины смертности среди лиц моложе 85 лет. Среди лиц старше лет наблюдается обратная ситуация [7].

В мире в 2002 году по различным оценкам произошло 11 миллионов новых случаев заболеваний злокачественными новообразованиями и 7 миллионов смертей в результате их развития. И, в то же время, приблизительно 25 миллионов человек живут, продолжая болеть раком [8].

Различия в заболеваемости, смертности и распространенности злокачественных новообразований в отдельных регионах мира связаны с генетическими различиями и старением населения, однако, также играют роль и корректируемые фак-

торы риска, такие, как курение, и факционные заболевания, питание (недостаточное употребление фруктов и овощей) и физическая деятельность. Другие корректируемые факторы риска включают в себя избыточную массу тела/ожирение, загрязнение воздуха в городах, задымление жилых помещений из-за использования огня в хозяйстве, небезопасный секс и нестерильные инструменты в медицинских учреждениях [6].

Судя по всему, не менее одной трети смертей от онкологических заболеваний в мире можно предотвратить. Известные к настоящему времени этиологические факторы развития злокачественных новообразований подразделяют на химические вещества и вещества естественного происхождения, лекарственные препараты и гормоны, возбудители инфекций различные их ассоциации [9].

При раке молочной железы лишь 5-10% случаев обусловлены наследственными факторами. Среди случаев наследственного и семейного рака молочной железы приблизительно половину из них ответственны мутации BRCA1 и/или BRCA2 [5].

В настоящее время сложилось представление о том, что причиной заболевания злокачественными новообразованиями является действие на организм целой группы как эндогенных, так и экзогенных факторов [4].

Кi-67 КАК МАРКЕР ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Монахов Б.В., Сатбаева Э.Б., Кузнецова С.Г.

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

Городское патологоанатомическое бюро г. Алматы

Появившиеся в последние 10 лет сведения указывают на необходимость более точных критериев, позволяющих объективизировать назначение противоопухолевых средств и гормонотерапии. К их числу относятся иммуногистохимические исследования. Основной задачей нашего исследования было определение пролиферативной активности по уровню белка Ki-67 в зависимости от уровня рецепторов эстрогена и прогестерона, а также гена HER-2/neu.

Проведенные нами иммуногистохимические исследования у 429 больных раком молочной железы свидетельствуют об обнаруженной нами обратной зависимости между пролифера-

тивной активностью, о которой мы судили по критерию белка Ki-67, и уровнем рецепторов эстрогена и уровнем рецепторов прогестерона. Установлена прямая зависимость между пролиферативной активностью и явно положительным наличием белка HER2/neu или степенью злокачественности рака молочной железы. Полученные результаты позволяют рекомендовать в клинической практике использование интегрального критерия пролиферативной активности Ki-67 при выборе конкретных схем полихимио- и гормонотерапии с учетом интенсивности терапии, ее частоты и поддерживающих курсов для индивидуализации лечения больных раком молочной железы.

ИЗУЧЕНИЕ КАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ ВОДЫ)

Доскеева Р.А., Каримов М.А., Сейтказина Г.Д.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Расчеты индивидуального канцерогенного риска, основанные на содержании канцерогенных веществ в пробах объектов окружающей среды (ОС) проводились на значениях канцерогенных потенциалов для бенз(а)пирена (БП) и кадмия (Cd).

Величина индивидуального канцерогенного риска определялась по формуле: $CR = LADDSF$, где, CR- индивидуальный канцерогенный риск;

Оценка уровня индивидуального канцер-риска проводилась согласно метода и классификации по Новикову С.М. с соавторами и Любченко П.Н.

Индивидуальный риск в течение всей жизни более 10^{-6} , но менее 10^{-4} соответствует зоне условно приемлемого (допустимого) риска для населения в целом.

Расчеты индивидуального канцер-риска, основанные на содержании канцерогенных веществ в пробах воды были проведены на значениях канцерогенных потенциалов для бенз(а)пирена и кадмия.

Расчеты индивидуальных канцерогенных рисков в пробах воды, привезенных из ВКО основанные по содержанию БП и Cd показали, что в пробах воды г.Усть-Каменогорска - г.Иртыш, г.Ульба, водохранилища, ЦВС канцерогенный риск по БП (мг/л) был 1,7-7-8,8-7, 2,0-5 -1,0-6, 2,7-5-1,4-6, 1,2-8-6,6-7 соответственно объекту ОС. Значения по кадмию (мг/л) составили 9,7-6-1,5-4 , 2,2-5-3,6-4, 3,2-6-5,4-5, 4,2-6-6,9-5.

В пробах воды Глубоковского района ВКО – р.Ульба, р.Иртыш, г.Глубочанка, колодец №1, колодец №2, колодец №3 канцер-риск по БП составил 3,2-5-1,7-4, 3,5-4-3,9-4 , 1,1-4-4,9-4 , 3,6-6-1,1-5, 4,5-6-1,4-5, 1,4-6-4,6-6. По кадмию (мг/л) соответственно объекту ОС - 1,1-6-1,7-5, 2,2-6-3,6-5, 2,2-6-1,8-5, 3,2-6-5,3-5, 2,2-6-3,6-5, 1,3-6-1,7-5. В пробах воды Шемонаихинского района ВКО – р. Ульба, р. Уба, ЦВС, колодец CR по БП (мг/л) был 2,1-6-9,5-6, 1,2-7-5,6-7 , 1,4-8-6,6-8, 1,3-7-1,3-6 соответственно объекту ОС. По кадмию CR составил 1,0-6-1,7-4, 1,1-6-1,4-4, 1,3-5-2,1-4, 9,7-6-1,5-4.

Рассчитанные показатели индивидуального канцерогенного риска, основанные на содержании БП и кадмия в пробах воды, привезенных из исследуемых районов ВКО, относятся к низкому и минимальному уровню риска для населения и подлежат периодическому контролю. Канцерогенный риск для БП, содержащегося в пробах воды на уровне 10^{-4} , относящегося к низкому и среднему риску, в основном был в пробах, привезенных из промышленного Глубоковского района ВКО. Эти пробы воды были из децентрализованных источников водоснабжения питьевой воды.

Таким образом, следует предположить, что вода децентрализованных источников водоснабжения может представлять канцерогенный риск для здоровья населения, что обусловлено присутствием канцерогенных веществ БП и Cd.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА

Жолдыбай Ж.Ж., Садыков М.С., Чорманова Р.Р., Ахметова Г.С., Садыков С.С.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, ЦКБ УДП РК

Анализ наблюдений позволил определить возможности различных методов исследования в оценке распространенности опухолевого процесса. Проведенные наблюдения и их анализ дал возможность выработать рациональную диагностическую тактику применения диагностических методов при колоректальном раке. С целью углубленного научного анализа данных клинического, инструментального и лучевых методов обследования больных с онкологическими заболеваниями толстой кишки на различных этапах диагностики и лечения была проведена сравнительная оценка информативности визуальных методов диагностики колоректального рака.

Результаты КТ измерений в большинстве случаев соответствовали макроскопическим размерам опухоли. Преуменьшение размеров опухоли при эндоскопическом исследовании и первично-двойном контрастировании (ПДК) объяснялись отсутствием возможности измерить экстраорганный протяженность образования, которая являлась максимальным ее размером. Кроме того, невозможность продвижения колоноскопа или ректоскопа при стенозирующих опухолях также служила причиной неудачных измерений. Преувеличение размеров опухоли при ПДК наблюдалась в тех случаях, когда максимальным был размер опухоли по длиннику и не учитывался феномен проекционного искажения. Ошибочные результаты измерений при трансабдоминальной эхографии были следствием недостаточной визуализации органа из-за большого количества газа в кишечнике. При эндоскопическом и рентгенологическом исследовании толстой кишки оценка инвазивности роста опухоли была ограничена возможной, даже при группировании стадий Т3 – Т4. Эти методы малоэффективны вследствие невозможности оценки внекишечного роста опухоли и поэтому представляли

значительное количество ошибочных результатов. Возможности КТ более информативны, по сравнению с ПДК и УЗИ в определении размеров опухоли по длиннику и поперечнику, измерении толщины пораженной стенки, а также протяженности опухоли по отношению к окружности кишки. Измерения проводили как по аксиальным срезам, выполненным на уровне опухоли, так и по реконструктивным изображениям необходимого сечения отрезка кишки, пораженного опухолью.

Анализ наблюдений позволил определить возможности различных методов исследования в оценке распространенности опухолевого процесса. При этом следует, что эндоскопическое исследование толстой кишки с биопсией, комплексное рентгенологическое исследование, ультразвуковое исследование органов брюшной полости является тем минимальным диагностическим алгоритмом, который необходим для дифференциальной диагностики колоректального рака.

Эндоскопическое исследование рекомендуется в качестве основного метода диагностики в скрининговой программе раннего выявления колоректального рака. Ультразвуковое исследование толстой кишки выполняется после уточнения локализации зоны обструкции с помощью эндоскопического или рентгенологического методов.

Анализируя достоинства и недостатки клинических и инструментальных методов диагностики колоректального рака можно сделать вывод, что ни один из них не является абсолютно точным. Только комплексное использование в определенной последовательности традиционных рентгенологических, ультразвуковых и КТ методов диагностики в состоянии преодолеть ограничения классических приемов обследования пациентов.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДНК-ПЛОИДНОСТИ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО

*Кабиева А.О., Мухаметгалиев Н.А., Карасаев М.И., Баймухаметов Э.Т., Шибанова А.И.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, Республика Казахстан*

Изучение молекулярно-биологических особенностей клеток опухоли, по сути лежащих в основе злокачественного процесса, позволяет выявлять дополнительные критерии, которые в комплексе с традиционными данными могут быть использованы для определения прогноза заболевания и выбора соответствующей тактики лечения больного. В последние годы вызывает интерес способ прогнозирования течения опухолевого процесса на основании определения ДНК-ploидности клеток в опухолевом узле. При злокачественной трансформации и последующей прогрессии опухоли достаточно часто возникает анеуплоидный генотип опухолевых клеток. Для разных видов опухолей были выявлены некоторые общие закономерности: диплоидные опухоли имели более благоприятное течение, чем анеуплоидные. Сопоставление ДНК-цитометрических параметров с клиническими данными течения заболевания показывает информативность показателя ploидности ДНК опухолевых клеток и позволяет рассматривать его как важный прогностический признак.

Материал и методы исследования. Для ДНК-цитометрии был использован операционный материал, полученный от 62 больных раком легкого II-III ст., находившихся на лечении в отделении опухолей легких и средостения КазНИИОиР. Средний возраст больных 58,3±0,8 лет. Во всех случаях диагноз был подтвержден цитологически и гистологически. Определение ДНК ploидности опухолевых клеток проводилось методом лазерной проточной цитофлуориметрии на аппарате BD FACSCalibur. В качестве диплоидного контроля служили лимфоциты крови доноров, выделенные в градиенте плотности. Непосредственно перед исследованием на проточном анализаторе опытные и

контрольные пробы окрашивали раствором пропидия иодида (Becton Dickinson). Анализ выживаемости больных проводили по общепринятым в клинической онкологии статистическим методам.

Результаты. При исследовании контрольных и опытных образцов на проточном цитофлуориметре были получены DotPlot точечные графики для каждой пробы и гистограммы, отражающие количественное содержание ДНК. При анализе гистограмм индекс ДНК (DI) диплоидных клеток соответствовал 1,0. DI анеуплоидных клеток был больше или меньше 1,0. Диплоидный тип опухоли был выявлен у 17 больных (27,4%). Анеуплоидный тип новообразования был обнаружен у 45 пациентов (72,6±5,7)%.

У 21 пациента проследили 1-годовалую выживаемость. В связи с небольшим количеством больных расчет выживаемости проводили без учета пола пациентов, стадии заболевания и гистологической формы опухоли. Общая одногодичная выживаемость составила (71,4±1,5)%. Из 6 больных, умерших в течение первого года после операции, у 5 был анеуплоидный тип новообразования. Одногодичная выживаемость больных с диплоидным типом опухоли составила (83,3±9,6)%. Одногодичная выживаемость больных с анеуплоидным типом новообразования составила (66,7±2,4)%.

Таким образом, данные ДНК-цитометрии являются дополнением в оценке биологических особенностей опухоли. При раке легкого чаще встречаются новообразования анеуплоидного типа. Отмечается тенденция более благоприятного течения процесса у больных с диплоидными опухолями.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В КОНТЕКСТЕ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ

Афонин Г.А., Толстикова А.Ю.

*Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова
Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии.*

Благодаря ранней диагностике и улучшению эффективности комплексного лечения онкологических больных отмечается повышение 5-летней выживаемости. Исследования последнего времени показали, что, не смотря на высокий уровень выраженности физических (соматических) жалоб, часть онкологических больных отмечает приблизительно такой же уровень психосоциальной активности, как и люди одинакового с ними возраста из общей популяции. Однако наряду с этим онкологические больные испытывают специфические проблемы, в частности, чувство неопределенности относительно своего будущего (мысли о возможном скором фатальном исходе заболевания, что обусловлено бытующим распространенным мнением о неизлечимости онкологической патологии), мысли о возможном рецидиве, что определяет пристальное внимание пациентов к многочисленным физическим симптомам.

Не смотря на возросший уровень выживаемости при отдельных видах опухолей вследствие улучшения диагностики и лечения, сама природа рака как угрожающего жизни состояния остается мощным стрессовым фактором для большинства пациентов. И факт заболевания сам по себе, и лечение, и связанные с ним побочные эффекты (утомляемость, боль и различного рода функциональные нарушения) оказывают влияние на психологическое благополучие больных. Онкологические больные представляют собой группу лиц всех возрастных категорий, имеющую стойкое нарушение функций организма, которое приводит к ограничению жизнедеятельности, к изоляции и вызывает необходимость их социальной защиты. Большинство пациентов испытывают значительный психологический дискомфорт, что существенно влияет на процесс их адаптации к изменившимся

условиям жизни.

При изучении психологических аспектов онкологических заболеваний в контексте долговременной выживаемости (т.н. отсроченных психологических эффектов онкологического заболевания и протовоопухолевого лечения) было показано, что некоторые больные наряду с долговременными негативными психосоциальными последствиями своего диагноза отмечают и положительные аспекты заболевания. Так, около 30-50% онкологических больных из разных европейских стран сообщали о так называемых «позитивных аспектах» или «посттравматическом росте» - более позитивном самовосприятии, лучших социальных взаимоотношениях и отношениях с близкими, о том, что после установления диагноза злокачественного заболевания они начинают больше ценить жизнь, тем самым избавляясь от впечатления, что жизнь (т.е. здоровье) — это нечто само собой разумеющееся.

Лечение, как и состояние онкологического больного важно рассматривать комплексно, не расчленяя его на «стационарное» и «нестационарное», тем самым сохраняя преемственность в лечении, которая так нужна онкологическим больным. Многие больные после проведения им хирургической операции проходят несколько последовательных циклов лучевой или лекарственной терапии, так что процесс лечения занимает несколько месяцев (а иногда даже и лет). В этом случае врачу важно понимать — каким образом меняется в динамике психический статус больного, хотя бы из тех соображений, что любые позитивные сдвиги (при достаточном умении их идентифицировать и с ними обращаться) можно использовать для оптимизации процесса лечения.

Этим пациентам целесообразно оказание психотерапев-

тической помощи, которая сможет раскрыть многие аспекты оздоровления личности с учетом типологических и социально-психологических характеристик. Ее главная цель - помочь

больному обрести «познание самого себя» и увидеть по-новому свои проблемы.

К ВОПРОСУ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОДИНОЧНЫХ МЕТАСТАЗОВ В ЛЕГКИЕ

Кравчук В.А.

ТГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

Лёгкие играют роль первичного фильтра для тех органов и тканей, из которых венозная кровь поступает непосредственно в систему верхней и нижней полой вены. Для большинства органов брюшной полости (система воротной вены) первичным фильтром является печень. По мнению авторов, из первичных метастазов в один или два ключевых органа вторично происходит отсев опухоли на периферию. Предполагается, что при первом формировании метастаза происходит селекция опухолевых клеток, способных к дальнейшему метастазированию. Лёгочная паренхима является наиболее частой локализацией как солитарных (30,4%), так и множественных метастазов (75,6%) рака.

До недавнего времени показания к удалению метастазов из лёгких были строго ограниченными. Основными требованиями являлось наличие солитарного поражения, отсутствие первичной опухоли и местных рецидивов, длительный безрецидивный период (не менее одного года), динамическое наблюдение за появившемся в лёгком метастазом не менее 3 месяцев. Сегодня показания к активному хирургическому лечению лёгочных метастазов расширились.

За последние 3 года в торакальном отделении выполнено 12 операций по поводу солитарных метастазов в легкие. Мужчины и женщины распределились поровну. Средний возраст составил 47 лет.

По локализации первичного очага: рак толстой кишки 3 случая, рак почки 3 случая, по 1 случаю рак молочной железы, рак

яичника, рак нижней губы (мукоэпидермоидная карцинома), рак шейки матки, рак надпочечника, саркома матки. Гистологическое заключение соответствовало гистологии первичного очага.

Пациентам были проведены следующие операции: Пульмонэктомия - 1, комбинированные резекции - 2, атипические резекции - 2, лобэктомии - 6 (3 верхней доли, 1 средней, 2 нижней), а в 1 случае прецизионная резекция.

Большинство лёгочных метастазов находятся субплевральные и редко поражают долевые лимфатические узлы. Поэтому клиновидная резекция, отступая 5 мм от края опухоли, является адекватным методом. Лобэктомия выполняется большим с большими, центрально расположенными узлами. Пневмонэктомия себя не оправдывает. В большинстве сообщений не отмечена зависимость между видом выполненной операции и выживаемостью. Тем не менее, считается, что выживаемость после лобэктомии выше, чем после экономных резекций. При солитарном метастазе в пределах одной доли лёгкого рекомендуется выполнять лобэктомию. Плоскостные и клиновидные резекции по поводу метастазов в лёгкие должны применяться при наличии нескольких узлов в разных долях лёгкого. При солитарных метастазах они могут применяться у больных с низкими дыхательными резервами.

Таким образом, наша тактика соответствует современным тенденциям в лечении солитарных легочных метастазов.

КЛИНИКО-ГЕНОТИПИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ И ЗНАЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СКРИНИНГЕ, РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ И ПРОФИЛАКТИКЕ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Кайдаров Б.К., Афонин Г.А., Джансугурова Л.Б., Хожяев А.А., Любченко Л.Н.

Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова

Институт общей генетики и цитологии МОН РК

Российский Онкологический Научный Центр им. Н.Н. Блохина РАМН

По данным различных авторов, приблизительно 10% пациентов, у которых развивается колоректальный рак, имеют наследуемую генетическую предрасположенность к этому заболеванию. От 3% до 5% случаев КРР связаны с наследственным неполипозным колоректальным раком (ННКРР, синдром Линча), и еще у 1% пациентов заболевание ассоциировано с семейным аденоматозным полипозом (САП). Около 10% всех случаев РТК являются аутосомно-доминантными заболеваниями. Выяснение молекулярно-генетических основ этих состояний позволяет изучать этиологию и патогенез заболевания, разрабатывать систему ранней диагностики и оптимизации наблюдения, лечения и профилактики с учетом индивидуального генотипа пациента. Важным этапом в постановке генетического диагноза является медико-генетическое консультирование. При этом должны быть уточнены и идентифицированы все случаи заболевания у родственников, возраст начала болезни, наличие первично-множественных опухолей, фенотипические признаки, предшествующие возникновению рака (например, аденомы толстой кишки), специфические синдромальные ассоциации. Подтверждение генетического заключения требует специализированного молекулярно-генетического исследования с целью

выявления герминальных мутаций генов предрасположенности и других значимых молекулярных маркеров.

Показания для углубленного генетического обследования лиц с подозрением на наследственный неполипозный рак толстой кишки были сформулированы как Амстердамские критерии и критерии Бетезды, которые включают следующие клинические признаки: молодой возраст (манифестации заболевания до 50 лет); присутствие у кровных родственников больного (1 и 2 степени родства) злокачественного новообразования толстой кишки и/или других опухолей, ассоциированных с наследственным неполипозным раком толстой кишки (рак яичников, рак эндометрия); первично-множественный характер опухолевого процесса.

Первичная профилактика направлена на выявление герминальных мутаций, определяющих высокий риск развития рака. Показано, что скрининг с целью ранней диагностики на 56% снижает риск развития РТК и на 65% общую смертность среди пациентов с отягощенным онкологическим анамнезом. Ежегодная колоноскопия позволяет выявить локальные опухоли минимальных размеров, что также ведет к снижению смертности. Для пациентов, имеющих «патологический» генотип, рекомендовано диспансерное наблюдение, включающее колоноскопию, на-

чина с 25-30-летнего возраста, и консультацию проктолога. Для женщин обследование должно быть дополнено интравагинальным УЗИ органов малого таза, маммографией, анализом уровня маркера СА-125, консультацией маммолога и гинеколога с целью выявления опухолей женской репродуктивной системы.

Профилактические подходы включают лекарственные и хирургические методы. Из профилактических операций у пациентов с САП используют частичную колэктомию, у пациентов с синдромом Линча – субтотальную колэктомию и двустороннюю сальпингоовариэктомию после окончания периода деторождения. Показатели 5-летней выживаемости у пациентов с ННКРР, согласно данных экспертов ESMO, после выполнения профилактических операций составляют 98%.

Вторичная профилактика опухолей – программа, реализация которой обеспечивается путем скрининга родственников больных и активной диспансеризацией лиц с высоким риском развития рака. Пока это единственный подход для организации и функционирования системы генетической профилактики наследственных форм рака. Это в свою очередь является основной задачей

специализированного медико-генетического консультирования в онкологии. Задача подразделяется на 3 этапа: 1. генетический скрининг (выявление и регистрация онкологическиотягощенных семей); 2. генетическое консультирование (определение риска развития злокачественного заболевания для родственников больного (прогноз для здоровья) и его будущих детей (прогноз для потомства); 3. клинко-генетический мониторинг за состоянием здоровья лиц, отнесенных к контингенту повышенного генетического риска.

В будущем при достижении должного уровня функционирования молекулярно-генетических скрининговых и диагностических мероприятий, не будет необходимости рассчитывать вероятностные риски возникновения опухолей у родственников больных. Определение конкретной мутации конкретного гена в семье позволяет эффективно выявлять лиц, предрасположенных к злокачественным новообразованиям, и проводить раннюю (доклиническую) диагностику с последующим осуществлением соответствующих профилактических мероприятий.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГЛОТКИ

Медеуов А.Д.

*Медицинский Центр Западно-Казахстанского государственного
медицинского университета имени М. Оспанова*

Установление морфологической структуры опухоли является решающим этапом диагностики, так как определяет выбор метода лечения. Особое значение вопрос установления морфологии опухоли приобретает в условиях поликлиники, куда обращается основная масса больных, и где диагноз должен быть поставлен в максимально сжатые сроки и начато адекватное лечение.

Цель исследования: провести анализ клиники и морфологической структуры злокачественных опухолей глотки.

Материал и методы исследования: проанализировано 398 случаев злокачественных опухолей глотки (98- носоглотки, 117- ротоглотки, 183- гортаноглотки).

Результаты: распознаваемость злокачественных опухолей глотки в неспециализированных лечебных учреждениях низка и составляет всего 27%. В связи с этим 76% больных поступают на лечение при Т3 –Т4 местного процесса с регионарными, а иногда и отдаленными метастазами. Применительно к нашим локализациям это представлено следующим образом: носоглотка- 95,92%, ротоглотка- 59,83% и гортаноглотка- 96,18%. Метастазы в регионарные лимфатические узлы определялись соответственно в 76,59%- 80,09%- 57,38% случаев. Возраст больных колебался от 9 до 92 лет, средний возраст составил $50,3 \pm 1,2$ года.

Причинами поздней диагностики являются: сходство клинических проявлений опухолей глотки с неопухолевыми поражениями, неполный и невнимательный осмотр ЛОР – органов, неиспользование всего комплекса диагностических

мероприятий.

Злокачественные опухоли глотки в 84,6% имеют клинические проявления, указывающие на поражение ЛОР - органов. При опухолях с локализацией в ротоглотке в 82% отмечается нарастающая дисфагия, при поражении носоглотки наблюдается раннее появление «носовых» (40%) и «ушных» (26,1%) симптомов, а при поражении гортаноглотки – в 85%- «дисфагия» и в 10% - «дисфония».

При небольших злокачественных опухолях глотки (I-II стадии) визуально определяется изъязвление (32%), неровность, шероховатость, выбухание слизистой, экзофитное образование в виде гиперплазии лимфоидной ткани (68%).

Многокомпонентный тканевый состав глотки обуславливает возможность развития в них гистологически различных злокачественных опухолей: опухоли эпителиального происхождения составили 63,3%, лимфорегикулярного – 27,4% и другого генеза – 9,3%.

Сочетание субъективных и объективных признаков позволяет у большинства больных заподозрить новообразование глотки.

Выводы: результаты проведенной работы показали необходимость важности разработки вопросов раннего выявления и организации своевременной диагностики злокачественных опухолей глоточного кольца. От выполнения этого пункта, одной из онкологических доктрин, зависят эффективность лечения и судьба конкретного больного.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ОНКОЛОГИИ*Афонин Г.А., Вайсман М.А., Рудой С.М.**Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова
Московская Медицинская Академия им. И.М.Сеченова*

В последние годы понятие «качество жизни» получило широкое распространение в здравоохранении в целом и в различных областях онкологии, так как позволяет оценить уровень физического, психологического, эмоционального и социального состояния пациента, на основании объективных клинических данных и его собственного субъективного восприятия. Оценка качества жизни связанного со здоровьем пациента (КЖСЗ) в ходе рандомизированных контролируемых клинических исследований проводится на протяжении последних десяти лет и сходна с изучением классических клинических показателей, таких как выживаемость и анализ эффективности лечения.

Не смотря на то, что проблема КЖСЗ в настоящее время относительно хорошо изучена в клинических исследованиях, практические врачи по-разному относятся к возможностям использования данных о КЖСЗ в клинической практике. По-разному врачи оценивают и целесообразность выявления психосоциальной информации о пациентах применительно к эмоциональным и физическим нуждам больных. Рутинное использование оценки КЖСЗ в процессе лечения онкологических больных может помочь онкологам обнаруживать конкретные симптомы, психологические и функциональные проблемы, контролировать заболевание на протяжении времени до прогрессирования заболевания и/или ответ на проводимую терапию. Это будет способствовать также и улучшению процесса общения пациента с врачом. К сожалению, не смотря на положительные стороны учета вопросов качества жизни в онкологической клинике, потенциальная польза этих подходов, как и осознание перспектив на будущее до сих пор не были полностью реализованы. КЖСЗ остается все еще в большей степени областью теоретических исследований.

Практические сложности, затрудняющие процесс внедрения системы оценки КЖСЗ в практическое здравоохранение – это необходимость сбора и быстрой обработки большого объема данных и предоставление результатов онкологам (и через них – государственным органам) в реальном времени. Указанные сложности в настоящее время практически решены с внедрением компьютеризации и информационных технологий. Дальнейшая работа должна проводиться по развитию систем хранения, передачи и архивирования информации о КЖСЗ как части электронного банка данных региональных и национальных органов управления здравоохранением.

Методологические и концептуальные трудности связаны и с проблемой экстраполяции информации, полученной в ходе РКИ на группы других пациентов, правомочностью использования инструментов сбора и обработки массивов информации для применения у отдельного больного. Нет полной определенности и в том, как интерпретировать результаты: каково клиническое значение масштабов и различий (и ошибок репрезентативности), выявленных в ходе проведения рандомизированных контролируемых исследований.

Учитывая актуальность проблемы качества жизни, ожидается, что оценка КЖСЗ станет более распространенной в условиях клиники, а знакомство с достижениями этой области общественного здоровья будет осуществляться посредством и индивидуального и коллективного врачебного опыта. Необходима дальнейшая работа для развития обучающих программ для практических врачей и профессионалов здравоохранения в области вопросов качества жизни и для активного внедрения этого подхода в клиническую практику.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕПАРАТА «РАСТВОР НАТРИЯ ПЕРТЕХНЕТАТА 99mTc» ИЗ ГЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА, ПРОИЗВОДСТВА ИЯФ НЯЦ РК*Тажединов И.Т., Хан О.Г., Кайназаров Ч., Адилбай Д. Г., Джарбусынова Г.Б.,
Сактаганов М.И., Барсов С.В., Шатковская О.В., Чакрова Е.Т., Банных В.И.**Казахский НИИ онкологии и радиологии, Городской онкологический диспансер г. Аматы,
Институт ядерной физики НЯЦ РК, Алматы, Казахстан*

Клинические исследования проведены генератора 99mTc, производства ИЯФ НЯЦ РК с рабочим названием «Раствор натрия пертехнетата 99mTc» из переносного гель-генератора 99mTc.

Исследования проводились на гамма-камере PHILIPS FORTE. Проведены клинические радионуклидные исследования с 99mTc-пертехнетатом от переносного (испытываемого) и стационарного (референтного) генератора сделан сравнительный анализ качества визуализации щитовидной железы, печени, почек и скелета по 5 больных с испытываемым и референтным препаратами. Всем пациентам препараты вводились внутривенно в общепринятых дозах.

Продуктивность, т. е. выход 99mTc-пертехнетата от переносного «Гель-генератора 99mTc» в течении всего срока эксплуатации – две недели, стабильна и соответствует теоретическому расчету. «Раствор натрия пертехнетата 99mTc» из переносного гель-генератора 99mTc комплектован и сопровождающие технические документы позволяют получить полную информацию, необходимую для монтажа, эксплуатации и демонтажа генератора. Проведенный дозиметрический контроль и хронометраж показали радиационную безопасность генератора в эксплуатации.

Радиофармпрепараты, полученные с помощью метки 99mTc,

от переносного гель генератора сохраняют свои специфические свойства – тропность к органам и системам. Сцинтиграфия щитовидной железы с 99mTc-пертехнетатом, а также сцинтиграфия печени с 99mTc-технефитом, динамическая сцинтиграфия почек с 99mTc-пентатехом, сцинтиграфия скелета с 99mTc-технефором показали высокую информативность результатов диагностических исследований, что свидетельствует о высокой чистоте «Раствор натрия пертехнетата 99mTc» из переносного гель-генератора 99mTc.

Динамическое наблюдение во время исследования и в течение двух часов после, показало отсутствие разницы в поведении между испытываемыми и контрольными пациентами. Следовательно, «Раствор натрия пертехнетата 99mTc» из переносного гель-генератора 99mTc не обладает свойствами химотоксичности и радиотоксичности, а также какие-либо почечные эффекты.

Успешное клиническое испытание позволяет «Раствор натрия пертехнетата 99mTc» из переносного гель-генератора 99mTc, производства ИЯФ НЯЦ РК рекомендовать к серийному выпуску для широкого применения в клинической радионуклидной диагностике. Выпуск отечественного «Раствор натрия пертехнетата 99mTc» из переносного гель-генератора 99mTc

будет новым толчком в развитии ядерной медицины Республики и будет способствовать расширению применения в клинической

медицине столь необходимого метода, как радионуклидная диагностика.

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕПАРАТА «ДТПА-99mTc – РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИИ. «ВНУТРИВЕННО», ПРОИЗВОДСТВА ИЯФ НЯЦ РК

*Тажединов И.Т., Нурғалиев Н.С., Косанов М.С.,
Кенжебаев Б.Ж., Онгарбаев Б.Т., Чакрова Е.Т., Банных В.И.
Казахский НИИ онкологии и радиологии,
Институт ядерной физики НЯЦ РК, Алматы, Казахстан*

Проведены клинические испытания препарата «ДТПА-99mTc, реагент», разработанный в ИЯФ НЯЦ РК, предназначенный для медицинских диагностических исследований. Кальцийтринатрий диэтилентриаминпентаацетат с наиболее распространенным названием 99mTc-ДТПА является радиофармацевтическим препаратом (РФП), широко применяемым в клинической радионуклидной диагностике заболевания почек и мочевых путей.

Пациенты с нормальными показателями динамической сцинтиграфии составили 1-группу (8 пациентов) и с изменениями секреторно-экскреторной функции почек – 2-группу (7 больных). По 5 пациентов с нормальными показателями составили 3-группу и с изменениями секреторно-экскреторной функции почек – 4-группу, обследованные с референтным препаратом «Пентатех, 99mTc, реагент для получения» (Узбекистан). «ДТПА-99mTc, реагент» и «Пентатех, 99mTc, реагент для получения» являются препаратами одинаковой химической структуры с разными коммерческими названиями.

Динамическая сцинтиграфия проводилась в гамма-камере PHILIPS FORTE в течение 31 минуты с внутривенным введением с 150-200 МБк «ДТПА-99mTc, реагент» или референтным препаратом «Пентатех, 99mTc, реагент для получения». У всех пациентов непосредственно во время введения РФП и на протяжении исследования, а также в ближайшие 2 часа никаких изменений в состоянии и внешних проявлений болезни не наблюдалось.

Анализ количественных и качественных параметров ре-

зультатов динамической сцинтиграфии показал, что «ДТПА-99mTc, реагент» секретируется почками и выводится из почек (экскретируется) в мочевой пузырь с мочой. Тем самым, данный препарат позволил по кривой и показателям в цифрах динамической сцинтиграфии оценить секреторно-экскреторную функцию почек у пациентов; на фоне силуэта тела пациента визуализировать почки и мочевой пузырь. Динамическая сцинтиграфия показала, что РФП «ДТПА-99mTc, реагент» физиологически корректен, отражает секреторную и экскреторную фазы функции почек.

Результаты клинических испытаний показали, что «ДТПА-99mTc, реагент», производства ИЯФ НЯЦ РК, можно рекомендовать к серийному выпуску для широкого применения в клинической радионуклидной диагностике.

Клиническое испытание показало, что «ДТПА-99mTc, реагент», производства ИЯФ НЯЦ РК, специфичный препарат в отрошении мочеобразования и мочевыделения. «ДТПА-99mTc, реагент» не радио- и не химиотоксичен. Испытуемый «ДТПА-99mTc, реагент» соответствовал по всем параметрам контрольному основному химическому веществу – кальцийтринатриевой соли диэтилентриаминпентауксусной кислоты – с коммерческим названием «Пентатех, 99mTc, реагент» производства «Радиопрепарат» (Узбекистан, Ташкент), широко применяемый в клинической радионуклидной диагностике. Успешное клиническое испытание позволяет данный препарат рекомендовать к серийному выпуску.

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕПАРАТА «НАТРИЯ -О-ЙОДГИППУРАТ,131I РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ» (ЛЕКРСТВЕННАЯ ФОРМА: РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ), ПРОИЗВОДСТВА ИЯФ НЯЦ РК

*Тажединов И.Т., Нурғалиев Н.С., Косанов М.С., Кенжебаев Б.Ж.,
Онгарбаев Б.Т., Мясцев А.В., Даулбаев С.У., Чумикова В.М.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, Институт ядерной физики НЯЦ
РК, Алматы, Казахстан*

Клиническим исследованиям подвергся препарат «Натрия о-йодгиппурат,131I раствор для инъекций», разработанный в ИЯФ НЯЦ РК, предназначенный для медицинских исследований пациентов в диагностике заболевания почек и мочевых путей. Исторический его аналог 131I-гипуран является одним из первых радиофармпрепаратов, примененный в клинической радионуклидной диагностике патологии почек и мочевых путей.

Динамическая сцинтиграфия проводилась на гамма-камере PHILIPS FORTE в течение 31 минуты с внутривенным введением 7-16 МБк «Натрия о-йодгиппурат,131I раствор для инъекций» или с 150-200 МБк референтным препаратом «Пентатех, 99mTc, реагент для получения». У всех пациентов непосредственно вовремя введения препарата и на протяжении исследования, а также в ближайшие 2 часа никаких изменений в состоянии и внешних клинических проявлений болезни не наблюдалось.

С нормальными показателями пациенты составили 1-группу (8 пациентов) и с изменениями секреторно-экскреторной функции почек – 2-группу (7 больных). По 5 пациентов с нормальными показателями составили 3-группу и с изменениями секреторно-экскреторной функции почек – 4-группу, обследованные с референтным препаратом «Пентатех, 99mTc, реагент для получения».

У двух групп пациентов (1 и 3 группы) с нормальными диагностическими показателями, параллельно обследованных с «Натрий о-йодгиппурат,131I раствор для инъекций» и «Пентатех, 99mTc, реагент для получения», коэффициент корреляции был высоким и составил 0,9. Коэффициент корреляции между 2-ым и 4-ым группами с изменениями в показателях динамической сцинтиграфии был достаточно высокими и составил 0,8. Следовательно, испытуемый РФП в оценке секреторно-экскреторной функции почек у пациентов не отличался от референтного препарата.

Анализ результатов динамической сцинтиграфии показал, что «Натрия о-йодгиппурат, 131I раствор для инъекций», разработанный в ИЯФ НЯЦ РК, секретируется почками и выводится из почек (экскретируется) в мочевой пузырь с мочой. Тем самым, данный препарат позволил по кривой динамической сцинтиграфии оценить секреторно-экскреторную функцию почек у пациентов, визуализировать почки и мочевой пузырь. Динамическая сцинтиграфия показала, что РФП «Натрия о-йодгиппурат, 131I раствор для инъекций» разработанного в ИЯФ НЯЦ РК, предназначенного для медицинских диагности-

ческих исследований, физиологически корректен, отражает секреторную и экскреторную фазы функции почек.

Фармакодинамика испытуемого и референтного препаратов идентичны, так как оба вещества выводятся канальцевой секрецией.

Результаты клинических испытаний показали, что «Натрия о-йодгиппурат, 131I раствор для инъекций» (лекарственная форма: раствор для инъекций), производства ИЯФ НЯЦ РК, можно рекомендовать к серийному выпуску.

К МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ЛЕГКОГО

Мухаметгалиев Н.А.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, Республика Казахстан

Рак легкого, наиболее распространенная форма злокачественных новообразований, как во всем мире, так и в Казахстане.

Нами проанализировано 131 случай с новообразованием легкого верифицированного цитологически. Средний возраст пациентов – 58,3 лет, мужчины составили 76%. Материал для цитологического исследования получен бронхоскопически в 45%, методом трансторакальной пункции 35%, операционный материал 20%.

70% злокачественных новообразований легкого составил плоскоклеточный рак, 17% аденокарциномы, 9,0% недифференцированный рак, метастазы рака других локализаций 4% случаев. Чаще процесс наблюдался в правом легком, и чаще поражалась верхняя доля.

Сложность цитологической диагностики опухолей отчасти связана с тем, что цитолог имеет дело с раздробленным набором частей какого-то целого. Так, наряду с типичными клеточными критериями цитологической диагностики, многие цитологические феномены остаются без объяснений. Какое место занимают та или иная клетка (клеточный элемент), или

группа клеток (структура) в гистологическом препарате?

В этом смысле представляется важным сопоставление цитологической картины с гистологической. Но прежде нужно решить вопрос: возможно ли найти гистологический субстрат цитологического феномена?

Проведенное предварительное исследование было направлено на обнаружение общих признаков в цитологическом и гистологическом препарате.

При сопоставлении цитогрaмм и гистологии материала от пациентов с плоскоклеточным раком легкого обнаружено, что в каждом случае цитологический материал отражает характерное гистологическое строение опухоли, что выражается преимущественно в структуре комплексов клеток. Последние часто не принимаются в расчет, в виду очевидности лишь только клеточных признаков злокачественности и тканевой принадлежности.

Таким образом, для повышения информативности и объективизации цитологического материала необходимы прямые сопоставления с гистологическим строением опухоли.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В МОНИТОРИНГЕ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Тельгузиева Ж.А., Байназарова А.А., Жолдыбай Ж.Ж., Ахметова Г.С., Абенова М.Т.

Казахский НИИ онкологии и радиологии (г.Алматы)

Центральная клиническая больница Управления делами Президента РК (г.Алматы)

Городской онкологический диспансер г.Астаны

В последнее время перспективным способом повышения эффективности сочетанной лучевой терапии (СЛТ) рака шейки матки (РШМ) является совместное использование химиолучевой терапии (ХЛТ). Большие надежды возлагаются на применение химиопрепаратов в метродном режиме.

В работе представлены непосредственные результаты лечения 116 больных РШМ, получивших лечение в КазНИИ онкологии и радиологии в 2009 - 2011 гг. по следующим схемам: основная группа (n-54) - СЛТ на фоне метродной химиотерапии с цисплатином (из расчета 40мг/м²) на протяжении 5 недель облучения (1,8,15,22,29 дни СЛТ); контрольная группа (n-62) - радикальный курс СЛТ по стандартной методике. В изучаемых группах больных РШМ средняя доза СЛТ составила: основная группа - СОД (т.А) - 73,6Гр, СОД (т.В) - 57,8Гр (с разовой дозой цисплатина - 50мг, а курсовой - 257,4мг); контрольная группа - СОД (т.А) - 74,3Гр, СОД (т.В) - 66,2Гр.

Эффективность проводимого лечения оценивалась в динамике (до начала лечения, при дозе облучения 20Гр и после завершения основной терапии) при помощи лучевых методов диагностики малого таза – комплекс специальных методик УЗИ (режим В-mode и второй тканевой гармоник, волюметрия, амплитудная гистогарфия, 3D-режим, цветовой и энергетический доплер) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Было использовано УЗ-оборудование – SDU-1200, «Viking 2400», «GE Logic 7», а МРТ выполнено на томографе

«GE Signa Profile» с предварительным внутривенным контрастированием («Омнискан»).

В процессе лечения положительная динамика наблюдалась у всех 116 больных РШМ, однако степень регрессии первичной опухоли была более выраженной в основной группе больных, чем в контрольной группе. В основной группе регрессия исходной опухоли шейки матки отмечалась (в среднем) с объема: 1) по данным УЗИ - с 80,9см³ до 43,6см³ (20Гр) и до 4,7см³ (после ХЛТ); 2) по данным МРТ - с 88,4см³ до 53,0см³ (20Гр) и до 6,3см³ (после ХЛТ). В контрольной группе уменьшение первичной опухоли отмечалось с объема: 1) по данным УЗИ - с 63,1см³ до 36,4см³ (20Гр) и до 11,9см³ (после СЛТ); 2) по данным МРТ - с 72,2см³ до 42,0см³ (20Гр) и до 13,1см³ (после СЛТ). При сравнении данных УЗИ и МРТ наблюдается совпадение их результатов, что проявлено в одинаковой тенденции регрессии злокачественного процесса, т.е. по мере лизиса опухоли, подтвержденных УЗ-данными наблюдается аналогичная положительная МРТ-динамика. Причем степень и характер деструктивных изменений УЗ-параметров опухоли соответствует выраженности изменений ее МРТ-характеристик. После реализации всего объема лечения полный клинический ответ был достигнут в основной группе у 81,8±5,2% больных, что оказалось в 1,5 раза выше показателя контрольной группы (54,8±6,3%).

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ

Югай Т.П.

КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан

Основным фактором, влияющим на уровень креатинина в дренажной жидкости, является концентрация этого соединения в сыворотке крови. Уровень креатинина в моче почти в 100 раз выше уровня его в сыворотке крови. Взяв за основу эти соотношения, предложен способ диагностики повреждения мочевых путей во время оперативных вмешательств и в послеоперационном периоде путем определения концентрации креатинина в дренажной жидкости из брюшной полости и по его соотношению к концентрации креатинина в сыворотке крови судят о наличии или отсутствии повреждений мочевых путей. Наряду с современными методами диагностики, такими как ультразвуковое, рентгенологическое исследования, магнитно-резонансная томография, данный способ имеет ряд преимуществ. Он не инвазивный и безвредный, т.к. исследуется уже выделенная дренажная жидкость и нет опасности занесения инфекции, для выполнения не требует дорогостоящего оборудования, доступен для любой лаборатории. Используя данный способ для динамики наблюдения, можно своевременно уловить момент нарушения целостности мочевых путей или несостоятельность швов, тем самым предотвратить грозные осложнения, такие как мочевые затеки и перитонит.

Задачи исследования: создание информативного и своевременного способа диагностики повреждения мочевых путей.

Материалы и методы исследования: В исследование включены 70 пациентов, у которых были диагностированы опухоли в брюшной полости различной локализации и им было проведено оперативное вмешательство. Уровень креатинина в дренажной жидкости из брюшной полости и в сыворотке крови определяла по общепринятой методике, основанной на реакции Яффе с депротеинизацией. Использовала наборы реагентов «Креатинин-БМ» фирмы ТОО «Бион-Мед».

Исследования выполняла на спектрофотометре PD-303 фирмы APEL Японии. Дренажную жидкость забирали 1-4 раза в день до удаления дренажей. Одновременно исследовали сыворотку крови, полученную при стандартной процедуре венопункции кубитальной вены.

Результаты: Из 70 пациентов, у 45 был диагностирован рак мочевого пузыря, произведена операция цистпростатэктомия с наложением двухсторонней уретерокутанеостомии. В случаях, когда послеоперационный период протекал гладко без осложнений, соотношение уровня креатинина в сыворотке крови дренажной жидкости из брюшной полости было одинаковым или в дренажной жидкости ниже или выше, чем в крови в пределах до ± 40 мкмоль/л. Величина диуреза составляет от 1,0 до 3,0 литров, а количество дренажной жидкости 50-300 мл. Если происходит разрыв мочевых путей или несостоятельность швов то, вследствие проникновения мочи в брюшную полость, наблюдаются следующие лабораторные показатели: уровень креатинина в дренажной жидкости из брюшной полости превышает уровень креатинина в сыворотке крови в 2,7 и более раз. Одновременно уменьшается диурез и увеличивается количество дренажной жидкости. Соотношение концентрации креатинина в дренажной жидкости и в сыворотке крови используется для дифференциальной диагностики лимфореей у пациенток раком шейки матки, которым была проведена операция Вертейма.

Выводы: Концентрация креатинина в дренажной жидкости из брюшной полости по отношению к таковой в сыворотке крови изменяется при повреждении мочевых путей. Определение концентрации креатинина в дренажной жидкости является неинвазивным и информативным методом исследования, повышающим качество лабораторного мониторинга. Инновационный патент №22861 от 15.07.2009 г.

ЛЕЧЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ

Аладов В.Н.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

За 2010-2011г на лечебно-консультативной комиссии при Павлодарском областном онкологическом диспансере (ПООД) были приняты 8 беременных женщин, состоящих на учёте. Все женщины были направлены гинекологами женской консультации для определения дальнейшей тактики ведения беременных. 5 женщин стоят на учете в ПООД более 5 лет с лимфопрлиферативным заболеванием. 3 женщины – более 3 лет с заболеванием молочной железы. Всем женщинам были разъяснены возможные риски, возможность прогрессирования заболевания. 6 женщин отказались прерывать беременность.

Уровень заболеваемости злокачественными опухолями, которые диагностируются у беременных женщин, в развитых странах составляет 1 на 1000 случаев беременности. Наиболее распространенными формами рака, выявляемыми у беременных женщин, являются рак шейки матки, рак молочной железы, меланома, различные виды лимфом и острые лейкозы. Противоречивые данные существуют относительно диагностики гормонально зависимого рака молочной железы у беременных с использованием иммуногистохимического определения уровня рецепторов эстрогенов и прогестеронов опухоли. Краеугольным камнем для определения стадии заболевания являются рентгенография грудной клетки и маммография, которые выполняются с использованием экранной защиты брюшной полости, а также ультразвуковое исследование. Рутинное использование МРТ исследования

не рекомендовано, т.к. гадолиний проникает через плаценту и индуцирует мальформации. Следует избегать назначения беременным компьютерной томографии или радиоизотопных исследований. Ионизирующее излучение и цитотоксические препараты могут оказать мута-генное, тератогенное и канцерогенное воздействие на эмбрион, в зависимости от дозы, природы составляющих элементов, области лечения и недели беременности.

Не следует применять антинеопластические препараты в первом триместре (период развития органов у эмбриона), но их назначение может быть оправданно с учетом невысокого риска для матери и плода во втором и третьем триместрах беременности.

Оптимальная стратегия лечения должна выбираться совместно командой медиков, пациентом и семьей, и должна зависеть от стадии беременности, природы и стадии онкологического заболевания, существующих вариантов лечения и желаний самого пациента. Команда медицинских специалистов должна включать: акушера, неонатолога, онколога, хирурга и психолога.

Прерывание беременности рекомендуется в случае назначения химиотерапии или лучевой терапии в первом триместре беременности, при необходимости выполнения радикальной гинекологической операции, плохом прогнозе для выживаемости матери. Нет никаких данных, подтверждающих, что прерывание беременности меняет биологические

характеристики опухоли или прогноз пациента при назначении соответствующей противоопухолевой терапии.

Операция - это главная основа лечения солидных опухолей и беременность не является противопоказанием для выполнения хирургического вмешательства. С современной хирургической и анестезиологической техникой материнская смертность незначительна.

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Аладов В.Н.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

В Павлодарской области ежегодно берется на учет в онкологическом диспансере 420-450 больных с запущенной формой онкологического заболевания, которые нуждаются в адекватном обезболивании. Непосредственное лечение хронического болевого синдрома у онкологических больных, подлежащих только симптоматическому лечению, осуществляет участковый врач-терапевт. Консультативно-методическую помощь участковому врачу-терапевту при ведении хронического болевого синдрома осуществляет районный онколог по месту жительства, а также врачи хосписов. Бригады скорой помощи осуществляют выполнение врачебных назначений по купированию болевого синдрома у онкологических больных в ночное время, а также самостоятельно назначают лечение при некупируемом болевом синдроме. Около 80% больных с распространенным опухолевым процессом страдают от боли. В 2005 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указала, что одной из основных составляющих противораковой борьбы в любой стране, независимо от экономических ресурсов, должна быть организация "комплексной паллиативной помощи, обеспечивающей ослабление боли", "разработка минимальных национальных стандартов устранения боли", "обеспечение наличия и доступности опиатов, особенно морфина для перорального приема". Болевой синдром может быть эффективно купирован у 90% больных раком, а в 10% случаев может быть снижена интенсивность болевого синдрома.

На первом этапе лечения болевого синдрома у онкологических больных следует исключить боли, связанные с неотложным состоянием: патологическим переломом, метастатическим поражением головного мозга, перфорацией полого органа.

Выполнение операции в первом триместре беременности не вызывает увеличения врожденных дефектов, но возрастает риск преждевременных родов. Поэтому, в тех случаях, когда это возможно, хирургическое лечение должно быть отложено до второго триместра, когда риск для плода является самым низким.

При проведении обезболивающей терапии необходимо соблюдать следующие основные принципы:

1. Дозу анальгетиков подбирают индивидуально в зависимости от интенсивности и характера болевого синдрома, добиваясь устранения или значительного облегчения боли за 2 - 3 дня.

2. Назначают анальгетики регулярно строго "по часам" (круглосуточно), а не "по требованию", т.е. очередную дозу препарата больной должен получать до прекращения действия предыдущей дозы.

3. Анальгетики применяют по "восходящей", т.е. от максимальной дозы слабейшего к минимальной дозе сильнейшего препарата.

4. По возможности избегать инъекционного введения анальгетиков, максимально использовать возможности перорального, трансректального и трансдермального путей введения препаратов.

5. Ожидаемая продолжительность жизни больного не должна влиять на выбор анальгетика.

6. На каждом этапе лечения прежде, чем увеличивать дозу анальгетика, необходимо использовать ко-анальгетики.

7. Препараты морфия можно безопасно вводить в возрастающих количествах до тех пор, пока не будет получено адекватное обезболивание. "Правильная доза" - это та доза морфина, которая эффективно облегчает боль до тех пор, пока вызываемые им побочные реакции переносятся больным. Какой-либо стандартной дозы морфина не существует.

8. Побочные эффекты анальгетиков должны предупреждаться и в случаях их возникновения и адекватно лечиться.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ТОЛСТОКИШЕЧНОГО АНАСТОМОЗА

Садыков М.С.

Казахский НИИ онкологии и радиологии

Диагностика несостоятельности швов анастомоза достаточно сложна, и ограничиваться только клиническими методами недостаточно, но и в большинстве случаев невозможно. Лучевая диагностика, в частности, рентгенологическая имеет первостепенное значение при выявлении данного осложнения.

Наиболее опасным осложнением после операций, проведенных по поводу злокачественных опухолей, в раннем послеоперационном периоде, является несостоятельность швов толстокишечного анастомоза.

Исследование начинали с обзорных рентгенограмм брюшной полости в горизонтальном положении. При этом получить прямые признаки несостоятельности швов анастомоза, практически невозможно, а имеющиеся косвенные симптомы, выразившиеся в парезе кишечника, наводили на мысль о возможности данного осложнения. Для ее диагностики необходим и обязателен рентгенконтрастный метод исследования желудочно-кишечного тракта. При пероральном и ретроградном введении контрастного вещества, предположение отдавали использованию не жидкой бариевой взвеси,

а применению водорастворимого контрастного препарата (Ультравист-300), который дает более четкую информацию при несостоятельности швов различных анастомозов. Выявлялись прямые рентгенологические признаки несостоятельности швов толстокишечных анастомозов или ушитой культи толстой кишки. При этом отмечали затекание контрастного вещества за контуры тонко-толстокишечного, либо толсто-толстокишечного анастомоза.

Рентгеноконтрастные исследования не заменимы в выявлении поздних послеоперационных осложнений у больных, оперированных по поводу различных новообразований толстой кишки: рубцовые стриктуры в области наложенных анастомозов и соустьев, пресакральные абсцессы, сдавления мочеточника рубцовыми тканями, послеоперационные свищи, подтвержденные при релапаротомии. Своевременно, проведенная релапаротомия позволила устранить описанные осложнения.

Такие исследования сложны в самой процедуре выполнения, но они дают ценную информацию о виде осложнения и локализации, что позволяет клиницистам решить вопрос

не только о целесообразности релапоротомии, но и выбора объема повторного оперативного вмешательства. Необходимо, обратить внимание еще на один рентгенологический признак, появление газа в брюшной полости и забрюшинном пространстве (серповидная полоска просветления под куполом диафрагмы).

Что касается ультразвуковой диагностики послеоперационных осложнений, то она имеет определенную ценность, и может многократно выполняться без всяких воздействий на

больного. Диагностическая информативность УЗИ несколько уступает рентгенодиагностическому методу при выявлении наличия различного рода кишечных свищей. Последние, практически, невозможно определить с помощью ультразвукового исследования.

Таким образом, лучевые методы диагностики различных осложнений в послеоперационном периоде являются достаточно информативными и требуют своего дальнейшего совершенствования.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ ГЛОТКИ

Майемер Д.Б.

*Медицинский Центр Западно-Казахстанского государственного
медицинского университета имени М. Оспанова*

Цель исследования: провести анализ информативности лучевых методов исследования (рентгенологического, компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и ультразвукового (УЗИ)) в диагностике опухолей глотки.

Материал и методы исследования: проанализировано 398 случаев злокачественных опухолей глотки (98- носоглотки, 117- ротоглотки, 183- гортаноглотки).

Результаты: рентгенологическое исследование ротоглотки рекомендовано для объективизации поражения корня языка и задней стенки глотки. КТ- для опухолей парафарингеального пространства. Рентгенологическая семиотика при опухолях носоглотки зависит от размеров патологического очага и степени экспансии в окружающие ткани, что не исключено и при доброкачественных процессах. Информативны томограммы. Эпифарингография позволяет обнаружить дефект наполнения. КТ информативна для определения преимущественной стороны поражения, тотального поражения всего просвета носоглотки, заинтересованности основной пазухи, врастания в крылочелюстную ямку и задние отделы полости носа, но не всегда позволяет оценить вероятность деструктивных изменений.

Из результатов рентгенологического исследования у 45 больных опухолями гортаноглотки наиболее информативным оказались результаты прямых томограмм: размытость тени черпалонадгортанной складки отмечена у 28 больных, и у них же имело место сужение воздушного просвета грушевид-

ного синуса с пораженной стороны, которое проявлялось их асимметричностью при сравнении двух сторон. У 12 больных было проведено контрастированное исследование бариевой взвесью с проведением функциональных проб; у 7 выявлена асимметрия в заполняемости грушевидных синусов и у 5 отмечено поперхивание, у 3 – задержка контраста в обоих грушевидных синусах. КТ позволяет оценить характер роста новообразования, его величину, плотность, взаимосвязь с окружающими органами и тканями. С контрастированием и без обычные методы рентгенологической диагностики дают более четкую информацию об объемных процессах гортаноглотки по сравнению с КТ.

При анализе результатов УЗИ (159 больных – 40%) в диагностике метастатического поражения лимфатических узлов шеи выявлено: в 84,8% случаях обнаружено увеличение лимфатических узлов шеи, при этом в 75,8% наблюдений изменение узлов трактовались правильно; распознаны 90,9% лимфатических узлов шеи с гиперпластическим и метастатическим поражением, расположенные в поверхностных отделах шеи. При поражении глубоких лимфатических узлов шеи информативность УЗИ снижается до 63,8%.

Заключение: в диагностике опухолей глотки рентгенологический, КТ и МРТ используются для уточнения распространенности и локализации опухоли. УЗИ для распознавания метастазов в лимфатических узлах шеи и для получения дополнительной информации о взаимоотношении опухоли с магистральными сосудами.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ ЖКТ

Мухамеджанов К.Х.

Алматы АГИУВ

В течении многих десятилетий для исследований органов брюшной полости использовались лишь обзорные снимки, контрастирование барием желудка и кишки и холецистография. Возможности оценки печени, поджелудочной железы и желчных протоков, внеорганных опухолей были ограниченными. С другой стороны, рентгеноскопия и рентгенография органов пищеварительного тракта остаются методами комплексного исследования этих органов.

Технический прогресс неизменно изменили абдоминальную радиологию. В первую очередь, это касается исследования паренхиматозных органов брюшной полости, где ведущую роль на сегодняшний день занимают ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Применение эндоскопических датчиков для внутриполостных исследований существенно расширяет возможности этого метода в сложных случаях. В настоящее время основной парк КТ составляют приборы с 16-64 рядами детекторов, у которых время оборота трубки составляет всего 320-350 мс, а толщина среза – 0,5 с.

Различные виды патологии пищевода (грыжи пищевод-

ного отверстия диафрагмы, опухоли, расширения) хорошо выявляются с помощью КТ или МРТ. КТ позволяет выявлять распространение опухолей за пределы пищевода. Для детальной оценки стенок пищевода используют эндоскопическое УЗИ. Рентгенография и рентгеноскопия остаются важными методами диагностики доброкачественных и злокачественных опухолей желудка. В настоящее время все чаще и чаще опухоли желудка впервые выявляют при проведении КТ органов брюшной полости. Для исследований тонкой кишки используют пассажа по ней бариевой взвеси или водорастворимого контрастного средства. В последнее время большое внимание привлекли такие методики, как КТ- или МР-энтерография, при которых возможно построение трехмерных изображений органа и построение изображений просвета кишки в эндоскопическом режиме. Одно из частых показаний к ирригоскопии – диагностика рака толстой кишки, полипов и дивертикулов. МСКТ и в особенности методика КТ-колонографии могут служить альтернативой ирригоскопии в скрининге и диагностике рака толстой кишки. КТ позволяет лучше видеть изменения кишечной стенки и стадировать заболевание. Лучевая диагно-

стика заболеваний печени сегодня в основном основывается на использовании УЗИ, КТ и МРТ. К очаговым поражениям печени относятся доброкачественные и злокачественные опухоли печени и метастазы органических опухолей в печень. КТ,

МРТ облегчают диагностику опухолевого поражения желчных протоков, поджелудочной железы, селезенки. Выбор метода лучевой диагностики зависит от характера предполагаемого заболевания, остроты процесса и клиники.

МЕТАСТАЗЫ БЕЗ ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА

Аладов В.Н.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

По данным Павлодарского областного онкологического диспансера, метастазы злокачественных новообразований без выявленного первичного очага ежегодно выявляются у 3 - 4% больных. 50% таких пациентов умирают на первом году жизни. Среди таких пациентов мужчины встречаются несколько чаще, чем женщины; средний возраст составляет 51-52 года. Локализация поражений, распространенность опухолевого процесса, морфологическая структура метастатических опухолей чрезвычайно разнообразны.

В зависимости от локализации и распространенности поражений можно выделить следующие варианты метастазов без выявленного первичного очага: изолированные (единичные или множественные) поражения лимфоузлов в пределах одного коллектора – шейного, подмышечного, пахового, медиастинального, забрюшинного; изолированные (единичные или множественные) поражения органов и тканей – костей, легких, печени, мягких тканей, головного мозга; поражения нескольких коллекторов лимфоузлов; сочетанное поражение лимфоузлов, органов и тканей.

Пациенты с метастазами рака, меланомы, злокачественной опухоли без уточнения гистогенетической принадлежности подлежат дальнейшему обследованию. Установление морфологической структуры метастаза позволяет предположительно определить локализацию первичной опухоли, что значительно облегчает поиск первичного очага. Цитологическое исследование пунктатов метастазов обычно предваряет биопсию. Получение материала для морфологического исследования не представляет трудности при поражении периферических лимфоузлов. При изолированном метастазировании в подмышечные лимфатические узлы наряду с гистологическим исследованием целесообразно изучение рецепторного статуса опухолевой ткани, так как при этой локализации первичный очаг в 60-80% случаев выявляется в молочной железе. Если опухоль положительна по рецепторам эстрогенов и/или прогестерона, специальное лечение может быть дополнено гормонотерапией. В случае поражения медиастинальных или забрюшинных лимфоузлов выполняется чрескожная пункция под контролем УЗИ или КТ. При невозможности морфологического диагноза по биоптатам лимфоузлов показана биопсия в условиях торакоскопии или лапароскопии. Аналогична диагностическая тактика при метастатическом поражении плевры, брюшины, органов грудной, брюшной полости, забрюшинного пространства. При костных метастазах диагностические процедуры предусматривают последовательное выполнение пункции, трепанобиопсии, открытой биопсии пораженной кости. При поиске первичного очага в первую очередь следует обратить внимание на обследование молочных желез, предстательной железы, почек. Также должны быть выполнены бронхоскопия, эзофагогастроскопия, КТ малого таза, брюшной полости и забрюшинного пространства. Как известно, при выявлении метастазов в яичниках чаще всего диагностируется рак желудка, молочной железы или толстой кишки. Выявление первичной опухоли позволяет надеяться на существенное улучшение результатов специального лечения. При изолированных метастазах продолжительность жизни больше, чем при множественных. Сочетанные поражения лимфоузлов и органов сопряжены с наименьшей выживаемостью. Наибольшая продолжительность жизни отмечена при метастазах плоскоклеточного рака и внегонадных герминогенных опухолей; наименьшая – при метастазах аденокарциномы и светлоклеточного рака.

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВНОГО И МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

*Дуненова Г.А., Югай Т.А., Акимжанова С.М., Садыкова Т.Т.,
Косаева Т.Г., Анфиногенова А.Г.*

Городской онкологический диспансер,

*Казахский Национальный Медицинский Университет им.Асфендиярова,
Лечебно-диагностический центр, Алматы, Казахстан*

Рецидивы рака шейки матки (РШМ) после специального лечения чаще возникают через 12-20 месяцев после начала лечения, их частота колеблется от 3,3% до 40% (Козаченко В.П., Кузнецов В.В.). Прогноз у больных с рецидивным раком шейки матки неблагоприятный. Последнее десятилетие изучается использование химиотерапии в паллиативном лечении рецидивного рака шейки матки.

В Городском онкологическом диспансере был проведен анализ 71 случая рецидивного рака шейки матки, возникших за период 2006-2010 гг., после комплексного, комбинированного и сочетано-лучевого лечения. Возраст больных варьировал от 32 до 68 лет, в среднем – 48,5±4,5 лет.

Противорецидивная лучевая терапия проведена 29,6% больным в условиях КазНННОнР. 25,3% больных получили самостоятельную противорецидивную химиотерапию, 59,2% больным химиотерапия использована как компонент комбинированного лечения.

Использовались следующие схемы химиотерапии:

Схема	Число больных
Цисплатин+ фторурацил	19 (38,0%)
Гемзар+ Карбоплатин	13 (26,0%)
Кампто+ Цисплатин	10 (20%)
Цисплатин+ фторурацил+ доксорубин	3 (6,0%)
Карбоплатин+ паклитаксел	5 (10,0%)
Всего	50 (100%)

Оценка лечебного эффекта осуществлялась по шкале ВОЗ после каждого курса химиотерапии и/или после лучевой терапии по данным субъективных жалоб больных, клинического осмотра, УЗИ. Был проведен анализ непосредственного клинического эффекта лечения больных рецидивным раком шейки матки.

Среди больных, получивших противорецидивную химиотерапию с последующей лучевой терапией, отмечается большая часть частичной регрессии рецидивной опухоли – в 20 (47,6%)

случаях, стабилизация – в 9 (21,4%), прогрессирование диагностировано у 13 больных (31,0%). У пациенток после самостоятельных видов лучевой терапии в 7 (33,3%) случаев отмечена частичная регрессия рецидивного опухолевого процесса, стабилизация – у 6 (28,6%) и прогрессирование – у 8 (38,1%).

После самостоятельной химиотерапии, использованной, в основном, у больных с отдаленными метастазами (легкие, печень, надпочечные лимфоузлы), частичная регрессия и стабилизация наступила в 580%. В этой группе отмечен самый высокий удельный вес больных, у которых на фоне

противоопухолевого лечения наблюдалось прогрессирование заболевания - 9 (50%) больных.

Пациентки с подтвержденной регрессией и стабилизацией неопластического процесса отмечали субъективное улучшение самочувствия и снижение интенсивности имеющихся у них симптомов болезни.

Таким образом, применение на первом этапе комбинированного лечения противорецидивной химиотерапии, в сочетании с лучевым компонентом, у больных с рецидивами и метастазами рака шейки матки способствовало их относительной регрессии и повышению качества жизни.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

Тилеген Г.У.

Городской онкологический диспансер, г. Алматы

В настоящее время лапароскопические методы лечения различных патологий внутренних органов становятся все более популярными.

В основу наблюдений входит 65 (100%) анестезиологических пособий, которым выполнены лапароскопические операции.

21 (32%) пациентам проведены трансуретральные резекции мочевого пузыря (ТУР); 12 (18%) лечебно-диагностические торакоскопии, 22 (34%) диагностические гистероскопии и 10 (16%) лечебно-диагностические эндоскопические вмешательства с целью решения дальнейшей тактики.

ТУР мочевого пузыря и гистероскопия проводились под внутривенной анестезией, без применения наркотических препаратов с применением рекофол и кетамина болюсно. Лечебно-диагностическую лапароскопию проводили под многокомпонентной внутривенной анестезией, включающая в себя транквилизатор диазепам или брызепам, гипнотик пропфол или рекофол, наркотический анальгетик фентанил. Из релоксантов использовали лисенон, ардуан.

Возраст больных колебался от 25 лет до 77 лет. У исследуемых больных существенных изменений во время проведения анестезии не наблюдалось. Больным проведенным внутривенную анестезию после пробуждения переводились в профильное отделение. Больным после проведения лечебно-диагностической лапароскопии в зависимости от возраста

основной патологии и состояния больного переводились в отделение интенсивной терапии.

Выполнение лапароскопических операций, как оказалось, сопряжено с возникновением значительных трудностей в анестезиологическом пособии, связанных в основном с повышением внутрибрюшного давления при наложении пневмоперитонеума и изменением положения тела больного на столе во время операции.

Наложение пневмоперитонеума и изменение положения больного приводят к перераспределению воды по сегментам тела и изменениям гемодинамики.

Специальной задачей во время эндоскопических вмешательств больных, учитывалось основное состояние, возраст, сопутствующая патология (ИБС, АГ, Бронхиальная астма, Ожирение), что являлось основной целью предотвращения ишемии миокарда путем поддержания баланса между потребностью миокарда в кислороде и доставки его, то-есть не допускать тахикардии, которая влияет на подъем систолического давления, предотвращает гипоперфузию миокарда и уменьшает гипоксемию организма, которая возникает в результате наложения карбосипневмоперитонеума.

Таким образом, бурному развитию эндохирургии способствует малая травматичность, высокая эффективность, короткие сроки послеоперационной реабилитации, отличные косметические результаты и экономичность.

ОБ ИСХОДНОЙ ПОДГОТОВКЕ ХИРУРГОВ К ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Олжаев С.Т., Тельгозин Е.Т., Алтыбаева А.С., Новиков И.И.

ГККП «Алматинский региональный онкологический диспансер» г. Алматы

Актуальность. В деятельности врачей-хирургов часто возникает необходимость диагностики злокачественных новообразований.

Цель. Выявить исходную готовность врачей-хирургов к диагностике злокачественных новообразований, имеет большое практическое значение.

Материал и методы. Проведено социологическое исследование среди врачей-хирургов Алматы и Алматинской области. Умение правильно поставить диагноз и провести необходимое лечение злокачественных новообразований.

Результаты. Знания по раку желудка в полном объеме продемонстрировали 60,0% респондентов. В эту группу вошли врачи города Алматы – 7,7%, Алматинской области, 15,4%,. Неуверенные умения показали 32,3% врачей: города Алматы (10,8%), Алматинской области (6,2%). Отсутствие этих знаний выявлено у 3,1% респондентов города Алматы. Затруднились ответить 4,6% врачей города Алматы (1,5%) и Алматинской области (3,1%). Установлена квалификация респондентов в отношении диагностики и лечения опухоли ободочной кишки. Как выяснилось, в этом вопросе в полном объеме разбираются

75,4% опрошенных. Не владеют этими знаниями 3,1% врачей города Алматы и затруднились ответить также 3,1% (по 1,5% - город Алматы и Алматинской области).

Диагностику и лечение рака прямой кишки уверенно могут осуществить 64,6% респондентов. Среди них врачи города Алматы – 7,7%, Алматинской – 18,3%. Недостаточный уровень квалификации установлен у 27,7% специалистов (город Алматы – 10,8%, Алматинской области 3,1%,. 3,1% опрошенных города Алматы такими знаниями не владеют. Затруднились ответить на данный вопрос 4,6% опрошенных (по 1,5% врачей города Алматы, Павлодарской и Алматинской областей).

Что касается рака молочной железы, то при этом заболевании достаточно компетентными были 58,5% опрошенных. В их числе врачи города Алматы – 7,7%, Алматинской области – 13,8%. Не в полном объеме владеют знаниями 33,8% респондентов, в том числе из города Алматы (9,2%), Алматинской области (по 7,7%). Не выявлены такие знания у 4,6% врачей города Алматы и затруднились ответить на этот вопрос 3,1% врачи Алматы и Алматинской области – по 1,5%).

Установлено, что диагностировать и лечить рак легкого

в полном объеме способны 55,4% респондентов. В их числе опрошенные города Алматы – 4,6%, Алматинской области – 13,8%. Другую группу составили специалисты недостаточно квалифицированные (36,9%) в этом вопросе удельный вес этих врачей по регионам был таким: 12,3% врачей – город Алматы, 4,6% , Алматинской- 6,2% . Не владеют этими знаниями 4,6% врачей города Алматы. Затруднились ответить по 1,5% опрошенных города Алматы и Алматинской области.

Анализ ответов респондентов, на вопросы касающиеся диагностики и лечения доброкачественных опухолей кожи, клетчатки, соединительной ткани, мышечной, сосудистой и нервной системы при указанных заболеваниях, что показал высокий профессионализм, имеется у 70,8% опрошенных

города Алматы (10,8%), Алматинской области (16,9%) В число недостаточно подготовленных специалистов вошли 21,5% врачей. Это 9,2% врачей города Алматы, 3,1% - Алматинской области. Полностью не осведомлены в этих 1,5% врачей города Алматы. Затруднились ответить 6,2% опрошенных города Алматы, и Алматинской области (3,1%).

Выводы. Проведенные исследования показывают разный уровень исходной готовности врачей-хирургов к диагностике и лечению злокачественных новообразований. Эти результаты диктуют необходимость проведения среди врачей-хирургов систематических и целенаправленных учебных мероприятий что обеспечат лучшее качество плановой хирургической помощи населению.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТАТИЧЕСКОГО СПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Мухатова С. А.

КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан

Актуальность. Рак предстательной железы (РПЖ) – распространенная патология среди встречающихся у мужчин онкологических поражений мочеполовой системы. В Карагандинской области РПЖ среди злокачественных заболеваний мужчин занимает 3 - е место. Практически у 70% больных РПЖ диагностируется на III или даже IV стадии.

Задачи исследования: оценить результаты использования простатспецифического антигена (ПСА) при раке предстательной железы.

Материалы и методы исследования. Обследованы 102 больных РПЖ, 48 пациентов с доброкачественной гиперплазией, 44 больных со злокачественными опухолями мочевого пузыря (ЗОМ), 22 практически здоровых мужчин. Обследованные находились в возрасте от 40 до 80 лет. Уровни ПСА определяли в сыворотке крови иммуноферментным методом: тест-система общий ПСА, свободный ПСА (фирма «Алкор Био», Россия), анализатор Био-рад.

Результаты. При сравнительном исследовании средние значения ПСА общего при РПЖ повышены по сравнению с соответствующим показателем в контрольной группе в 98 раз и в группе больных доброкачественными гиперплазиями – в 21,4 раза. Результаты определения ПСА в группе больных со злокачественными опухолями мочевого пузыря были отрицательными, что свидетельствует о специфичности этого маркера для РПЖ. Только у 3 больных (6,8%) из 44 больных с ЗОМ уровень ПСА общий превышал пороговое значение 4 нг/мл.

В группах больных с доброкачественной гиперплазией, опухолями мочевого пузыря и в контрольной группе максимальный уровень антигенов (15,0; 10,5 и 5,16 нг/мл, соответственно) обнаруживались у пожилых мужчин (старше 70 лет). Уровни ПСА при доброкачественной гиперплазии находились в интервале стандартной нормы в 72,9% случаев, при РПЖ – выше порогового значения в 94,1%. У 12% больных

с доброкачественной гиперплазией значения общего ПСА колебались от 4 до 10 нг/мл (серая зона) и у 14% они были более 10 нг/мл. У 6% больных РПЖ уровень общего ПСА соответствовал интервалу контроля и в 9% наблюдений составлял 4-10 нг/мл. При анализе соотношения свободного и общего ПСА в группах больных с доброкачественной гиперплазией и РПЖ получены различия. Средняя величина соотношения при РПЖ (0,13) была ниже, чем при доброкачественной гиперплазии (0,29). Комплексный анализ свободного и общего ПСА способствует повышению чувствительности и специфичности до 93-95% при проведении дифференциальной диагностики РПЖ и доброкачественной гиперплазии.

При анализе распределения значений ПСА-общего, с учётом степени распространённости значения ПСА для больных с I – II стадией РПЖ, характерно наличие более низких значений общего ПСА по сравнению с больными III стадией. При IV стадии РПЖ невысокие уровни ПСА были выявлены в 4 наблюдениях, остальные 70 больных имели значения ПСА более 15 нг/мл. У 25 (35,7%) больных этой группы значения ПСА превышали 70 нг/мл и достигали 10500 нг/мл, тогда как ни в одном наблюдении при III стадии такие уровни не были обнаружены. Это позволяет с высокой степенью достоверности оценивать распространённость злокачественного процесса, в частности выявлять РПЖ с метастазами в отдалённые органы. В течение последних 3 лет число больных РПЖ с нормальными значениями ПСА снизилось, а с пограничными и патологическими – возросло, что согласуется с литературными и клиническими данными.

Выводы. Результаты определения общего ПСА говорят о высокой диагностической и прогностической значимости опухолевого маркера при раке предстательной железы, процентное соотношение уровней свободного и общего ПСА может быть полезным в дифференциальной диагностике РПЖ и доброкачественной гиперплазии.

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСШИРЕННЫХ И КОМБИНИРОВАННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ РАКЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА ГОРОДА АЛМАТЫ

Балтаев Н.А., Кайдаров Б.К., Афонин Г.А.

Городской онкологический диспансер г. Алматы

Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова

Основным методом лечения больных колоректальным раком (КРР) остается хирургический, дополняемый в некоторых случаях адъювантной лекарственной или лучевой терапией. Городской онкологический диспансер Алматы является ве-

дущим медицинским учреждением онкологического профиля в городе, где оказывается специализированная помощь больным КРР. За последние 3 года отмечается повышение хирургической активности стационара, увеличение числа

выполняемых операций при раке ободочной и прямой кишки. Приоритетным направлением работы отделения является выполнение функционально-щадящих операций при КРР, при наличии строгих показаний и оценке возможного риска с позиций онкологического радикализма. Это направление можно считать первичной хирургической реабилитацией такой сложной категории пациентов, какими являются больные раком ободочной и прямой кишки.

Как показывают результаты наблюдений, даже в случае радикально выполненной операции не менее 50% больных КРР имеют риск прогрессирования заболевания в виде отдаленного метастазирования или локального рецидива опухоли. Особенно это важно в отношении больных, после проведения им комбинированного или комплексного лечения так как опухолевые клетки подвергающиеся действию химиопрепаратов проходят определенную «селекцию», в результате чего возникают клоны, обладающие более злокачественными свойствами, морфологическим отражением которых может быть более низкая чем у исходной опухоли степень дифференцировки, большая способность к метастазированию и больший потенциал опухолевой прогрессии.

В клиническом отношении это означает распространенность заболевания с вовлечением в опухолевый процесс смежных (матка, придатки, тонкая кишка, мочевого пузыря) или отдаленных органов. Такой категории больных не смотря на тяжелое исходное состояние, обусловленное распространенностью опухоли, сопутствующую патологию и неудовлетворительные функциональные показатели оказывается специализированная онкохирургическая помощь.

В торакоабдоминальном отделении ГОД больным КРР с распространенным опухолевым процессом с вовлечением смежных органов выполнялись расширенно-комбинированные оперативные вмешательства. Всего за описываемый период (2010-2011 гг.) выполнено 40 таких вмешательств. При этом вариантами выполнения операции были: удаление метастатической опухоли (восходящего отдела ободочной кишки)

с гемиколэктомией справа с резекцией $\frac{1}{2}$ тонкой кишки (4); гемиколэктомия справа с экстирпацией матки с придатками (4); расширенно-комбинированная операция Гартмана с экстирпацией матки с придатками (6); симультанная операция – брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с гемигепатэктомией справа при массивном метастатическом поражении печени (2); удаление рецидивной опухоли слепой кишки с резекцией илеотрансверзоанастомоза, резекцией тонкой кишки (5); обструктивная резекция толстой кишки с субтотальной резекцией $\frac{3}{4}$ желудка с наложением гастроэнтероанастомоза и спленэктомией (4); резекция прямой кишки, резекция сигмовидной кишки, резекция тонкой кишки с экстирпацией матки с придатками (10); гемиколэктомия справа, субтотальная резекция желудка с резекцией передней брюшной стенки (2); расширенно-комбинированная брюшно-анальная резекция прямой кишки с колостомией, экстирпацией матки с придатками, резекцией верхней трети влагалища (2); комбинированная правосторонняя гемиколэктомия с атипической резекцией желудка, холецистэктомией (2); удаление рецидивной опухоли прямой кишки с экстирпацией матки с придатками, резекцией и пластикой мочеочочника (3).

Осложнениями ближайшего послеоперационного периода явились: острая задержка мочи – 1 случай, эвентерация – 2, острый некроз культи желудка (после расширенно-комбинированной операции по поводу рака сигмовидной кишки с резекцией $\frac{3}{4}$ желудка) – 1, абсцесс брюшной полости – 2, затек в области колостомы (до апоневроза) – 1, экссудативный плеврит, скопление жидкости в перигепатическом, подпеченочном пространстве (в ложе удаленной опухоли, после гемигепатэктомии) – 2, спаечная непроходимость – 2, перитонит – 1.

Следует заметить, что частота и характер осложнений находятся в зависимости от числа выполняемых оперативных вмешательств, их объема, сложности, травматичности и исходного состояния пациентов. В ГОД эти показатели не превышают таковые других ведущих онкологических клиник.

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСШИРЕННЫХ И КОМБИНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО В УСЛОВИЯ ГОРОДСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА Г. АЛМАТЫ

Нурманов С.Р., Макаров В.А.

Городской Онкологический Диспансер, г. Алматы, Республика Казахстан

Актуальность: Рак легкого в структуре заболеваемости города Алматы по статистическим данным занимает второе место, уступая только раку молочной железы и лидирует по причинам смертности от онкологических заболеваний среди мужчин.

Значимыми достижением последних лет в онкохирургии легких является выполнение резекционных этапов не только на элементах легкого, но и на внутригрудных лимфатических коллекторах и соседних органах.

Цель: Улучшить результаты лечения больных раком легкого.

Материалы и методы: В отделении торако-абдоминальной хирургии (зав. отд. – к.м.н. Нурманов С. Р.) – в период 2008-2010 гг. произведено 128 расширенных и комбинированных оперативных вмешательств.

Совершенствованию подлежали элементы медиастинальной и надключичной лимфодиссекции. В связи с инвазией опухоли в структуры средостения у большинства больных производилось частичная резекция более одного органа и структурного элемента (перикарда, вилочковый железы, ребер, пищевода, париетальной плевры, диафрагмы), включая резекции сосудов (верхней полой вены). 8 пациентам удалось провести оперативное лечение после НАПХТ кол-во курсов варьировало от 2 до 10. Применяемая нами НАПХТ проводилась по схемам EP, CAP.

Количество радикальных операции выполненных в 2008,

2009, 2010 годах составило от общего количества оперативных вмешательств 66%, 67% 70% соответственно.

Процентное соотношение больных по стадиям заболевания:

2009 год I стадия -9%, II стадия -24%, III стадия - 66%, IV стадия – 1%.

2010 год I стадия -17%, II стадия -25%, III стадия - 48%, IV стадия – 10%.

Известно что, статистика 5-летней выживаемости при III стадии рака легкого (до 25-30%) подтверждает возможность увеличения продолжительности жизни и клинического излечения именно благодаря выполнению комбинированных и расширенных операций с обязательной медиастинальной лимфаденэктомией.

Результаты: Прооперировано 128 пациентов, эффект от лечения отмечался у 109, умерло 5 пациентов, послеоперационные осложнения у 9 пациентов, у 2-х пациентов выявлено прогрессирование.

Выводы: Расширение объема оперативных вмешательств приводит к увеличению послеоперационных осложнений и летальности – 7.0% и 4.6% соответственно. Следует заметить что, подобные операции помимо лечебного характера позволяют проводить адъювантную химиоиммуннолучевую терапию, служат профилактикой кровотечения, распада опухоли, медиастина и других осложнений течения опухолевого процесса.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКОГО В УСЛОВИЯХ ТОРАКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПООД

Кравчук В.А.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

При патологических образованиях легких малого размера хирургическое лечение способствует верификации диагноза и позволяет выполнить операцию в более ранние сроки. В 10—40% наблюдений точный диагноз удается поставить только после диагностической торакотомии. Использование активной хирургической тактики без применения дополнительных методик сразу при выявлении периферического образования в легком имеет сторонников, так как это улучшает результаты лечения рака легкого, на эффективность которого существенно влияют сроки его диагностирования. В любом случае хирургическое лечение должно применяться, когда с помощью неинвазивных и инвазивных методов диагностики не представляется возможным исключить злокачественную природу образования.

В торакальном отделении ПООД за 3 года проведено 105 операций по поводу периферических образований легких. Средний возраст оперированных больных составил 51,5 года. При этом в возрасте 50-59 лет - 27%, 60-69 лет - 29%, старше 70 лет - 9%. Более 70 % составили мужчины. По локализации образования верхней доли 42%, средней доли 8%, нижней доли 50%.

Установлена онкологическая патология у 56 пациентов. По гистологической структуре у 33 пациентов плоскоклеточный рак легкого, у 8 аденокарцинома легкого, у 6 железисто-плоскоклеточный, у 5 бронхоальвеолярная карцинома, мелко-клеточный рак у 3, а в 1 случае злокачественный карциноид.

У 49 пациентов установлена неонкологическая патология, у 21 больного туберкулез различных форм (очаг Гона, тубер-

кулома, кавернозный и др.), в 7 случаях доброкачественные опухоли (хондрома, гамартохондрома и др.), у 7 больных эхинококк, киста легкого у 5, хроническая пневмония с карнификацией у 4, одиночный мешотчатый бронхоэктаз у 3, в 2 случаях небольшой хронический абсцесс.

По данным ряда авторов, даже в случае малого (до 1,5 см) рака легкого метастазы в лимфоузлах обнаруживаются в 15 – 20% случаев, в то время как при размере опухоли до 1 см таковых нет, в настоящее время не существует методик, позволяющих уверенно исключить рак легкого в случае обнаружения периферического образования легкого, не прибегая к операции, радикальные резекции при более высокой послеоперационной летальности и значительном снижении качества жизни не дают преимуществ в плане 5-летней выживаемости по сравнению с менее инвазивными вмешательствами.

По характеру выполненных манипуляций операции распределены следующим образом: пульмонэктомия 1, комбинированные резекции 2, билобэктомии 3, лобэктомии с лимфодиссекцией 12, сегментэктомия с лимфодиссекцией, типичная лобэктомия у 44, полисегментарная резекция 7, а презионная резекция выполнена у 4 больных.

Таким образом, по данным ПООД при патологических образованиях легких преобладает онкопатология, которая составляет 53%, на втором месте туберкулез 20 %, остальная патология менее значима. Только хирургическое лечение позволило достоверно установить диагноз. В 90% случаев произведена радикальная резекция с точки зрения онколога.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРО-КТ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА ГОРОДА АЛМАТЫ

Курсанова Н.Р.

Городской Онкологический диспансер, г.Алматы, Казахстан

Актуальность. В структуре заболеваемости и смертности рак желудка занимает одно из ведущих мест. Лечение больных, прогноз результатов лечения зависят от точности и полноты диагностической информации о распространенности опухолевого процесса. Для адекватной диагностики необходимы детальные данные о местной, регионарной распространенности опухоли и наличия отдаленных метастазов. Требуется полная информация об особых проявлениях опухоли: определение локальной распространенности процесса, глубины поражения стенки желудка, выявления опухоли инвазии в клетчаточные пространства, наличие метастатического поражения лимфатических узлов и висцеральных метастазов, стадирование опухоли. На основании точных сведений о степени распространения опухоли, полученных до начала лечения, основывается тактика дальнейшего комплексного и комбинированного лечения.

Цель исследования. Предоперационная оценка степени распространенности рака желудка.

Материалы и методы. С целью изучения возможностей гидро-КТ в оценке распространенности опухолевого процесса, обследовано 46 пациентов с раком желудка. Гидро-КТ основана на оптимальном растяжении желудка негативным контрастным средством: водой в сочетании с внутривенным контрастированием. Исследование проводится натощак, пациент не должен принимать пищу в течении 12 ч. Для стандартного исследования пациенты принимали 1000-1500 мл воды за 30 мин до исследования, непосредственно перед сканированием 500 мл для оптимального растяжения желудка.

Сканирование охватывало области от диафрагмы до седалищных бугров с целью определения распространенности опухолевого процесса и выявления висцеральных метастазов. Использовался протокол сканирования, также обеспечивающий оптимальную оценку печени. Проводилось нативное исследование и сканирование в портальную фазу. В портальной фазе происходит контрастное усиление утолщенной стенки желудка и пораженных лимфоузлов. В 44 случаях из 46 выявлено накопление контрастного средства опухолью. Определялась локализация, протяженность процесса, глубина поражения стенки желудка, опухолевая инвазия в клетчаточные пространства, диагностика метастатического поражения лимфатических узлов и висцеральных метастазов, стадирование опухоли. Лимфатические узлы более 5 мм округлой формы с контрастным усилением расценивались в большинстве случаев как метастатические.

Особо важное значение имеет гидро-КТ желудка для диагностики и степени распространения скirroзного рака, преимущественном подслизистом распространении опухоли, отсутствием верификации диагноза после гастроскопии. Также для хирургов предоставляются дополнительные сведения о местном распространении опухоли, вовлечения в процесс сосудов, что является очень важным в оценке резектабельности опухоли. После проведения оперативного вмешательства изучался протокол операции, операционный материал и патоморфологическое заключение. На основании сопоставления данных КТ и патоморфологического заключения оценивались возможности метода. У двух пациентов из 46 не удалось

обнаружить опухоль при т.н. «малом раке». Остаются трудности при выявлении микроскопической инвазии в клетчатку, серозную оболочку, идентификация мелких перитонеальных метастазов.

Выводы. Гидро-КТ желудка по полноте получаемой информации для предоперационной оценки имеет значительные преимущества перед обычной компьютерной томографией. Контрастное усиление утолщенной стенки желудка и пораженных лимфоузлов является надежным методом диагностики. Точность в определении локализации опухоли, протяженности процесса, глубины поражения стенки желудка, опухолевой

инвазии в клетчаточные пространства, диагностики метастатического поражения лимфатических узлов и висцеральных метастазов, оценке степени местного распространения, особенностей роста опухоли и ее осложнений позволяет рекомендовать гидро-КТ желудка для предоперационной оценки степени распространенности рака желудка, оценке резектабельности опухоли. Особенно важным методом диагностики гидро-КТ желудка является при скirrрозном раке, при отсутствии морфологической верификации. Однако диагностика ранних форм рака при гидро-КТ затруднительна.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА СУТЕНТ В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ ХИМИОТЕРАПИИ ГОРОДСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПЕНСERA Г. АЛМАТЫ

Люмозова Г.Г., Турешева А.О.

Городской онкологический диспансер г. Алматы, Республика Казахстан

Таргетные противоопухолевые препараты, направленные на ингибирование ангиогенеза, считаются одним из основных прорывов в медицине за последние десятилетия.

Новые таргетные препараты предлагают широкие возможности для паллиативного лечения больных с распространенным раком почки, однако в настоящее время не существует единого стандарта лечения таргетными препаратами, а осуществляется индивидуализированный алгоритм выбора схемы лечения.

Сунитиниб (Сутент) представляет собой ингибитор тирозинкиназы, который направлен против нескольких рецепторов VEGF и PDGF.

За период с марта по июль 2011г. нами было пролечено 5 пациентов с раком почки с использованием таргетного препарата Сутент. У 4 пациентов до начала терапии Сутентом отмечалось прогрессирование основного процесса с возникновением отдаленного метастазирования, 1 пациент изначально имел запущенную IV стадию заболевания с метастазами в правый надпочечник, поджелудочную железу. Всем пациентам на 1 этапе проведено хирургическое лечение в объеме нефрэктомии.

3 пациентов из 5 ранее получали специальное лечение по поводу основного заболевания (иммунотерапия, таргетная терапия авастинном либо нексаваром), 2 пациентов химио-иммуно-таргетную терапию не получали.

Из 5 пациентов 3 получили 3 курса, 2 пациента 2 курса таргетной терапии Сутентом, в рекомендованном режиме использования препарата: по 50 мг в день перорально в течение 28 дней, с перерывом между курсами в 2 недели. Переносимость терапии у всех пациентов была удовлетворительная, ежедневно проводился контроль лабораторных показателей (общий анализ крови, биохимический анализ крови с оценкой печеночных проб, азотистых шлаков; общий анализ мочи и коагулограмма по показаниям), электрокардиография между курсами таргетной терапии.

Субъективный положительный ответ на терапию Сутентом отмечается у всех 5 пациентов в виде уменьшения основных симптомов заболевания (кашля, одышки, болевого синдрома). У 3 пациентов до начала терапии Сутентом статус по шкале Карновского составлял 70%, у 2 пациентов – 80%, после лечения статус по шкале Карновского соответственно составил 80% у 3 пациентов, 90 % у 2 пациентов.

На настоящий момент по данным контрольного инструментального обследования, включающего компьютерную томографию органов грудной клетки, брюшной полости нами отмечены следующие результаты: частичная регрессия процесса достигнута у 2 пациентов, стабилизация процесса с положительной динамикой достигнута у 3 пациентов.

Из отмеченных нами побочных действий наблюдалась постлекарственная токсичность 1-2 степени в виде явлений диспепсии (тошнота и снижение аппетита) у 4 пациентов, мукозит слизистой полости носа у 1 пациента, дерматологические реакции (эритематозная сыпь, сухость кожи, эритема) у всех пациентов, явлений астении у 3 пациентов. Указанные побочные действия не требовали снижения дозы Сутента, купирующего лечения, купировались самостоятельно. Клинически значимых изменений со стороны лабораторных показателей, электрокардиографии у всех 5 пациентов не наблюдалось. Таким образом, лимитирующая токсичность после терапии Сутентом нами не отмечалась.

Таким образом, новая эра в лечении метастатического либо распространенного рака почки с использованием таргетных препаратов, в частности препарата Сутент поможет большинству больных увеличить продолжительность и качество жизни и иметь контроль над опухолевым процессом. Накопление большего числа пациентов, анализ полученных результатов лечения, а также последовательность в назначении препаратов позволят в дальнейшем оптимизировать лечение метастатического рака почки.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОВИРУСНОГО ЛЕЧЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Акимжанова С.М.

Городской онкологический диспансер, г.Алматы

В Казахстане раком шейки матки (РШМ) ежегодно болеет более 1000 женщин.

Широкое внедрение скрининговых программ в нашей Республике позволило повысить уровень своевременной диагностики фоновых, предраковых состояний шейки матки, начальных форм РШМ, а также адекватного их лечения. На первое место из известных этиологических факторов выходит папилломавирусное (ВПЧ) поражение шейки матки, являю-

щееся предшественником цервикальных интраэпителиальных неоплазий (дисплазий) и затем рака шейки матки. Существует несколько вариантов комплексной противовирусной терапии при лечении предрака и рака шейки матки.

В нашей клинике уже около 10 лет проводятся практические исследования, направленные на улучшение результатов комплексной терапии предрака и преинвазивного РШМ, с применением деструктивных методов лечения совместно с

противовирусными и иммуномодулирующими препаратами. В качестве основного деструктивного метода лечения при дисплазии II-III степени и преинвазивного РШМ у молодых женщин мы используем электрохирургическую конизацию шейки матки. Обязательным считается в предоперационном и послеоперационном периодах проведение курса противовоспалительного, противовирусного местного и системного лечения.

Целью нашего исследования являлось повышение эффективности комплексного лечения больных с предраковыми и преинвазивными формами рака шейки матки путем применения этиопатогенетической противовирусной терапии. Одним из препаратов выбора с местным иммуномодулирующим и противовирусным действием является «Эпиген интим» спрей. Активным действующим веществом данного препарата служит глицирризиновая кислота на основе растительной субстанции. «Эпиген интим» спрей обладает комплексным иммуномодулирующим, противовирусным, противовоспалительным воздействием, удобен для пациентов при самостоятельном применении.

В исследование были включены 250 женщин фертильного возраста с различной степенью дисплазии и преинвазивного рака шейки матки. Средний возраст пациенток составил $36,8 \pm 5,5$ лет. При диагностике был использован общепри-

нятый алгоритм, включающий расширенную кольпоскопию, цитологическое, патоморфологическое исследования и типирование ВПЧ методом полимеразной цепной реакции. Препарат «Эпиген интим» спрей назначался вагинально по 3-4 раза в день в течение 15 дней в предоперационной подготовке и после деструкции шейки матки 15-20 дней. При оценке эффективности лечения в предоперационном периоде в 98% случаев отмечалось уменьшение патологических выделений из половых путей. После электроконизации шейки матки наблюдалось раннее и равномерное отторжение струпа. При контрольной кольпоскопии была отмечена активная краевая эпителизация деструктивной поверхности, сокращение сроков репарации и полной эпителизации. Контрольное цитологическое исследование в течение двух лет в 98% случаев не выявило рецидива заболевания.

Выводы: 1. Местное применение препарата «Эпиген интим» спрей активизировало противовоспалительное лечение в предоперационном периоде. 2. Противовирусный и противовоспалительный эффект «Эпигена» в комплексной терапии ускорил процессы репарации и эпителизации шейки матки после деструкции. 3. При дальнейшем применении с профилактической и лечебной целью препарат блокирует размножение вирусов и развитие рецидива заболевания.

ОПЫТ РАБОТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПИЩЕВОДА

Мусулманбеков К.Ж., Шауенов Е. С.

Карагандинский государственный медицинский университет,
КГКП «Областной онкологический диспансер» г. Караганда

Рак пищевода является краевой патологией для Казахстана, среди злокачественных опухолей занимает пятое место с заболеваемостью 8,1 и смертностью 6,9 на 100000 населения (2009).

Данная патология представляет одну из сложных проблем клинической онкологии в вопросе лечения. Особенно сложным представляется лечение среднегрудного отдела пищевода. Несмотря на более 100 летний период разработки хирургическое лечение данной локализации применяется только в специализированных клинических центрах. Резекция среднегрудного отдела пищевода чревата высокими послеоперационными осложнениями и летальностью.

Только в конце XX – века, за счет внедрения функционально надежных анастомозов и повышения техники выполнения операции, снижен риск так называемых «хирургических» осложнений и послеоперационной летальности.

К одному из центров разработки методов хирургического лечения, относится клиника онкологии Карагандинского государственного медицинского университета.

За период с 1970 по 2010 г.г. на базе КГКП «областной онкологический диспансер» выполнено 346 радикальных операции на пищеводе, из них 174 резекции среднегрудного отдела пищевода.

Возрастной состав больных, подвергнутых резекции среднегрудного отдела пищевода следующий: 30 – 39 лет – 4 (2,3 %), 40 – 49 лет – 32 (18,4 %), 50 – 59 лет – 62 (35,6 %), 60 – 69

Таблица 2. Характер и объем выполненных операции

№ п/п	Объем и характер операции	Количество больных	Осложнения	Летальность
1	Резекция среднегрудного отдела пищевода по типу Льюиса	107	28 (26,2 %)	13 (12,1 %)
2	Резекция среднегрудного отдела пищевода левосторонним чресплевральным доступом	60	14 (23,3 %)	7 (11,7 %)
3	Экстирпация пищевода с формированием пищеводно-желудочного анастомоза на шее.	7	2	-
Итого		174	42 (24,1 %)	20 (11,5 %)

лет – 68 (39,1 %), 70 лет и старше – 8 (4,6 %), самому старшему 77 лет. Мужчин – 112 (64,4 %), женщин – 62 (35,6 %).

Объем и характер выполненных операции приведены в таблице № 2.

Среди послеоперационных осложнений ведущее место заняла недостаточность пищеводно – желудочного анастомоза, в 10 случаях приведшее к летальному исходу. На втором месте сердечно – сосудистая недостаточность (5), в трех случаях являвшийся причиной летального исхода. В 3 случаях встречали некроз трансплантата с летальным исходом в 2х случаях.

За последние 8 лет резко уменьшилось количество послеоперационных осложнений и летальность, так на 85 операции летальность составила 3,5 % (3 больных). В этой группе больных мы не встречали ни одного случая недостаточности швов анастомоза.

Комбинированная резекция произведена 24 больным, что составила 13,8 %. Летального исхода среди больных подвергнутых комбинированной резекции пищевода не было.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Аладов В.Н.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

Структура онкологической службы в Павлодарской области выглядит следующим образом. Первичным подразделением онкологической сети является онкологический кабинет в центральной районной больнице. На онкологический кабинет

возлагаются следующие важные задачи: организация учета и регистрация онкологических больных, т.е. ведение онкологической документации в районе обслуживания поликлиники; диспансерное наблюдение за онкологическими больными,

состоящими на учете и диспансеризация больных с предраковыми заболеваниями. Большинство больных предраковыми заболеваниями должны выявляться, учитываться и лечиться у врачей-специалистов общей сети. Все факультативные предраки кожи находятся в ведении дерматолога, хронические анацидные гастриты, хронические пневмонии - терапевта, определенный круг больных - гинеколога, окулиста, отоларинголога. У врача онкологического кабинета должны быть на диспансерном наблюдении все больные со злокачественными новообразованиями, доброкачественными новообразованиями молочных желез (фиброаденома, фиброаденоматоз), ворсинчатыми полипами желудочно-кишечного тракта.

Всех взятых под диспансерное наблюдение больных распределяют на клинические группы: группа Ia - больные с заболеванием, подозрительным на злокачественное новообразование; группа Ib - больные с предопухолевыми заболеваниями; группа II - больные злокачественными новообразованиями, подлежащие специальному (радикальному) лечению; группа IIa - больные злокачественными новообразованиями, подлежащие радикальному лечению; группа III - практически здоровые лица (после проведенного радикального лечения злокачественной опухоли); группа IV - больные с распространенными формами злокачественных новообразований, подлежащие паллиативному или симптоматическому лечению.

Пациентов группы Ia по мере установления окончательного диагноза снимают с учета или переводят в другие группы. Углубленное обследование больных Ia клинической группы

должно быть организовано не позднее чем через 10 дней с момента взятия на диспансерный учет.

Павлодарский областной онкологический диспансер является единственным лечебно-профилактическим учреждением, обеспечивающим население квалифицированной и специализированной стационарной и поликлинической онкологической помощью, осуществляет организационно-методическое руководство лечебно-профилактическими учреждениями по вопросам онкологии, обеспечивает специализацию и повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала в области диагностики и лечению больных злокачественными новообразованиями. В структуре онкологического диспансера развернуты следующие функциональные подразделения: стационар, поликлиника, лаборатории (клиническая, цитологическая, патоморфологическая), рентгенологическое отделение, организационно-методический кабинет. Стационарную помощь населению Павлодарской области оказывают торакальное отделение на 40 коек, отделение общей онкологии на 50 коек, радиологическое отделение на 50 коек, отделение химиотерапии на 30 коек. Дневной стационар при диспансерном отделении и стационар дневного пребывания при радиологическом отделении позволяют проводить стационарозамещающую помощь онкологическим больным.

Научно-методическую, организационно-методическую и лечебно-профилактическую работу проводит Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии.

ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ БОЛЬНЫХ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Садвакасова Г.С., Каракушикова А.С., Шортанбаев А.А.

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, кафедра иммунологии и аллергологии, г.Алматы

Актуальность. Рак молочной железы является одним из самых распространенных заболеваний у женщин. Одним из основных условий возникновения злокачественных новообразований в организме является нарушение функции иммунной системы.

Цель исследования. Изучить особенности иммунологических показателей у больных с доброкачественными новообразованиями молочной железы.

Материал и методы исследования. Проведен анализ Т-клеточного звена системы иммунитета у 23 больных доброкачественными новообразованиями молочной железы (ДНМЖ). Исследовались женщины от 35 до 65 лет. Контрольную группу составили 17 практически здоровых женщин аналогичного возраста без патологических изменений в молочной железе.

Типирование лимфоцитов проводилось в реакции непрямой иммунофлюоресценции при визуальном контроле результатов с использованием моноклональных антител CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD95+, CD25+, CD11b+ производства ЗАО «Вектор-Бест» г.Новосибирск.

Результаты и их обсуждение. При исследовании показателей клеточного иммунитета было установлено, что показатели

как относительного, так и абсолютного количества CD3+, CD4+, CD8+, CD16+ и CD95+- лимфоцитов в периферической крови у больных ДНМЖ достоверно не различались с контрольной группой. Однако в исследуемой группе наблюдалось статистически значимое увеличение относительного (в 2,5 раза) и абсолютного (в 3,2 раза) количества CD11b+-лимфоцитов по сравнению с группой контроля. В оценке иммунного статуса онкологических больных особое внимание уделяется активационным антигенам, таким как CD25+. У больных ДНМЖ было выявлено повышение, как и относительного (в 2,2 раза), так и абсолютного количества (в 2,9 раза) CD25+- лимфоцитов по отношению к их уровню в контрольной выборке. Соотношение CD25/CD95 достоверно повысился в 3,3 раза по отношению к контролю за счет повышения CD25+-лимфоцитов.

Выводы. Таким образом, на стадии предопухолевых изменений в ткани молочной железы отмечаются изменения субпопуляционного состава иммунокомпетентных клеток, а именно активация CD11b+- и CD25+-лимфоцитов, что позволяет определить течение заболевания и определить риск развития злокачественного новообразования.

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАРНОГО МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ РАКА ГОРТАНОГЛОТКИ

Тулебаев Р.К., Исмагулова Э.К., Шагатаева Б.А.

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М. Оспанова

Для нижнего отдела глотки закономерно более частое и раннее метастазирование в регионарные лимфатические узлы шеи по сравнению с гортанью (от 50 до 89%).

Цель исследования: анализ особенностей метастазирования и лечения злокачественных опухолей гортаноглотки.

Материал и методы исследования: Из 52 больных с поражением проксимального (перепончатого) отдела гортаноглотки у 32 (60,4+7,1%) имел место инфильтрат без изъязвления, у 15 (22,9+6,1%) – инфильтрат с изъязвлением, а у 12 (16,7+5,4%) – экзофитная форма роста. Причем при инфильтративной и

инфильтративно-язвенной формах метастазы в шейные лимфатические узлы отмечены более чем в 2 раза чаще (89,6%), чем при экзофитной форме роста (38,4 %), у 48% больных метастазы были множественными, у 21,2% - двухсторонними. Морфологически в 90,2% выявлен плоскоклеточный рак, в 9,8% - прочие.

Результаты исследования: У пациентов с первичной опухолью, соответствующей Т3-Т4 без регионарных метастазов трехлетняя выживаемость составила 48,1%, пятилетняя – 42,3% (21 и 17 из 46 человек соответственно). Наличие же регионарных метастазов, соответствующих N1 и N2 с аналогичной распространенностью первичной опухоли снижало отдаленные результаты в среднем в 1,3 раза: трехлетняя выживаемость составила 36,5% (8 человек) и пятилетняя – 31,6% (7 человек из 38).

Наилучшие результаты лучевой терапии получены у пациентов со степенью распространения первичной опухоли Т2 при отсутствии регионарных метастазов. При наличии регионарного метастазирования более трех лет не прожил ни один пациент. Следует отметить, что в ближайшие сроки окончания лучевого лечения у 12 пациентов из 27 с метастазами, соответствующими N2 имела полная или частичная регрессия метастатической опухоли, однако по окончании курса лучевой терапии в сроки 4-18 месяцев возникал рецидив. При проведении комбинированного лечения отмечалось повышение трех- и пятилетней выживаемости у больных с распространенными первичными опухолями. У пациентов с первичной

опухолью соответствующей Т3 (43 человека) трехлетняя выживаемость составила 66,28% (живы 29) пятилетняя – 56,98% (25 человек). Тогда как у пациентов со стадией Т3 N0M0 при хирургическом лечении трехлетняя выживаемость составила 50% (из 22 человек живы 11), пятилетняя – 45,45% (живы 10 из 22 человек).

При анализе непосредственных результатов комплексного лечения больных раком гортаноглотки полной ремиссии не наблюдалось ни у одного пациента, частичная имела у 11 (31,43%), стабилизация и прогрессирование наблюдалось в равных количествах – по 12 больных (34,29%).

Выводы: 1. Наличие у больного раком гортаноглотки клинически определяемых метастазов в регионарные лимфатические узлы является показанием для шейной лимфодиссекции или операции Крайля;

2. при клинически не определяемых метастазах (N0) возможно лишь облучение зоны путей лимфооттока, но пациент должен находиться под строгим динамическим наблюдением, и в случае появления метастазов подвергнут хирургическому вмешательству;

3. при распространенных злокачественных опухолях гортаноглотки комбинированный метод лечения более эффективен, чем чисто хирургический и лучевой. Однако, учитывая высокий процент осложнений после предоперационного облучения (62,5% против 32,3% при послеоперационном облучении), лечение следует начинать с хирургической операции.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ САРКОМОЙ МАТКИ

Имендинова Д. У., Шакирова А. Ф., Дзюбина Т. С.

КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан

Задачи исследования: анализ результатов лечения больных саркомой матки (СМ).

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 213 больных с диагнозом саркома матки, находившихся на лечении в отделении онкогинекологии КГКП «ООД» за период с 1990 по 2008 гг. Средний возраст пациенток составил – 47,8 года.

Среди гистотипов сарком матки лейомиосаркома наблюдалась у (47,4+4,9)% (101 пациентка) и эндометриальная саркома – у (36,2+5,5)% (77 больных), тогда как карциносаркома и смешанная мезодермальная опухоль относятся к редко встречающимся опухолям и составили соответственно: (10,8+6,5)% (23) и (5,6+5,6)% (12 больных).

Среди больных СМ преобладали пациентки с I стадией заболевания (62,0+4,3%), преимущественно с лейомиосаркомой (58,3+5,6%) и эндометриальной стромальной саркомой (28,8+7,3%). Больные по стадиям СМ распределились следующим образом: I стадия была выявлена у (62+4,35)% (132 человека) больных, II – (18,8+6,2)% (40 человек), III и IV стадии: (9,8+6,6)% и (9,4+6,7)% (20 больных).

Среди больных лейомиосаркомой преобладали пациентки с I стадией – 77 больных (58,3+5,6%), над III–IV стадиями – 17 больных (16,8+3,7%). При наличии эндометриальной стромальной саркомы, напротив, преимущественно пациентки имели III–IV стадии – 7 больных (33,3+5,6%) и 9 пациенток (45+11,4%) соответственно, тогда как I-II была лишь у 38 человек (28,8+7,3%) и у 23 больных (57,5+10,5%). При редко встречающихся опухолях – карциносаркоме и смешанной мезодермальной опухоли III-IV стадий выявлена у 5 больных (21,7+8,8%) и 3 больных (25,0+3,7%), соответственно.

Результаты. Больные СМ были разделены на три группы. 1 группа – 62 больных (29,1+5,7%) – получили только хирургическое лечение в объеме экстирпации матки с придатками. 2 группа – 71 больной (33,3+5,6%) – комбинированное лечение (операция + послеоперационная лучевая терапия (ПЛТ) или

адьювантная полихимиотерапия (ПХТ)). 3 группа – 80 больных (37,6+5,4%) – комплексное лечение (операция + ПЛТ + ПХТ).

Общая 3-я и 5-я выживаемость независимо от гистотипа опухоли и ее стадии составила, соответственно – (46,0+8,3)% и (40,8+7,2)%. Общая 5-летняя выживаемость при лейомиосаркоме достоверно выше, чем при эндометриальной стромальной саркоме (49,5+5,0% и 31,2+5,2%) ($p<0,05$). Достоверной разницы между 5-ей выживаемостью больных лейомиосаркомой с пациентками со смешанной мезодермальной саркомой (33,3+13,6%) и карциносаркомой (39,1+10,2%) не выявлено. Лейомиосаркома является наиболее благоприятной формой, при которой отмечены самые высокие показатели выживаемости больных. Общая 5-летняя выживаемость при I стадии независимо от гистотипа опухоли равна (55,3+3,6)%, при II стадии – (30,0+6,8)%, а при III - всего лишь (9,5+2,1)%. При IV стадии саркомы ни одна больная не пережила 5-й срок.

Трех- и 5-е результаты лечения больных СМ в группах больных, получавших хирургическое и комбинированное лечение, оказались практически идентичными. На 5-ю выживаемость больных СМ существенное значение имеет вид лечения. Показатели выживаемости оказались выше ($p<0,05$) у больных, которым проводилась адьювантная химиотерапия – (59,6+6,8)%, тогда как после адьювантной лучевой терапии она составила (31,6+10,7)%. Поэтому в качестве адьювантного лечения более эффективным можно считать химиотерапию.

Пятилетняя выживаемость среди больных без метастазов составила (50,3+3,8)%, при их наличии – (27,3+12,8)%.

Выводы: Общая 3-я и 5-я выживаемость больных саркомой матки составила, соответственно – (46,0+8,3)% и (40,8+7,2)%. Высокие показатели выживаемости при комбинированном и комплексном лечении обусловлены применением адьювантной ПХТ.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕОАДЪЮВАННОЙ ХИМИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

*Дуненова Г.А., Югай Т.А., Акимжанова С.М., Садыкова Т.Т.,
Косаева Т.Г., Анфиногенова А.Г.*

Городской онкологический диспансер,

*Казахский Национальный Медицинский Университет им.Асфендиярова,
Лечебно-диагностический центр, Алматы, Казахстан*

Использование системной химиотерапии как звено в комбинированном или комплексном лечении рака шейки матки (РШМ), по данным многих авторов, расширяет перспективы хирургического лечения местнораспространенных форм РШМ и улучшает отдаленные результаты.

Исследования были выполнены на базе Городского онкологического диспансера г. Алматы в период 2003 – 2009 гг. Объектом клинко-морфологических исследований были 147 больных первичным раком шейки матки IIa – III стадий по FIGO. По дизайну исследования 97 больным проведена неоадъювантная химиотерапия (НАПХТ) в режиме PF: цисплатин в дозировке 100 мг/м² 1-й день с использованием стандартного режима гипергидратации и антиэметиков и 5-фторурацил 750 мг/м² со 2-го по 5-й дни (внутривенно) (1-3 курса). После оценки эффективности лечения 47 больных (48,5%) (I группа) проведено хирургическое лечение в объеме расширенной экстирпации матки с придатками и верхней трети влагалища, с последующим дистанционным облучением до суммарно очаговой дозы (СОД) 40 Гр. II-ю группу составили 50 больных, которым после завершения НАПХТ была проведена сочетанная лучевая терапия (СЛТ) по радикальной программе, СОД на т.А – 60-75 Гр, СД на т.В – 45-54 Гр. III группу - группу контроля, составили 50 пациенток с раком шейки матки, которым была проведена сочетанная лучевая терапия по радикальному курсу в условиях КазНИИОиР.

Согласно нашим наблюдениям эффективность при проведении различных видов противоопухолевой терапии была различной. Прежде всего, это было связано с первичной распространенностью опухолевого процесса, повлекшего за собой той или иной вариант лечения. Анализ отдаленных результатов лечения показал, что одногодичная выживаемость составила 100% в группе больных, пролеченных комплексным лечением. В группах химиолучевой лечения и СЛТ годовой рубеж пере-

жили 94% и 92% соответственно. 3-х летний безрецидивный период в группе больных, пролеченных комплексным методом, составил 82,9%, после химиолучевой лечения – 70%, после СЛТ – 59%. Трехгодичная выживаемость в зависимости от вида лечения составила 85,1%, 74% и 62,0%. 5-летняя выживаемость в группе комплексного лечения достигла 78,7%, в группе комбинированного лечения – 60%, после СЛТ – 46%.

После проведенного первичного лечения в группе комбинированной и сочетано-лучевой терапии время до возникновения рецидива составило 6 месяцев. В группе первичного комплексного лечения время до прогрессирования составило 18 месяцев. В группе комплексного лечения без рецидивов и метастазов 2-летний рубеж пересекло 91,5% больных. Этот показатель в группе комбинированного и сочетано-лучевого лечения составил соответственно 78% и 64%. Всего показатель 2-х летней безрецидивной выживаемости составил 80,9%. В группе больных, которым была проведена комплексная терапия, рецидивы и отдаленные метастазы были выявлены в 1,3 и 1,8 раз реже по сравнению с больными после комбинированного и сочетано-лучевого лечения соответственно.

Результаты лечения рака шейки матки различными методами показали, что прогноз благоприятен лишь в ранних стадиях и ухудшается при распространении процесса. При инвазивном раке шейки матки в пределах T1b трехлетняя выживаемость отмечалась в 92,3%; при распространенности по FIGO IIA - в 88,9%; при IIB стадии - в 64,7%, при III стадии - в 55,9% случаях. Рецидивы и отдаленные метастазы были диагностированы среди больных раком шейки матки I степени у 15,4%, при IIa стадии – у 19,4%, при IIb стадии – 60,8%, III стадии - у 85,3%. Таким образом, применение системной химиотерапии в многокомпонентном лечении является эффективным методом лечения местнораспространенного рака шейки матки.

ОЦЕНКА ЛЕЧЕБНОГО ПАТОМОРФОЗА ПРИ РАДИОСЕНСИБИЛИЗАЦИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ИНГИБИТОРАМИ ЦОГ-2 С МАЛЫМИ ДОЗАМИ ЦИТОСТАТИКОВ

Тельгузиева Ж.А., Байназарова А.А., Абенова М.Т., Жолдыбай Ж.Ж.

Казахский НИИ онкологии и радиологии г.Алматы

Центральная клиническая больница Управления делами Президента РК г.Алматы

Городской онкологический диспансер г.Астаны

Рак шейки матки (РШМ) – визуально доступная форма опухоли. В исследовании клеточных мазков с поверхности шейки матки широко используют цитологический метод. Он является простым, безболезненным, сравнительно дешевым, малотравматичным, а его информативность довольно высока и составляет для преинвазивного рака - 80%, при РШМ Ia-Ib стадий - 85%, при инвазивном раке - 90%. Также в цитологии широко применяют пункционную биопсию, но при этом методе высок риск неточного попадания иглы в пунктируемую ткань. Для устранения этого момента и повышения точности диагностики используют сочетание направленной тонкоигольной пункционной биопсии с ультразвуковой эхографией. Одним из важных критериев оценки проводимой терапии явились результаты цитологического исследования степени лечебного патоморфоза в опухоли.

Цель работы - оценка лучевого патоморфоза РШМ на этапах сочетанной лучевой терапии (СЛТ) при радиосенсибилизации опухоли кетопрофеном (ингибитор фермента циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2)) с малыми дозами цитостатика - 5-фторурацила (5-Фу). В исследование было включено 80 больных IIa-IIIb стадий РШМ (по классификации FIGO), получивших лечение в Казахском НИИ онкологии и радиологии.

По способу лечения пациентки разделились на 2 группы: основная группа (n=40) - больные РШМ, получившие СЛТ на фоне радиомодификации с внутриопухолевым введением 5-Фу (250мг х ч/день, №5) в сочетании с пероральным приемом кетопрофена (50мг х 2 р/день, №25); контрольная группа (n=40) - больные РШМ, получившие только СЛТ по радикальной программе.

Результаты цитологии оценивались в динамике лечения

(при дозе облучения 20Гр и после завершения всей терапии). Материалом исследования послужили мазки, взятые с поверхности опухоли шейки матки и мазки, полученные при направленной тонкоигольной пункционной биопсии (из центральных зон опухоли) при помощи биопсийной системы – пружинный пистолет «Bard Magnum». Степень повреждения клеточных элементов опухоли определялась по морфологической классификации Г.А. Лавниковой на специальном оборудовании (программный аппаратный комплекс «Leica DMSL») с увеличением $\times 400$ и $\times 1000$. Окраска материала проводилась по способам Романовского-Гимза и Паппенгейма.

Установлено, что в основной группе при начальной дозе облучения (20Гр) отмечалось преимущественное повреждение опухолевых клеток II (42,5% - в пункционном материале) и III степени (42,5% - в поверхностных мазках), а после завершения

лечения - IV степени (85,0% - в поверхностных мазках и 82,5% - в пункционном материале). В контроле при 20Гр чаще отмечалось радиационное повреждение опухолевых клеток I (по 47,5% - в поверхностных мазках и в пункционном материале), а после завершения СЛТ - преимущественно IV степени (по 55,0% - в поверхностных мазках и в пункционном материале). Итак, в обеих группах наблюдалась схожая тенденция усиления повреждения клеток опухоли по мере нарастания дозы ионизирующей радиации к концу проводимой терапии. Однако в основной группе в опухоли патоморфоз IV степени наблюдался в 1,5 раза чаще, чем в контроле, что свидетельствовало об усилении радиационного повреждения опухоли шейки матки при применении полирадиомодификаторов в основной группе.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ АСҚАЗАН РАГІ АУРУЫНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ

Жұмағали Д.Ж., Орманов Н.К., Мадилоходжаев Р.С.

Оңтүстік Қазақстан облыстық қатерлі ісікке қарсы диспансері

Мәселенің маңыздылығы: Қазіргі таңда, дүниежүзінде асқазан рагі (АР) қатерлі ісік аурулары арасында екпе рагінен соң екінші орындарды алады және бір жылда 1 млн. астам науқастар осы аурудан көз жұмады. Ал Қазақстан Республикасында 2010 жылы асқазан рагі 100 мың халыққа шаққанда 16,3 көрсетіп төртінші орынды алса, ал ең жоғарғы көрсеткіш Солтүстік Қазақстан (24,0), Ақмола (22,1), Шығыс Қазақстан (22,0) облыстарында орын алып отыр. Оңтүстік Қазақстан облысында соңғы жылдарда сүт безі рагі алғашқы орында келсе, ал 2011 жылдың 7 айында асқазан рагі бірінші орынға шыққан және де алғаш рет анықталғандардың 17,5 пайызы ғана бірінші-екінші сатысында анықталса 25,4 пайызы төртінші сатысында анықталған. Осы мерзімде қайтыс болғандарды бөлгенде бірінші орында асқазан рагі 171 науқас (21,2 пайыз), Сондықтан, қазіргі таңда ғылыми сарапталған жаңа әдістері асқазан ісік алды және ісік ауруларының алдын алуда маңызды орын алуы тиіс.

Зерттеу мақсаты: Статистикалық көрсеткіштер негізінде Оңтүстік Қазақстан облысы (ОҚО) бойынша асқазан рагінің эпидемиологиялық жағдайын зерделеу.

Зерттеу материалы: ОҚО 2006-2010 жылдар аралығында және 2011 жылдың 7 айындағы алғашқы рет асқазан рагімен тіркеуге алу мәлімдемесіне және де арнайы қолданыстағы №35,7 есептік нысаналарға сүйене, тағы да қазіргі таңдағы онкологиядағы қолданыста жүрген жалпы санитарлық статистикалық әдістер негізінде көрсеткіштер алынған.

Нәтижесі: ОҚО бойынша 2010 жылы 2390 науқас қатерлі ісіктермен диспансерлік есепке алғаш рет алынған болса, соның ішінде асқазан рагімен 266 науқас тіркеліп, сүт безі рагінен соң екінші орында болатын. Оларды жынысына қарап бөлгенде 162 ер кісі (60,9 пайыз), ал 104 әйел кісі (39,1 пайыз). Аурушандық деңгейі де кейінгі жылдарда төмендеу байқалған, атап айтқанда 2006–2010 жылдар 100 000 халыққа шаққанда 13,2 ден 10,4 азайған. Ал 2011 жылдың 7 айында асқазан рагімен 212 науқас диспансерлік есепке алғаш рет алынған

және бірінші орынға шыққан. Асқазан рагімен анықталғандарды жасына қарап бөлсе, 2006 жылы 15-50 жаста 36 науқас (13,1 пайыз), 50-60 жаста 50 науқас (18,2 пайыз), 60-70 жаста 97 науқас (35,2 пайыз), 70-80 жаста 81 науқас (29,4 пайыз), 81 жас және жоғары 10 науқас (3,6 пайыз), салыстырмалы 2010 жылы 15-50 жаста 35 науқас (13,1 пайыз), 50-60 жаста 53 науқас (19,9 пайыз), 60-70 жаста 94 науқас (35,3 пайыз), 70-80 жаста 66 науқас (24,8 пайыз), 81 жас және жоғары 17 науқас (6,3 пайыз) болған. Алғашқы ерте кезеңде (1-2 сатысында) анықталуы 2006 жылы 16,7 пайыз, ал 2010 жылы 16,8 пайыз айтарлықтай кейінгі бес жылда алға үлгерілеу байқалмайды, асқынған төртінші сатысында 2006 жылы 25,4 болса, 2010 жылы 25,1 азаймаған. Ауырғыштығы ОҚО бойынша 2006 жылы 27,1 (100 000 халыққа шаққанда) болса, ал 2010 жылы 26,7 айтарлықтай өзгеріс жоқ. Бір жылдық өлім асқазан рагінен 2006 жылы 36,7 пайыз (772 науқас), 2010 жылы 29,7 пайызға төмендеген.

Науқастардың 5 жыл және одан артық өмір сүруі 2006 жылы 133 науқас 23,3 пайыз болса, ал 2010 жылы 279 науқас 41,2 пайызға өскен, бірақ бұл төмен көрсеткіш.

Тұжырым: Қорыта айтқанда, асқазан рагінің статистикалық көрсеткіштерінің өзгеріссіз қалыпты деңгейде қалуы, бұл мәселенің шешілмей келе жатқандығын көрсетеді. Арнайы емнің толық жүргізілуі өз нәтижесін бергеніне қарамастан асқазан рагі ерте анықталмай, асқынған кезеңде кеш анықталуы негізгі мәселе. Бұл бастапқы медициналық санитарлық көмек деңгейінде асқазан рагіне соқтыратын ауруларды алдын ала анықтау, емдеу, сауықтыруды және оны алғашқы кезеңінде анықтау өз деңгейінде жүргізгенде ғана, осы ауруды және өлімді азайтуға, 5 жыл және одан артық өмір сүруін арттыруға мүмкіндік туындайды деп ойлаймыз. Сондықтан 2011-2015 жылдарға арналған ҚР онкологиялық қызметті жетілдіру стратегиялық жоспарды орындау маңызды орын алады, ал өңеш, асқазан және ішек жолдарында скринингтік профилактикалық тексеру енгізу, бұл өмір талабы.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ҚАТЕРЛІ ІСІК АУРУЛАРЫНАН ҚАЙТЫС БОЛУ ЖАҒДАЙЫ

Д.Ж.Жұмағали

Оңтүстік Қазақстан облыстық қатерлі ісікке қарсы диспансері

Мәселенің маңыздылығы: Қазіргі таңдағы қоғамда онкологиялық аурулар мәселесі маңызды болып табылып, дүниежүзі ғалымдарын осы мәселені қалай шешу керектігі ойландыруда. Атап айтқанда, дүниежүзінде жылда 9 млн. адам өмірінде алғаш рет диспансерлік есепке онкологиялық

аурулармен алынса, 5 млн адам жылына қайтыс болады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының болжамы бойынша 2020 жылы онкологиялық аурулармен өмірінде алғаш рет диспансерлік есепке алынғандар саны 20 000 000 жетсе, ал қайтыс болғандар саны 12 000 000 асады делінген. Осыған

қарамастан Қазақстанда онкологиялық аурулардан қайтыс болғандар соңғы бес жылда 100 000 халыққа шаққанда 115,0 ден 104,0 дейін төмендеген, ал Оңтүстік Қазақстан облысы бойыншада 2006 жылы 60,1 болса, ал 2010 жылы 53,9 дейін төмендеген. Бірақ соңғы 2009-2010 жылдарда облыс көлемінде онкологиялық аурулардың аурушандығының өсімі байқалады, демек жалпы өлім санының өсуі белең алуы мүмкін.

Зерттеу мақсаты: Статистикалық көрсеткіштер негізінде Оңтүстік Қазақстан облысы (ОҚО) бойынша онкологиялық аурулардан қайтыс болуын зерделеу.

Зерттеу материалы: ОҚО 2006-2010 жылдар аралығы мен 2011 жылдың 7 айындағы сапалы көрсеткіштердің бірі онкологиялық аурулардан қайтыс болғандарды тіркеуге алу мәлімдемесіне және де арнайы қолданыстағы №35, 7 есептік нысаналарға сүйене, тағы да қазіргі таңдағы онкологиядағы қолданыста жүрген жалпы статистикалық әдістер негізінде көрсеткіштер алынған.

Нәтижесі: ОҚО бойынша 2006 жылы онкологиялық аурулардан қайтыс болғандар саны болса, оны 100 000 халыққа шаққанда 60,1 болған. Бұл көрсеткіш 2007 жылы 63,7 дейін өскен, бірақ 2010 жылы 53,9 дейін төмендеген. Ал 2011 жылдың 7 айында 803 науқас қайтыс болса, 100 000 халыққа шаққанда 31,6 ал 2010 жылдың 7 айында 733 науқас қайтыс болған 30,4, салыстырмалы алғанда 1,4 өсім байқалады. Осы анықталған 803 науқастың 153 науқас бір жылға дейін (19,05 пайызы) қайтыс болса, 650 науқас бір жылдан асқан соң қайтыс болған. Оларды жасына қарап бөлгенде 41-60 жас аралығында 29,4 пайызы (235 науқас), 61-70 жаста 28,1 пайызы (225 науқас), 71 жастан жоғары 34 пайыз (273 науқас) құраған. Ал сатыға

бөлгенде екінші сатысында 93 науқас (11,5 пайыз), үшінші сатысында 425 науқас (53,0 пайыз), төртінші сатысында 276 науқас (34,5 пайыз) болған. Екінші жағдайдағы 650 науқастың екі жылға дейін 367 қайтыс болған (56,4 пайызы). Қатерлі ісіктің орналасуына қарап қайтыс болғандарды бөлгенде бірінші орында асқазан рагі 171 науқас (21,2 пайыз), екінші орында өңеш рагі 109 науқас (13,5 пайыз), үшінші орында өкпе рагі 83 науқас (10,3 пайыз), төртінші орында ұйқы безі рагі 78 науқас (9,7 пайыз), бесінші орында бауыр рагі 67 науқас (8,3 пайыз) болған.

Тұжырым: Қорыта айтқанда, жалпы өлім 2011 жылдың 7 айында 100 000 халыққа шаққанда 1,4 өскен, ал қайтыс болған науқастардың 62,1 пайызы 61 жастан асқандар болса, олардың 74,5 пайызы екі жылға дейін қайтыс болғандар, демек кеш анықталуы және де орналасуына қарап 63 пайызы негізгі асқазан, өңеш, өкпе, ұйқы безі, бауыр рактерінен, ал аурушандықтың өсуімен қатар өлімнің өсуі, бұлда заңдылық. Осыған қарамастан скринингтік профилактикалық тексерулер нәтижесін беріп жатқанда, жоғары да аталған негізгі орналасуларда да скринингтік профилактикалық тексеру 50 жастан жоғары жүргізілсе. Онда ерте кезеңде анықтап, арнайы ем толық жүргізілсе және де бастапқы медициналық санитарлық деңгейде керекті мамандармен қамтып, қосалқы қазіргі заманғы жаңа құралдармен толықтырылса (рентгендік, ЭФГДС, УДҚ) өз нәтижесін береді деп ойлаймын. Осы тұрғыда, бұл мәселе 2011-2015 жылдарға арналған ҚР онкологиялық қызметті жетілдіру стратегиялық жоспарды орындауда маңызды орын алатынына күмәнім жоқ.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ ПЕРВИЧНЫМ РАКОМ ПЕЧЕНИ

Жумабаев А.Р., Гапырова Г.М.

Ошский межобластной центр онкологии, г. Ош Кыргызская Республика

Актуальность. До 90% больных со злокачественными новообразованиями печени не получают радикального хирургического лечения в связи с поздней диагностикой. Если принять во внимание тот факт, что большинство больных хотели бы провести остаток своей жизни и умереть дома (от 80 до 90 % опрошенных нами пациентов), то оказание паллиативной помощи в домашних условиях было бы наиболее целесообразно.

Цель исследования: определение потребности оказания паллиативной помощи пациентам с инкурабельными злокачественными новообразованиями печени жителей г. Ош.

Материал и методы исследования: Пилотным регионом был выбран город Ош, где, а с 2004 по 2006 год зарегистрировано 41 больных первичным раком печени, которым проведена комплексная терапия. Средний возраст 61,5 лет (от 38 до лет 85). Анкеты-вопросники заполнялись как во время первичного осмотра пациентов на консультативном приеме в амбулаторно-диагностическом отделении Ошского межобластного центра онкологии, так и во время осмотра онкологических больных на дому. Первичным намерением анкетирования было выяснение преобладающих симптомов болезни среди онкологических больных, их нуждаемости в паллиативной помощи, в доступности медицинских и социальных ресурсов.

Результаты и обсуждения: по полученным анкетным данным установлено, что у пациентов отмечались следующие симптомы: боль 38 случаев, слабость - 26 случаев, бессонница - 9 случаев, беспокойство и депрессия - 9 случаев, раздражительность и тревога - 9 случаев, похудание и потеря аппетита - 23 случаев, тошнота - 13 случаев, рвота - 8 случаев, одышка - 9 случаев, запоры - 13 случаев, диарея - 3 случая, кожный зуд - 6 случаев, желтуха - 7, пролежни - 7 и асцит - 12 случаев. Слабый симптом был оценен в 1 балл, умеренный - в 2 бал-

ла, сильный - в 3 балла. Для оценки тяжести испытываемых пациентом симптомов, общая оценка каждого симптома была суммирована и получены следующие результаты: боль - 83, слабость - 98, бессонница - 12, беспокойство и депрессия - 32, раздражительность и тревога - 20 у, похудание и потеря аппетита - 40, тошнота - 27, рвота - 14, одышка - 22, запоры - 24, диарея - 7, кожный зуд - 13, желтуха - 19, пролежни - 17, асцит - 25 баллов.

Боль явилась наиболее частым симптомом у пациентов первичным раком печени в терминальной стадии заболевания. Лечение хронической боли проводилось согласно анальгетической трехступенчатой схемы по ВОЗ (1999): ацетилсалициловая кислота по 250 мг пациентам (слабая боль), 29 пациентам (сильная боль) - трамадол гидрохлорид по 50 мг 4 раза в сутки и нестероидные противовоспалительные средства (индометацин, ибупрофен), 3 пациентам - морфин гидрохлорид по 20 мг 4 раза в сутки. Из вспомогательных лекарственных препаратов был использован дексаметазон по 4-6 мг с последующим поэтапным снижением (через неделю) до уровня поддерживающей 5-10 мг (дексаметазон 1-2 мг); карбамазепин по 100 мг 2 раза в день; амитриптилин по 25 мг 1 раз в сутки на ночь, при неэффективности анальгетического эффекта у 2 пациентов через 3 дня доза была повышена до 50 мг, затем до 75 мг.

Выводы: случаи боли у онкологических пациентов (92,7%) с терминальными стадиями развития болезни соответствовали данным, процитированным ВОЗ (80%). Полноценную помощь удалось оказать 78,01% пациентам. Доля пациентов, чью боль не удалось купировать несмотря на назначенное лечение, составила 12,19%. Осталось неизвестным состояние - у 4 (9,80%) пациентов, ввиду отсутствия достоверных сведений.

ПАЛЛИАТИВНОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ЖЕЛУДКА

*Кайдаров Б.К., Хожжаев А.А., Балтаев Н.А.,
Шатковская О.В., Тумабаева Х.Т., Кайдарова А.Б., Афонин Г.А.*

Городской онкологический диспансер,

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова,

Алматы, Республика Казахстан

Актуальность. Рак желудка (РЖ) на протяжении последних лет продолжает занимать одно из лидирующих мест в структуре онкозаболеваемости населения нашей республики. Так удельный вес запущенной (IV) стадии заболевания в 2008 году составил 29,7% (среднереспубликанский показатель), занимая I-е место среди всех нозологических форм злокачественных новообразований. Данное обстоятельство диктует необходимость поиска способов повышения эффективности паллиативного лечения и качества жизни (КЖ) этого контингента больных.

Цель работы: определение основных показателей КЖ и повышение эффективности паллиативного лечения больных РЖ запущенной (IV) стадии.

Материал и методы. В настоящее исследование включено 68 пациентов РЖ IV стадии, находившихся на лечении в Городском онкологическом диспансере г. Алматы в 2008-2010 гг. В соответствии с задачами исследования пациенты составили следующие группы: I (основная) группа – пациенты, получившие паллиативное комбинированное лечение: циторедуктивная гастрэктомия и послеоперационные курсы ПХТ согласно стандартам лечения (27 больных); II (контрольная) группа – больные, которым проведено паллиативное терапев-

тическое лечение – курсы ПХТ + симптоматическая терапия (41 пациент). Оценка КЖ проводилась посредством модульного опросника оценки функций в онкологии – FACT-Ga (version 4), включающего 27 вопросов, которые формируют 4 шкалы: физического, социального (включая семейное), эмоционального функционирования, благополучия в повседневной жизни и специфического модуля, содержащего 19 вопросов. В 1-й точке исследования КЖ (до начала лечения) показатели шкал опросника FACT-Ga в исследуемых группах не имели достоверных отличий ($p>0,05$).

Результаты. Сравнительная оценка КЖ в основной группе по отношению к контрольной показала, что статистически значимые различия ($p<0,05$) по среднему баллу шкал опросника FACT-Ga были выявлены по всем 4 базовым шкалам и дополнительному модулю во всех точках исследования после начала лечения. При этом медиана выживаемости составила в основной группе 13,9 мес, а в контрольной – 6,4 мес ($p<0,05$).

Выводы. Выполнение циторедуктивной гастрэктомии при запущенной (IV) стадии РЖ позволяет добиться улучшения отдаленных результатов лечения и КЖ этих больных.

ПАТОМОРФОЗ ОПУХОЛИ ПРИ РАЗНЫХ ВИДАХ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ФЕНОТИПА

*Мальшиев Н.В., Сирота В.Б., Тургунов М.Б.,
Панибратец А.П., Шерстов С.Ю., Досманова Е.А.*

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан

КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан

Задачи исследования: определение частоты встречаемости патоморфоза рака молочной железы (РМЖ) при разных видах неоадьювантной терапии в зависимости от иммуногистохимического фенотипа опухоли.

Материалы и методы исследования. Морфологическому исследованию подвергнут послеоперационный материал 313 больных РМЖ, получивших комплексное лечение в ООД. Экспрессия ER, PR и Her2/neu определялась с помощью иммуногистохимического анализа в соответствии с национальными и международными рекомендациями 2006 года. Опухоль классифицировалась, как ER и/или PR положительная при окрашивании более 10% опухолевых клеток. Оценка экспрессии Her2/neu проводилась по шкале Герсер-Test: 0-1+ - отрицательная экспрессия, 2-3+ - положительная экспрессия. Все больные разделены согласно классификации Perou C. M. et al. (2000) и Sorlie T. et al. (2001) на 4 основные группы в зависимости от фенотипа опухоли, основанного на изучении трех иммуногистохимических параметров ER, PR, Her-2/neu. Базальноподобный тип опухоли (ER-PR-Her-2/neu-) имели 105 больных (1 группа), Her-2/neu позитивный тип (ER-PR-Her-2/neu+) – 68 пациентки (2 группа), люминальный A тип опухоли (ER+PR+Her-2/neu-) имели 105 больных (3 группа) и люминальный B тип опухоли (ER+PR+Her-2/neu+) – 35 пациенток (4 группа). Использовали компьютерную программу «Statistica 5.5».

Результаты. Из 313 больных РМЖ, прослеженных в течение 3 лет, 106 – на первом этапе проведено хирургическое лечение. Исследование патоморфоза опухоли проведено у 207 пациенток, получивших неоадьювантное лечение: полихимиотерапию (ПХТ), лучевую терапию (ЛТ) и химиолучевую

терапию (ХЛТ).

После неоадьювантной ПХТ больные со II степенью патоморфоза одинаково распределились по всем фенотипическим группам, с III и IV степенью патоморфоза наименьшее количество больных наблюдали в 3 группе, достоверно меньше такового в 1 и 4 группах ($p<0,05$). Наибольшая эффективность неоадьювантной ПХТ наблюдалась у больных с люминальным B и базальноподобными типами опухоли.

После неоадьювантной ЛТ больные со II и III с IV степенью патоморфоза одинаково распределились по всем фенотипическим группам без достоверных отклонений.

После неоадьювантной ХЛТ больные со II степенью патоморфоза одинаково распределились в 1, 2 и 3 фенотипических группах, наибольшее количество больных наблюдали в 4 группе, которое достоверно ($p<0,05$) превышало таковое в остальных группах. Наименьшее количество больных с III и IV степенью лечебного патоморфоза наблюдали в 4 группе, достоверно меньше такового в 1, 2 и 3 фенотипических группах ($p<0,05$), в которых распределение больных равномерное. Высокая эффективность неоадьювантной ХЛТ отмечена у больных с базальноподобным, Her-2/neu позитивным и люминальным A типами опухоли.

Выводы: После неоадьювантной ПХТ наиболее часто патоморфоз РМЖ III и IV степени имели больные с люминальным B ($42,9\pm6,4\%$) и базальноподобным ($31,8\pm6,2\%$) типами опухоли ($p<0,05$). После неоадьювантной ЛТ больные со II и III с IV степенью патоморфоза одинаково распределились по всем фенотипическим группам без достоверных отклонений. После неоадьювантной ХЛТ наиболее часто лечебный

патоморфоз РМЖ III и IV степени имели больные с базально-подобным (69,2±6,4%), Her-2/neu позитивным (50,0±6,9%) и люминальным А (58,4±6,8%) типами опухолей, что достоверно

по отношению к больным с люминальным В (28,6±5,3%) типом опухоли ($p < 0,05$).

ПЕРВИЧНО - МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ

Аладов В.Н.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

Под первичной множественностью опухолей (ПМО) в настоящее время понимают независимое возникновение и развитие у одного больного двух или более новообразований. При этом пораженными могут быть не только разные органы различных систем, но и парные (молочные железы, легкие и др.), а также мультицентрически один орган.

В структуре полинеоплазий преобладает сочетание двух опухолей. Случаи тройной локализации встречаются в 5-8% наблюдений. Наличие у одного больного четырех, пяти, шести и более опухолей является редким и представляется казуистикой.

Впервые определение первично-множественным опухолям дал Бильрот в 1869 году. В нем он определил следующие требования к первичной множественности опухолей:

- 1) опухоли должны располагаться в различных органах;
- 2) иметь различную морфологическую структуру;
- 3) каждая опухоль должна давать собственные метастазы.

Это положение считалось классическим, но впоследствии было пересмотрено.

Большинство авторов в настоящее время придерживается положения, выработанного S. Warren, O. Gates (1932г.) и впоследствии подтвержденного Н.Н. Петровым (1947г.). С

Считается, что единственным и обязательным требованием является, чтобы эти опухоли не были метастатическими, занесенными по току лимфы, крови или по серозным полостям, ни отпечатками, развившимися от соприкосновения, то есть доказанную первичность, а не метастатическое их происхождение.

Эти критерии необходимы и очень важны при синхронном сочетании злокачественных опухолей. По мнению других исследователей, о полинеоплазиях можно говорить в случаях, когда каждая опухоль имеет определенные признаки злокачественности и не является метастазом в отношении к первой.

Особенности роста и местного метастатического распространения злокачественных опухолей столь разнообразны и неожиданны, что отличить вторую первично-множественную опухоль от рецидива или метастаза в практической работе далеко не всегда удается с абсолютной точностью.

Вопрос временной границы между синхронностью и метастатичностью длительное время был открытым. В настоящее время большинство авторов считает, наиболее достоверным и приемлимым интервалом выявления метастатических опухолей, в сроки более 6 месяцев.

В сущности установить точные границы представляется невозможным, что заставляет с особым вниманием относиться к диспансеризации этого контингента больных.

За последнее десятилетие частота ПМО возросла до 13%. Только за последние 30 лет во всем мире описано несколько десятков тысяч наблюдений ПМО.

Факторами, влияющими на рост заболеваемости ПМО, являются увеличение средней продолжительности жизни, возростание интенсивности канцерогенных воздействий, урбанизация, накопление наследственной отягощенности, улучшение диагностики онкологических заболеваний.

В Павлодарском онкологическом диспансере за 2008г взято на учет с первично-множественными опухолями 75 пациентов, в 2009г. - 72, в 2010г. - 75.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ТИМОЭКТОМИИ БЕЗ И С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ АНГИОПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

Бейсебаев А.А., Карасаев М.И., Баймухаметов Э.Т.,

Тулеутаева З.К., Макаров В.А.

Казахский НИИ онкологии и радиологии;

Казахский НМУ им. С. Д. Асфендиярова; ГОД г. Алматы

Хирургический метод – основа лечения больных опухолями средостения. Мы располагаем опытом клиничко-лучевой диагностики послеоперационных осложнений:

1. При выполнении операции тимомэктомия по поводу ее злокачественности - 27 больных. Выполнен широкий спектр таких вмешательств, как стандартная тимомэктомия, комбинированная тимомэктомия (одновременное удаление вторично пораженных органов и структур грудной клетки).

2. При выполнении тимомэктомии с ангиопластическими операциями по поводу злокачественной тимомы и синдрома сдавления верхней полой вены - 15 больных. Производилась резекция верхней полой вены или ее ветвей, а также протезирование.

Клиничко-рентгенологически обследовано и подвергнуты хирургическому лечению 42 больных со злокачественной патологией вилочковой железы.

Из 42 больных у 23 опухоль вилочковой железы носил более выраженный характер с клиникой синдрома верхней полой вены.

Гистологическое заключение операционного материала: эпителиальная тимомы 13 (31,0±7,1); эпидермоидная тимомы

3 (7,1±4,0); веретинноклеточная тимомы 3 (7,1±4,0); лимфоэпителиальная тимомы 9 (21,4±6,3); гранулематозная тимомы 13 (31,0±7,1); гигантоклеточная тимомы 1 (2,4±2,4).

У 8 больных удаление вилочковой железы сопровождалось частичной перикардэктомией или краевой резекцией легкого. В 15 случаях удаление вилочковой железы потребовало оперативное вмешательство на сосудах. Из них у 3 больных операция на сосудах заключалась в резекции левой безымянной вены. Операции непосредственно на верхней полой вене состояли в ее резекции и протезировании (5) или наложении обходного сосудистого шунтирования (анонимо-аурикулярное - 3, анонимо-кавальное - 3, яремно-кавальное - 1).

Анализ характера и частоты осложнений, возникающих после удаления опухоли вилочковой железы, позволяет указать на следующее. Во-первых, до 31,8% рентгенологически с первых суток после операции в плевральной полости со стороны торакотомии выявляется жидкость, сгустки крови или газ (воздух) несмотря на присутствие дренажной трубки и проведение активной или пассивной аспирации содержимого плевральной полости. Малая эффективность оставляемых хирургами дренажной трубки в плевральной полости можно

объяснить прижатием трубки или его отверстий легким.

Во-вторых, легкое до $21,0 \pm 9,6\%$ находится в состоянии гиповентиляции и в $21,0 \pm 9,6\%$ случаев развивается пневмония.

В-третьих, наблюдается увеличение частоты осложнений тимомэктомии при комбинированных (резекции участков легкого, пищевода, ребер) и ангиопластических операциях: $36,9 \pm 11,4\%$; $50,0 \pm 17,7\%$ и $53,3 \pm 13,3\%$ соответственно.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ЯИЧНИКОВ

*Кукубасов Е.К., Кайрбаев М.Р., Шалбаева Р.Ш., Досаханов Ж.А., Гуртовенко М.И.
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, г. Алматы
Областной онкологический диспансер, г. Павлодар, РК*

Цель исследования - оценить результаты хирургического лечения распространенного рака яичников.

Материал и методы. В исследование включено 27 пациенток с верифицированным диагнозом рак яичников стадии IIIb-IV. Стадия определена в соответствии с правилами стадирования FIGO. Средний возраст больных составил 56,9 лет. Стадия IIIb – 9 больных (33,3%), IIIc – 15 (55,6%), IV – в 3 (11,1%) случаях. Хирургическое лечение проведено в объеме: Лапаротомия. Гистерэктомия. Оментэктомия у 18 (66,7%) пациенток. Модифицированная экстраперитонеальная задняя экзентерация в 9 (33,3%) случаях. Всем пациенткам проведена системная периаортальная, тазовая зональная лимфодиссекция (рисунок 1).

Результаты. Проанализированы патоморфологические исследования биопсийного материала пациенток. Выявлены метастазы в группах лимфатических узлов: А – 12 (44,4%), В – 8 (29,6%), С – 18 (66,7%), D – 5 (18,5%), Есправа – 9 (33,3%), Еслева – 8 (29,6%), Фсправа – 7 (25,9%), Фслева – 10 (37,0%), Гсправа – 9 (33,3%), Гслева – 7 (25,9%), Нсправа – 7 (25,9%), Нслева – 3 (11,1%). В большом сальнике – 16 (52,9), круглой связке печени – 3 (11,1%), яичниковые сосуды справа и слева по 4 (14,8%), брюшина диафрагмы – 4 (14,8%), л/у ворот печени

и селезенки, поверхность печени по 1 (3,7%), латеральные каналы – 7 (25,9%). У 4 (14,8%) пациенток метастазов не обнаружено.

Выводы. Результаты являются промежуточными. Проводится изучение влияния проведения радикальных операций с периаортальной лимфодиссекцией на общую и безрецидивную выживаемость пациенток с распространенным раком яичников.

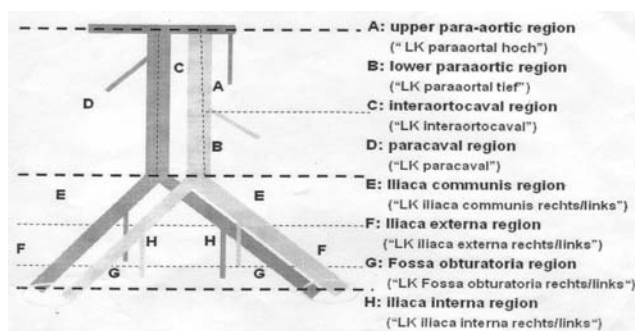


Рисунок 1. Схема периаортальной, тазовой системной лимфодиссекции

ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗВИТИЮ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

*Кайдаров Б.К., Афонин Г.А., Джансугурова Л.Б.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова
Институт общей генетики и цитологии МОН РК*

Ситуация с заболеваемостью и смертностью от колоректального рака (КРР) в Республике Казахстан остается неблагоприятной. Анализ статистических данных свидетельствует, что: 1. заболеваемость раком прямой и ободочной кишки возрастает; 2. возрастает смертность от этих форм рака; 3. в г. Алматы отмечается высокий процент запущенности при раке толстой кишки (РТК) и раке прямой кишки (РПК); 4. РПК и РТК входят в число 9 основных форм рака, определяющих структуру онкопатологии в республике (рак ободочной кишки – 8 место, рак прямой кишки – 9 место); 5. в г. Алматы отмечены высокие показатели заболеваемости КРР; 6. в структуре причин, определяющих смертность от онкологических заболеваний, РТК находится на 7, а РПК – на 6 месте. Важно отметить, что все случаи заболевания КРР не дифференцируются, т.е. они регистрируются единым массивом без стратификации по возрасту, и соответственно без выделения ведущей причины возникновения заболевания в той или иной возрастной группе. Важной проблемой является рост заболеваемости КРР в популяции молодых людей. Рак толстой и прямой кишки, как и ряд других злокачественных новообразований «молодеет», поражая пациентов молодого, трудоспособного возраста.

Основные теоретические и практические предпосылки разработки данной проблемы в Республике Казахстан.

Фундаментальное значение. К настоящему времени четко установлено, что рак – это болезнь генома. Каждая конкретная

опухоль, не смотря на определенные закономерности патогенеза, реализуется на основе уникального генотипа пациента и различных типов мутаций, вовлеченных в процессы канцерогенеза. Выяснение этих механизмов при наследственных формах КРР, где вклад генетических факторов несомненен при учете данных молекулярной эпидемиологии, будет способствовать более полному и глубокому пониманию частоты распространения в популяции мутаций, определяющих предрасположенность к наследственным формам КРР.

Клиническое значение. КРР является нозологией, при которой даже комплексное лечение при условии выполнения радикальной операции на протяжении последних десятилетий имеет ограниченные достижения. Причин тому несколько: как правило, КРР поздно диагностируется, когда даже при отсутствии видимых (т.е. доступных инструментальному контролю) метастазов, наиболее вероятно наличие микрометастазов, которые и определяют дальнейшее течение заболевания и прогноз для больного. У молодых лиц в силу биологических особенностей организма (большой пул пролиферации клеток) болезнь рано и быстро прогрессирует с развитием отдаленных очагов метастатического опухолевого роста. Это определяет неблагоприятный прогноз для пациента. Вместе с тем следует отметить, что при обнаружении опухоли на ранних стадиях и адекватном лечении возможно достижение благоприятного результата в плане выживаемости и качества жизни больного.

Социальное значение. Лица с наследственными формами КРР – это лица молодого, активного, репродуктивного возраста. Это особая категория больных, которые, как правило, обращаются за медицинской помощью с запущенным опухолевым процессом (например, с клиникой кишечной непроходимости), таким больным проводятся нвалидирующие операции, что резко снижает качество жизни. Даже при условии проведения радикальной операции, дополненной курсами адъювантной химио- или химиотаргетной терапии заболевание у таких больных, как правило, прогрессирует, что приводит к фатальному исходу. Общество и семья теряют активного, работоспособного члена.

Самым важным на сегодняшний день остается вопрос методологии и стратегии: в республике больные с наследственными формами КРР не выделяются в отдельную группу пациентов. Выделение таких больных в особую группу позволит целенаправленно собирать анамнез, в т.ч. «семейный»,

проводить более углубленное специальное обследование, динамическое диспансерное наблюдение. Важным при проведении молекулярно-эпидемиологических исследований является определение вероятности совокупного генетического риска развития КРР (наличие и характер мутаций), осуществление ранней диагностики и профилактики путем медико-генетического консультирования и адекватного лечения больных на ранних стадиях болезни.

Основным положением, которое позволяет перевести данные фундаментальных исследований в практически-значимые аспекты является следующее: клинко-генетические и молекулярно-биологические исследования семейных форм РТК позволяют разработать индивидуальный комплексный подход к верификации диагноза (молекулярно-генетического), оценке риска развития рака, ранней диагностике, лечению и профилактике с целью снижения заболеваемости и смертности.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Кабилдина Н.А.

Карагандинский государственный медицинский университет

Актуальность. Проблема ранней диагностики новообразований молочной железы, в особенности непальпируемых, является чрезвычайно актуальной и в то же время одной из самых сложных в маммологической практике. Метод пальпации является инициальным моментом в диагностическом поиске различной патологии молочных желез. Для более точной диагностики применяется ряд лабораторно-инструментальных методик.

Стремление повысить качество диагностического процесса приводит к разработке и внедрению в практику новых инструментальных методов исследования молочных желез и совершенствованию существующих.

Цель исследования. Доказать, что комплексно проведенное обследование молочных желез, включающее клинический осмотр, рентгеновское и ультразвуковое исследования значительно повышает выявляемость непальпируемых образований.

Материалы и методы. Проанализированы результаты рентгеновских и ультразвуковых исследований молочных желез 117 пациенток в условиях КООД, у которых при пальпации отсутствовали патологические изменения в молочных железах. Возраст их составлял от 42 до 68 лет.

Ультразвуковые исследования осуществлялись на аппарате «Sonoase» фирмы «Медисон» линейным датчиком 7,0 – 13,0 МГц с использованием ЦДК. После чего этим же пациенткам проводилась двухсторонняя рентгеновская маммография в двух проекциях.

Результаты. Результаты исследований: при проведении УЗИ выявлена объемная патология в молочных железах у 62 женщин (53%). У 6 (14,5%) из них имелась сонографическая картина рака, что было подтверждено цитологически. Пункции проводились под контролем ультразвука, все пунктаты оказались информативными. У 36 (58,1%) выявлены фиброадено-

мы, у 17 (27,4%) кисты.

При проведении рентгенологических исследований этой же группы женщин объемная патология выявлена у 104. Злокачественные опухоли у 17 (16,3%). Цитологическое подтверждение до операции было получено только у 8 человек (47%). Остальным женщинам были выполнены секторальные резекции со срочным гистологическим исследованием, получено морфологическое подтверждение, после чего выполнялось радикальное лечение. У 47 (45,2%) женщин были обнаружены фиброаденомы малых размеров. У 18 (17,3%) – кальцинаты, у 3 из них скопление кальцинатов было локализованным, им проведены секторальные резекции, выявившие в 2 случаях рак молочных желез. И у 22 (21,4%) рентгенологически были выявлены кисты. У 2 пациенток при пункции опухоли под контролем УЗИ получены цитологические подтверждения злокачественности опухоли. Обе пациентки были радикально прооперированы, имеется гистологическое подтверждение диагноза. В 7 случаях фиброаденомы были выявлены только при ультразвуковом исследовании, 4 женщинам из них проведены секторальные резекции, подтвердившие диагноз. В 3 случаях опухоли были малых размеров (менее 5 мм), секторальные резекции им не проводились, пациентки находятся под наблюдением от 6 месяцев до 2 лет, роста опухолей нет отмечено.

Выводы. Таким образом, несмотря на то, что приоритет рентгеновской маммографии в диагностике заболеваний молочных желез неоспорим, ультразвуковая маммография, проведенная совместно с рентгеновской, расширяет возможности диагностики непальпируемых образований молочных желез, что дает возможность диагностировать рак молочной железы на ранних стадиях, тем самым повышая качество жизни женщин.

ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОПРЕПАРАТА АРГЛАБИН У ИНКУРАБЕЛЬНЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Досманова Е. А.

КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан

Арглабин создан в РК (разработчик – Институт фитохимии МОН РК) на основе одноименного сесквитерпенового лактона, выделенного из эндемичного растения для Центрального Казахстана – полыни гладкой. Арглабин является ингибитором фермента фарнезилпротеинтрансферазы, участвующего в процессинге Ras-онкобелков, отвечающего за митотическую

активность опухолевой клетки. Отсюда направленность действия препарата и его низкая токсичность.

В КазНИИОиР в лаборатории экспериментальной химиотерапии в 1991-1993гг. была определена разовая доза 5 мг/кг веса или 185 мг/м².

При изучении влияния препарата «Арглабин» на интер-

фероновый и цитокиновый статус у больных раком молочной железы на базе «Центра по интерферону и цитокинам» при НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН (г. Москва), подтверждено иммунокорригирующее действие препарата при дозе 5 мг/кг веса или 185 мг/м². При данной дозе определено и радиосенсибилизирующее свойство препарата, но цитотоксический эффект при этой дозе недостаточен. Представляет значительный интерес оценка цитотоксической эффективности арглабина при повышении его дозы, учитывая отсутствие токсичности самого препарата за счет направленности действия.

Цель исследования: изучение эффективности применения арглабина при повышении дозы препарата при симптоматической терапии инкурабельных онкологических больных.

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты лечения 24 инкурабельных больных. Средний возраст - 54,5 лет. Все пациенты были после комплексного лечения с прогрессированием опухолевого заболевания и после полихимиотерапии с развившейся к ней резистентностью. Больные с разной локализацией опухоли: рак молочной железы - 6 больных, меланома кожи - 1, рак органов желудочно-кишечного тракта - 11 (рак пищевода - 2, рак желудка - 2, печени - 2, поджелудочной железы - 1, прямой кишки - 3, желчного пузыря - 1), рак легкого - 2, шейки матки и яичников - 2, саркомы мягких тканей - 2. Из них 19 больных получали арглабин из расчета 10 мг/кг веса или 370 мг/м² в течение 15 дней внутривенно одномоментно в виде 2% раствора или инфузионно на 200,0 мл физиологического раствора. Остальные 5 больных получали арглабин из расчета 15 мг/кг веса или 555 мг/м² в течение 15

дней внутривенно инфузионно на 400,0 мл физиологического раствора. Разовая доза арглабина варьировала от 600 до 1120 мг, суммарная - от 9000 до 16800 мг. Пациенты получали от 1 до 6 курсов арглабина.

Полученные результаты. В первую очередь, необходимо отметить хорошую переносимость препарата при повышении дозы. При одномоментном введении арглабина в разовой дозе 370 мг/м² отмечались выраженное головокружение, горечь во рту, при внутривенной инфузии эти симптомы не были выражены, поэтому введение препарата в дозе 555 мг/м² было только инфузионно. Все больные субъективно отмечают уменьшение слабости, повышение аппетита и улучшение общего состояния после первого курса.

Полный и частичный клинический ответ не получен ни у одного пациента, у 10 больных стабилизация процесса до 12 месяцев, у 14 - прогрессирование.

Одна больная с диагнозом рака желчного пузыря после нерадикальной хирургического лечения с асцитом получала арглабин внутривенно через катетер после лапароцентеза в разовой дозе 370 мг/м², СД 8800 мг, стабилизация процесса. Другая пациентка с диагнозом рака молочной железы IIa (T2N0M0), после комплексного лечения, прогрессирование, асцит, после 6 курсов полихимиотерапии получила 6 курсов арглабина из расчета 370 мг/м², полный регресс асцита в течение года.

Выводы. Применение арглабина при повышении дозы препарата до 370 мг/м² и 555 мг/м² у инкурабельных онкологических больных требует дальнейшего изучения.

ПРИЧИНЫ ЛЕТАЛЬНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЁННОГО РАКА ЖЕЛУДКА

Букенов А.М., Нам Э.Н., Шевкоплясова А.М.

*Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан
КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан*

Задачи исследования: выявить основную причину летальности и уменьшить частоту несостоятельности швов пищевода при хирургическом лечении рака желудка.

Материалы и методы исследования: Анализированы истории болезни 287 больных, находившихся на обследовании и лечении с диагнозом: Рак проксимального отдела и тела желудка за период с 1990 по 2004 г.г. Возраст больных колебался от 27 до 80 лет. Средний возраст подвергнутых операции составил 59,4±2,8 лет. Следует отметить, что среди больных преобладала III стадия опухолевого процесса 82,2%, IVa стадия - 17,5% (с врастанием опухоли в соседние органы) и только лишь у одного пациента была диагностирована I стадия. Гистологически преимущественно встречались недифференцированные карциномы - 54,4% (156), плоскоклеточный рак с орогошением - 23,4% (67), дифференцированная и малодифференцированная аденокарцинома - 22,2% (64). Экзофитный рак выявлен у 36 (12,5%), инфильтративный - у 218 (76,0%) и смешанный рост - у 33 (11,5%). Объем выполненной операции зависел от анатомического типа роста опухоли и её локализации. Операции были выполнены чресплевральным доступом - 136 (47,4%) большим и чрезбрюшинно - 151 (52,6%).

Результаты: Послеоперационная летальность на 287 операций составила 17,1% (умерло 49). Независимо от оперативного доступа и объема операций ведущей причиной летальности явилась несостоятельность пищевода (44,8±5,6)% (35 из 287) среди всех осложнений. Значительное увеличение летальности отмечено среди больных после проксимальной резекции желудка с резекцией ретрокардиального и наддиафрагмального сегментов пищевода - (23,9±5,2)% против (6,5±4,4)% с резекцией абдоминального сегмента пищевода, т.е. чем выше уровень резекции пищевода, тем чаще возникает несостоятельность пищевода. После гастрэктомии

с резекцией абдоминального сегмента пищевода несостоятельность пищевода достоверно чаще возникает - (31,6±7,55)%, чем после чрезбрюшинной гастрэктомии без резекции пищевода - (3,3±1,5)%.

Анализ клинического материала показал, что частота недостаточности пищевода среди всех осложнений по Сапожкову-Юдину и Гиляровичу-Грэхему составила соответственно: (39,1±10,4)% (9 из 23) и (66,6±12,6)% (10 из 15). Послеоперационная летальность от недостаточности швов пищевода значительно ниже при использовании анастомоза по способу Сапожкова-Юдина (13,3±6,0)% (6), по сравнению с летальностью при использовании способа Гиляровича-Грэхема - (27,3±7,7)% (9). Послеоперационная летальность от несостоятельности пищевода была сведена до минимума за счёт внедрения усовершенствованного погружного анастомоза, при котором не наблюдалось данного осложнения. При муфтообразном анастомозе по Г.В. Бондарю отмечено в (5,6±2,4)% (5 на 90 операций) случаев несостоятельности пищевода. Из пяти больных с несостоятельностью пищевода при муфтообразном анастомозе погибли 3 пациента.

Выводы: Независимо от оперативного доступа, объема операции и уровня резекции пищевода ведущей причиной летальности явилась несостоятельность пищевода. На частоту развития несостоятельности анастомоза влияет и адекватно выбранный способ формирования последнего. Оптимальным вариантом формирования пищевода является погружной анастомоз (авторское свидетельство №45123, авторы Нам Э.Н., Букенов А.М.), который обеспечивает надёжную герметизацию соустья, а, следовательно, и отсутствие летальности от несостоятельности швов соустья.

ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ГЕМОБЛАСТОЗОВ И ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Мухаметгалиев Н.А., Кабиева А.О.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, Республика Казахстан

Терапия злокачественных новообразований требует детальной идентификации опухолевых клеток. Актуальны на сегодня дифференциальная диагностика опухолей и соответствующий подход к лечению. В связи с чем в диагностике лейкозов и лимфом прочное место заняло определение иммунофенотипа опухолевых клеток.

Материал и методы исследования. Для иммунофенотипирования острых лейкозов нами использовалась панель моноклональных антител: CD19, CD20, CD21, CD22, CD10, CD23, CD3, CD7, CD5, CD4, CD8, CD13, CD15, IgM, CD33, CD61, Гликофорин А, CD34, CD14, CD117, CD2, CD11c, CD56, CD38, CD45, HLA-DR, antiKappa/antiLambda/CD19, CD37, CD79b и др., для хронических лимфолейкозов: CD7, CD38, CD4, CD5, CD23, CD21, CD20, CD22, CD43, FMC7, CD79b, CD25, antiTCR abgd, HLA-DR, CD3, CD8, CD19, CD10, CD45, antiKappa/antiLambda/CD19 и др. Иммунофенотипирование проводили после пробоподготовки с лизированием и отмывкой эритроцитов на проточном цитофлуориметре FACS Calibur, фирмы Becton Dickinson. Иммунофенотипирование

клеток крови и костного мозга проведено 40 пациентам с гемобластомами и лимфопролиферативными заболеваниями. 13 пациентов были с направительным диагнозом: острый лейкоз, 27 пациентов с направительным диагнозом: хронический лимфолейкоз.

Результаты. Среди пациентов с острым лейкозом у 7 пациентов установлена миелоидная принадлежность, у 3-х пациентов В-клеточная принадлежность, у 3-х пациентов Т-клеточная принадлежность бластных клеток. Среди пациентов с направительным диагнозом хронический лимфолейкоз у 21 пациентов установлен В-хронический лимфолейкоз, у 1-го пациента лимфома клеток мантийной зоны, у 1-го пациента лимфома маргинальной зоны селезенки, у 3-х пациентов Т-клеточная лимфома, у 1-го пациента Т-клеточный пролимфоцитарный лимфолейкоз.

Таким образом, среди онкогематологических больных преобладают пациенты с хроническими лимфопролиферативными заболеваниями, подавляющее большинство среди которых занимает В-хронический лимфолейкоз.

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И СКРИНИНГ

Толеутай У.К.

Высшая школа общественного здравоохранения

Рак молочной железы (РМЖ) у женщин является одной из наиболее распространенных форм злокачественных новообразований. В структуре онкологической заболеваемости женского населения в области он занимал 2-е место, следуя после рака пищевода. Однако высокий темп прироста заболеваемости и смертности от РМЖ, опережающий большинство других опухолей, выдвигает эту проблему на ведущее место в противораковой борьбе.

Целью настоящей работы является изучение эпидемиологии РМЖ и эффективности проводимого маммографического скрининга на территории Кызылординской области.

Материалы и методы исследования. Исследование охватывает 20 лет (1991-2010). Источниками исследования были учетно-отчетные документы Кызылординского областного онкологического центра, где взяты на «Д» учет больные с впервые в жизни установленным диагнозом РМЖ. Вычислены экстенсивные и грубые показатели заболеваемости РМЖ по общепринятым методам санитарной статистики.

В структуре онкологической заболеваемости населения за 2010 год РМЖ занимает 4-е место. За 20 лет (1991-2010) в области было зарегистрировано 1004 – женщин с РМЖ. Частота встречаемости РМЖ в области была неодинаковой.

В Кызылординской области отмечается значительный рост заболеваемости РМЖ. С 1991 по 2010гг. этот показатель вырос втрое (с $3,8 \pm 1,52$ до $12,5 \pm 2,37$ ‰).

Показатель смертности от РМЖ в области находится на уровне среднеказахстанского, варьируя от $2,5 \pm 0,75$ ‰ до $6,0 \pm 0,75$ ‰. Заболеваемость РМЖ по Кызылординской области в 2010 г. составила - $12,59 \pm 0,11$ ‰. Самый низкий уровень заболеваемости зарегистрирован в Жалагашском районе - $2,38 \pm 1,24$ ‰; самый высокий – в городе Кызылорде - $19,78 \pm 3,12$ ‰.

Из общего числа заболевших женщины в возрасте до 50 лет составляют 46,3%.

Наибольшая заболеваемость отмечена в возрастной группе 50-59 лет (27,7%). После 80 лет, по нашим наблюдениям, РМЖ выявляется сравнительно редко, составляя всего 2,2% от всех заболевших.

За последние три года проведен маммографический скрининг 40779 женщинам в возрастной группе 50-60 лет. Различные формы диффузной фиброзно-кистозной мастопатии были диагностированы у 5381 (13,2%). Узловая форма мастопатии выявлена у 195 (0,48%). Фиброаденомы определялись у 538 (1,32%), микрокальцинаты у 360 (0,88%) женщин. РМЖ выявлен у 44 (0,1%), из них I-II стадии у 32 (72,7%).

Известно, что ранняя диагностика во многом определяет успех лечения онкологических заболеваний. Показатель ранней диагностики РМЖ (выявление заболеваний в I-II стадии) возрос в Кызылординской области за последние годы. Так, в 1991 г. он составлял 40,9%, в последний год - 72,8%.

Эффективность ранней диагностики, снижение запущенности характеризует показатель одногодичной летальности, который во многом зависит от степени распространенности процесса на момент обнаружения. Среднеобластной показатель одногодичной летальности при РМЖ в 1991-2010 гг. варировал от 9,6 до 10,0%.

Выводы. Таким образом, в результате эпидемиологического исследования последних 20 лет, выявлены тенденция к росту заболеваемости РМЖ, неравномерное распределение данной патологии по районам области. Также имеют место хорошие результаты в области ранней диагностики рака, во многом благодаря систематическому проведению маммографического скрининга.

РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ (1996-2010)

Сулейменов М.К., Кравчук В.А., Богомазова И.В., Буть Л.Г.
КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

В связи с тем, что Павлодарская область относится к регионам эндемичным в отношении патологии щитовидной железы, нами проведен анализ основных показателей рака щитовидной железы в области.

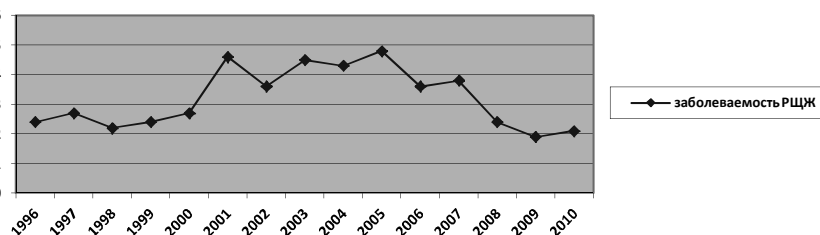
Для этого использованы статистические данные годовых отчетов за период с 1996 по 2010 годы.

Заболеваемость за эти годы значительно колебалась от 1,9 (в 2009 году) до 4,8 (в 2005 году). При этом отмечался пик заболеваемости в 2003-2007 годах (см. график).

Смертность колебалась незначительно от 0,5 до 1,5 и в целом за 2000-е имеет тенденцию к снижению. Последние годы стабильно составляет 0,7. Болезненность так же колеблется незначительно от 32,2 до 34,2.

Процент верификации в среднем чуть меньше 100%, в большинство лет составлял 100%, в некоторые годы отдельным пациентам диагноз верифицировать не удавалось. И учитывая общее небольшое количество больных, снижался в отдельные годы до 90%.

Удельный вес I-II стадии составляет все годы более 50% и колебался от 52,6 в 1998 году до 86,1 в 2005 году. В среднем за отчетный период составил около 60%. При улучшении качества диагностики, увеличения больных с начальными стадиями растет 5-летняя выживаемость с 50,2 до 72,2%.



При анализе полово-возрастного состава пациентов установлено, что преобладают женщины, отношение к мужчинам составляет 6:1. Средний возраст составил 51,4. При этом пациенты в возрасте 20-39 более 21%, а возраст 40-59 более 40%.

При анализе распространения РЩЖ по регионам области достоверных очагов заболеваемости выявлено не было, заболевание равномерно распределено в области, с распространением в основном среди городских жителей.

Полученные нами данные совпадают с тенденциями, отмеченными в РК (Мауенов Д.К. с соавторами 2011) и по восточному региону (Масадыков А.С. 2010). Положительные сдвиги в лечение связаны с улучшением диагностики узловых образований щитовидной железы и их своевременным хирургическим лечением. Связи заболеваемости раком щитовидной железы с Семипалатинским ядерным полигоном достоверно установлено не было.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАКА КОЖИ В ГОРОДЕ АЛМАТЫ

Кайдарова Д.Р., Хожжаев А.А., Балтаев Н.А., Шатковская О.В., Бекишев Х.Х.,
Дюсенгалиев Б.Д., Монахова Г.А., Абабакиев А.К., Валиева Т.Е.,
Адиев М.М., Баймухаметов К.К., Мецанинова И.В., Коллар И.Г.,
Суйнибек А.С., Серикбаев Б.А., Турсунов Ф.А.

Городской онкологический диспансер, Алматы, Республика Казахстан

Актуальность. Рак кожи, включая меланому кожи, является одной из наиболее часто встречающихся опухолей. При этом, основным методом лечения данных новообразований остается хирургический, так как эта онкопатология относится к разряду визуально-доступных локализаций и должна выявляться, априори, на ранних стадиях.

Цель работы: медико-статистический анализ заболеваемости и ранней диагностики рака кожи в г. Алматы в период 2009-2011 г.г.

Материал и методы. В работу включены показатели ранней диагностики больных раком кожи, включая меланому кожи, находящихся на диспансерном учете в Городском онкологическом диспансере г. Алматы с начала 2009 года.

Результаты. На диспансерный учет в 2009 году взято 385 больных с раком кожи, из которых на ранних стадиях заболевания (I-II стадии) выявлено 383 пациента или 99,5±0,4%. При этом запущенность составила всего 0,5% (2 больных выявлено на III стадии; пациентов с IV стадией опухолевого процесса не было). Диагноз меланомы кожи установлен 53 жителям г. Алматы. Из них 45 больных выявлены на ранних стадиях, 8 пациентов в запущенных стадиях, их которых 2 пациентов на момент постановки диагноза имели отдаленные метастазы, что связано с агрессивным течением данной нозологической формы злокачественных новообразований. В 2010 году раком кожи заболело 459 алматинцев, из них в 99,6±0,3% случаев (457 пациентов) злокачественный процесс

установлен на ранних стадиях и только у двух больных заболевание выявлено на III стадии. Меланома кожи выявлена у 47 человек, при этом у 42 больных (89,4±4,5%) на I и II стадиях, у 2 больных – на III стадии и еще у 3 пациентов – на IV стадии онкопроцесса. За 9 месяцев текущего года получены следующие результаты ранней диагностики: диагноз рака кожи установлен 324 пациентам, из которых 319 больных в момент постановки диагноза имели I и II стадии заболевания (98,5±0,7%), меланома кожи выявлена у 35 пациентов, при этом у четырех человек из пяти заболевание установлено на ранней стадии (80,0±6,8%). Вместе с тем, рак кожи в последние годы прочно занимает 2-е ранговое место среди всех опухолей.

Заключение. Учитывая полученные результаты можно констатировать, что сохраняется высокая заболеваемость раком кожи населения г. Алматы. При этом, высокие показатели ранней диагностики в течение последних трех лет наглядно демонстрируют результаты лечебно-профилактической работы, благодаря чему, подавляющему числу пациентов проведено специализированное лечение, в основном - хирургическое. В ряде случаев, пациентам проведена близкофокусная рентген-терапия, как самостоятельный метод лечения базально-клеточного рака кожи головы, а также химио-, иммуно- и лучевая терапия в виде комбинированного и комплексного лечения при распространенных формах опухолевого процесса, согласно стандартов лечения.

РЕАБИЛИТАЦИЯ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ БОЛЬНЫХ МЕЛАНОМОЙ

Аладов В.Н.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

В Павлодарском онкологическом диспансере состоит на учете 179 человек с меланомой кож, из них более 5 лет – 115. Показатель 5-летней выживаемости 64,9%.

Меланома кожи — чрезвычайно злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов (пигментных клеток, продуцирующих специфический белок — меланин). Удельный вес в общей структуре заболеваемости раковыми заболеваниями в Павлодарской области составляет от 0,5% до 1 %. Заболеваемость меланомой кожи в РК за последнее десятилетие имеет тенденцию к росту: прирост показателя составил 54,6 %. В различных регионах мира ежегодный показатель заболеваемости колеблется от 5 до 30 на 100000 населения. Заболевают меланомой кожи, в основном, лица после 30 лет.

Реабилитация онкологических больных — последовательный процесс, где на каждом этапе лечения, дальнейшего наблюдения и жизни больного применяют определенные воздействия. Основными принципами восстановительного лечения онкологических больных являются: раннее начало лечения, непрерывность, преемственность, комплексный характер, этапность медицинских мероприятий, индивидуальный подход к больному. Реабилитация при меланоме должна основываться на обязательном соблюдении следующих основных положений и требований:

1. Первичная профилактика меланомы кожи — радикальное удаление невусов, подвергающихся травматизации, особенно меланомоопасной группы.

2. Раннее выявление и адекватное хирургическое лечение меланомы кожи.

3. Выбор рациональных методов лечения в соответствии со стадией опухолевого процесса и особенностями его течения в каждом конкретном случае.

4. Тщательное установление показаний к комбинированным

и комплексным методам лечения, адъювантным и неоадъювантным способам терапии.

5. Выбор оптимального объема хирургического вмешательства на первичном очаге и адекватного метода пластического закрытия раневого дефекта.

6. Строгое установление показаний к простой и расширенной регионарной лимфаденэктомии.

7. Профилактика и рано начатое лечение возможного лимфостаза конечностей после регионарной лимфаденэктомии.

8. Тщательная диспансеризация больных после радикального лечения с целью раннего выявления и своевременного специального лечения возможных рецидивов и метастазов меланомы.

9. Диспансерное наблюдение за больными, леченными по поводу первичных поздних форм меланомы, рецидивов и метастазов после проведенного ранее радикального лечения, с целью проведения и коррекции специальных методов поддерживающей терапии.

Проведение комплекса реабилитационных мероприятий повышает эффективность лечения больных меланомой кожи. За больными меланомой после радикального лечения устанавливают тщательное диспансерное наблюдение с целью своевременного выявления возможных рецидивов и метастазов. Контрольные обследования проводят каждые три месяца в течение первого года и каждые шесть месяцев на протяжении второго года, затем — ежегодно. При возникновении рецидивов и метастазов больные подлежат специальному лечению в условиях соответствующего онкологического учреждения. За больными, лечение которых было нерадикальным, также устанавливают диспансерное наблюдение для контроля течения процесса и соответствующей коррекции поддерживающего специального лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ

Олжатаева Г. О.

КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан

Задачи исследования: исследовать результаты медицинской реабилитации больных раком шейки матки (РШМ).

Материалы и методы исследования. Проведен анализ медицинских дел освидетельствования 626 больных РШМ, пролеченных в КГКП «Карагандинский областной онкологический центр» за пять лет (2001-2005 гг.), 1260 историй болезней данных пациенток и 626 медицинских карточек. Все больные прошли полное клинико-лабораторное обследование. Диагноз верифицирован цитологически в (98,4±0,5)% случаев: плоскоклеточный рак — (73,2±1,6)%, железистый — (12,8±1,3)%, низкодифференцированный рак — (9,1±1,1)%, мукоэпидермоидный рак — (2,2±0,5)%, другие — (1,1±0,4)%.

У 63,6% пациенток проведено кольпоскопическое исследование: неизмененная слизистая оболочка влагалищной части шейки матки выявлена у (0,16±0,2)%, доброкачественные изменения слизистой оболочки — у (1,44±0,5)% и атипичный эпителий — у (62,0±1,9)%.

Подавляющее большинство больных (76,1%) имели II и III стадии злокачественного процесса. Запущенный процесс наблюдали в 50,8% случаев (318 пациенток) — это больные с III и IV стадиями рака. Это очень высокий показатель запущенности опухолевого процесса, учитывая визуальную локализацию рака. Остальные 49,2% приходятся на I и II стадии опухолевого процесса. В 98,4% случаев диагноз верифицирован цитоло-

гически при первичном обращении больных в поликлинику онкологического диспансера.

При анализе полученных клинических данных оценивалась безрецидивная и общая кумулятивная 5-летняя выживаемость больных (по Kaplan-Meier). Полученные результаты обработаны на персональном компьютере «Pentium - 4» с привлечением программы «Statistica».

Результаты. Одна треть больных РШМ (30,7±1,8%) получили комбинированное лечение: хирургическое + лучевое. При I стадии РШМ у молодых (до 50 лет) женщин было проведено хирургическое лечение в объеме расширенной экстирпации матки — операция Вертгейма. У остальных больных с I стадией, а также при II и III стадиях проводилась только сочетанная лучевая терапия — ведущий метод лечения РШМ, поэтому 50,5% пациенток лучевую терапию.

Средняя суммарная очаговая доза на точку «А» составила 77,13±0,95 Грей с минимумом в 59 и максимумом в 100 Грей. Большая часть пациентов получила суммарную очаговую дозу на точку «А» от 71 до 90 Грей. Средняя суммарная очаговая доза на точку «Б» составила 58,16±0,79 Грей и варьировала от 43 до 74 Грей. Подавляющее большинство больных — 62,5% получили на точку «Б» от 55 до 64 Грей, более 65 Грей подведено у 19,6% больных. В 17,9% случаев суммарная очаговая доза на точку «Б» составила меньше 54 Грей.

Отдаленные результаты лучевой терапии прослежены у 158 больных РШМ со II и III стадиями. Кумулятивная выживаемость на первом году составила $(76,0 \pm 6,0)\%$, показатель 3-летней общей выживаемости был равен $(63,0 \pm 2,4)\%$. Показатель 5-летней выживаемости практически не меняется и составляет $(62,5 \pm 1,4)\%$.

Безрецидивная выживаемость больных РШМ после

сочетанной лучевой терапии составила на первом году – $(65,0 \pm 2,7)\%$, трехлетняя безрецидивная выживаемость – $(52,0 \pm 3,4)\%$, четырех и пятилетняя безрецидивная выживаемость составила $(41,0 \pm 3,7)\%$.

Выводы: Общая кумулятивная 5-летняя выживаемость больных РШМ составляет $62,5 \pm 1,4\%$, безрецидивная – $41,0 \pm 3,7\%$.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИОТЕРАПИИ ФТОРПИРИМИДИНАМИ В КОМБИНАЦИИ С ЦИСПЛАТИНОМ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРВИЧНОГО РАКА ПЕЧЕНИ

Омарова И.М., Кожамбердин К.Е.

Карагандинский областной онкологический диспансер

Первичный рак печени представляет серьезную проблему для здравоохранения. По данным международного агентства по изучению рака в мире ежегодно погибает более полумиллиона человек.

Интерес к проблеме лечения первичного рака печени обусловлен всё ещё неудовлетворительными результатами лечения пациентов. Общий прогноз при первичном раке печени неблагоприятный, даже при использовании современных методов лечения

Цель исследования – изучение сравнительной эффективности цисплатина в комбинации с 5-фторурацилом или капецитабином в первой линии химиотерапии первичного рака печени

Материал и методы исследования: в данное нерандомизированное исследование включено 44 пациента (32 мужчин и 12 женщин) в возрасте от 34 до 76 лет с морфологически подтвержденным диагнозом распространенного первичного рака печени III – IV стадии (таблица 1).

В подгруппе А полихимиотерапия проведена по схеме: 5-ФУ 500 мг/м^2 внутривенно в 1, 3, 5, 8 дни и цисплатин 100 мг/м^2 внутривенно капельно в 1 день каждого 28 дневного цикла.

В подгруппе В полихимиотерапия проведена по схеме: капецитабин 1000 мг/м^2 2 раза в день внутрь с 1 по 14 дни и цисплатин 100 мг/м^2 внутривенно капельно в 1 день каждого 28 дневного цикла.

Результаты и обсуждение: в подгруппе из 28 пациентов А частичный регресс отмечался у 14,3%, стабилизация заболевания – у 32,1%, прогрессирование заболевания – у 53,6% пациентов. В подгруппе В из 16 пациентов частичный регресс отмечен у 18,7%, стабилизация заболевания – у 37,5%, прогрессирование заболевания – у 43,8% пациентов (

Сравнение результатов непосредственной эффективности

химиотерапии между подгруппами не выявило достоверных различий.

Токсический профиль в обеих подгруппах был практически одинаковым, однако следует отметить, что у 37,5% больных подгруппы В отмечался ладонно-подошвенный синдром.

Пригодными для оценки выживаемости в подгруппе А явились все 28 пациентов, которым проведено 86 курсов ПХТ 5-ФУ в комбинации с цисплатином. При использовании этой комбинации удалось достичь 3-месячной выживаемости у 98,2%, 6- месячной выживаемости – у 80,7%, 9-месячной выживаемости – у 56,1%, одногодичной выживаемости – у 35,1% пациентов. Медиана наблюдаемой выживаемости составила $10,7 \pm 1,5$ месяцев.

В подгруппе В проведение 16 пациентам 46 курсов ПХТ капецитабином в комбинации с цисплатином позволило достичь 3-месячной выживаемости у 93,7%, 6- месячной выживаемости – у 81,2%, 9-месячной выживаемости – у 66,5%, одногодичной выживаемости – у 60,9% пациентов. Медиана выживаемости достигла $14,4 \pm 1,6$ месяцев.

Результаты исследования показали, что комбинация капецитабин+ цисплатин достоверно (Cox's F-Test: $F=3,7$; $P=0,00014$) увеличивает одногодичную выживаемость с 35,1% до 60,9% и медиану выживаемости с 10,7 до 14,4 месяцев по сравнению с комбинацией 5-ФУ+цисплатин (рисунок)

Закключение: таким образом, проведенное клиническое исследование комбинированных режимов ПХТ фторпиримидинами с цисплатином в качестве I линии химиотерапии распространенного рака печени показало удовлетворительные непосредственные и отдаленные результаты лечения. Кроме того, изученные комбинации продемонстрировали уровень токсичности приемлемый для клиники.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Жумакаев М.Д., Мусулманбеков К.Ж.

Карагандинский государственный медицинский университет.

КГКП «Областной онкологический диспансер», г. Караганда

Несмотря на постоянное совершенствование техники хирургического лечения рака головки поджелудочной железы послеоперационные осложнения и связанная с этим летальность остается высокой и составляет в среднем 50 % и 26,6 % соответственно.

Наиболее сложным и ответственным элементом реконструктивного этапа панкреатодуоденальной резекции является формирование панкреатодуоденального анастомоза. Это поистине «ахиллесова пята» всей операции, т.к. послеоперационная несостоятельность этого анастомоза влечет за собой цепь тяжелых осложнений и практически остается причиной летальных исходов.

Второе место, среди грозных послеоперационных осложнений занимает панкреатит. По данным отдельных авторов

наиболее частым послеоперационным осложнением является панкреатит, встречающийся в 20 – 50 %. По их мнению, они часто являются фактором риска развития недостаточности панкреатоюанального анастомоза и одной из ведущих причин послеоперационной летальности.

С целью профилактики острого панкреатита предлагается целый комплекс медикаментозных лечений и дренирование протока поджелудочной железы с наружным выведением дренажа, который нередко приводит к формированию стойких панкреатических свищей и развития малоабсорбции.

В основу работы положен анализ лечения 46 больных с опухолями панкреатодуоденальной зоны, которым проведено оперативное лечение в Карагандинском областном онкологическом диспансере за период с 1999 по 2009 годы с

внедрением нового, разработанного в клинике, хирургического подхода.

Возрастной состав больных распределился таким образом: чаще встречались больные в возрасте 50 - 59 лет и 60 - 69 лет, составляя 45,6 % и 32,6 % соответственно. Возраст самого молодого и пожилого больного составили 18 и 85 лет.

Соотношение мужчин и женщин составили 58,8 % (27), женщины 41,2 % (19).

Установлены следующие локализации опухоли: рак головки поджелудочной железы 62,8 % (28), рак большого дуоденального соска (БДС) 29,4 % (14). Тремя больным по поводу осложненных форм рака дистального отдела желудка и одному больному по поводу рака печеночного угла ободочной кишки с прорастанием головки поджелудочной железы (8,6%) произ-

ведена комбинированная панкреатодуоденальная резекция.

По результатам операционного материала установлены следующие гистологические формы опухоли: аденокарцинома высокой, средней и низкой степени дифференцировки, светлоклеточный вариант аденокарциномы, злокачественный карциноид с амилоидозом, железистотубулярная аденокарцинома, ацинарноклеточный рак, протоковая аденокарцинома.

Среди послеоперационных осложнений поддиафрагмальный абсцесс, внутреннее кровотечение в 2 случаях.

После операции умерло 2 больных (4,3 %) от сердечно-сосудистой недостаточности. Как видно из приведенных цифр послеоперационное осложнение и летальность составила 21,7 % и 4,3 % соответственно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Сейсембаев М.А., Наржанов Б.А., Токсанбаев Д.С.,

Садыков Н.К., Молдабеков Е.Т., Исбамбетов А.С.

Национальный научный центр хирургии им. А. Н. Сызганова

Республика Казахстан, город Алматы

Цель. Улучшить результаты хирургического лечения больных с опухолями желчных протоков.

Материал и методы. В ННЦХ им. А. Н. Сызганова проанализированы результаты 72 больных со злокачественными опухолями желчных путей в возрасте от 37 до 80 лет, находившихся на лечении в отделении хирургии печени с 2003 – 2010 годы. Из них мужчин 42 (58,3%), женщин 30 (41,7%).

Для диагностики опухолей желчных протоков и причины механической желтухи использовались лабораторные, а также инструментальные методы исследования, как: УЗИ и доплерографией, МРХПГ, КТ, ЭРХПГ и ЧЧХС с фистулохолангиографией.

Основным проявлением заболевания явилась желтуха 100%, кожный зуд – 75,0%, холангит – 49,0%. Большинство пациентов 56 (77,8%) имели желтуху тяжелой степени тяжести (общий билирубин свыше 200 мкмоль/л). Операции проводились в два этапа; первым этапом с целью уменьшения печеночной недостаточности выполняли декомпрессию желчных путей (ЧЧХС, ЭРХПГ + стентирование), вторым этапом проводили основное оперативное вмешательство.

Результаты. Всего при опухолях желчных протоков выполнено 22 (29,1%) радикальных операций. Из них, в 15 случаях выполнены резекции опухолей желчных протоков с дополнительным иссечением передней части IVb сегмента печени, что обеспечило адекватный доступ к внутрипеченочным желчным протокам для формирования билиодигестивного анастомоза (би-, три-, тетрагепатикоюностомия) на изолированной Ру петле. В одном (1,4%) случае выполнена расширенная правосторонняя гемигепатэктомия, в 5 (6,9%) случаях – гастропанкреатодуоденальная резекция при опухолях терминального

отдела холедоха. При опухоли Клатскина с распространением в головку поджелудочной железы одному пациенту (1,4%) выполнена правосторонняя гемигепатэктомия + IVb сегмент и гастропанкреатодуоденальная резекция. В трех (4,2%) случаях из-за инвазии опухоли в стенку воротной вены произведено резекция с пластикой.

Паллиативное хирургическое лечение при опухолях желчных протоков выполнено 50 (69,5%) больным. Проведены следующие оперативные вмешательства: реканализация с дренированием желчных протоков – 24 (33,3%) пациентам, с наложением билиодигестивного анастомоза – 7 (9,7%) пациентам. Чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков под УЗИ-контролем как окончательный вид хирургического вмешательства выполнено – 19 (26,4%) пациентам.

В послеоперационном периоде наблюдались специфические осложнения у 15 (20,8%) пациентов – желчеистечение с перитонитом, кровотечение и печеночно-почечная недостаточность. Летальность отмечено в 13 (18,0%) случаях, причиной которых были холангит, печеночная недостаточность и ТЭЛА.

Выводы. При опухолях желчных протоков с тяжелой степенью механической желтухой и печеночной недостаточностью необходимо проводить двухэтапное лечение, которое позволяет уменьшить частоту послеоперационных специфических осложнений и летальных исходов. Наличие опыта резекционных вмешательств на печени и желчных протоках, а также техническое оснащение операционного блока специфическим оборудованием, позволяет выполнить радикальное оперативное вмешательство и улучшить отдаленные результаты лечения.

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ В ОНКОКОЛОПРОКТОЛОГИИ

Хожяев А.А., Кайдаров Б.К., Балтаев Н.А., Шатковская О.В.,

Мещанинова И.В., Адиев М.М., Баймухаметов К.К.

Городской онкологический диспансер г.Алматы,

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова

Актуальность. Высокий процент осложненных форм колоректального рака (КРР) сопровождается тем, что значительной части больных выполняются обструктивные резекции толстой кишки с формированием концевой колостомы на передней брюшной стенке. При этом реабилитационные мероприятия выходят на первый план, так как восстановление привычного «образа тела» остается доминирующей жизненной задачей этих больных, многие из которых в момент постановки диагноза

находятся в трудоспособном возрасте и профессионально востребованы. Как показывает практика, устранение инвадизирующего фактора остается главной задачей стомика на протяжении всего периода динамического наблюдения, оставляя на втором плане даже продолжительность жизни при наличии такого выраженного физического дефекта, как противоестественный задний проход.

Цель работы: улучшение качества жизни (КЖ) стомиро-

ванных больных КРР.

Материал и методы. В настоящее исследование включено 86 больных III клинической группы, находящихся на диспансерном учете в Городском онкологическом диспансере г. Алматы с диагнозом КРР и которым ранее в плановом или экстренном порядке были выполнены обструктивные резекции толстой кишки с формированием концевой абдоминальной колостомы с культей отключенной кишки: а) в левом боковом канале – 17, б) в малом тазу – 40, в) под тазовой брюшиной («короткая культя» прямой кишки) – 29 больных. При этом, 57 больных КРР, которым сформирован *anus praeternaturalis*, до первичной стомирующей операции занимались трудовой деятельностью, что составило $66,3 \pm 5,1\%$. Хирургический этап медицинской реабилитации заключался в устранении кишечной стомы и восстановлении естественного пассажа кишечного содержимого. Из них 19 больным выполнены реконструктивно-восстановительные операции с использованием механических аппаратных швов, а 67 больным – ручных двух- и однорядных швов. Несостоятельность межкишечного анастомоза составила 1,2%. КЖ оперированных пациентов изучалось с помощью опросника Европейской организации исследования и лечения рака – EORTC QLQ-C30 (version 3), состоящего из 5 функцио-

нальных шкал, 3 шкал симптоматики, шкалы общего качества жизни и 6 одиночных пунктов.

Результаты. Сравнительный анализ показателей КЖ больных КРР до восстановительной операции и во всех точках обследования после ликвидации колостомы показал, что статистически значимые различия ($p < 0,05$) по среднему баллу шкал опросника EORTC QLQ-C30 были выявлены по шкале общего КЖ (QL), функциональным шкалам: физическое функционирование (PF), ролевое функционирование (RF), эмоциональное функционирование (EF), социальное функционирование (SF) и шкале, отражающей финансовые затруднения (FI). Коэффициент «трудовой реабилитации» составил $84,2 \pm 4,8\%$. При этом из 48 больных, которые вернулись к труду после реконструкции кишечника, только $14,6 \pm 5,1\%$ (7 человек) пришлось пройти переквалификацию и поменять вид трудовой деятельности.

Заключение. Выполнение реконструктивно-восстановительных операций, как хирургического этапа медицинской реабилитации у стомированных больных КРР, позволяет значительно улучшить их КЖ и подавляющему числу пациентов вернуться к трудовой деятельности, в том числе в основном – без переквалификации.

РОЛЬ ИМПЛАНТОВ И ЭСПАНДЕРОВ В РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Исмаилов А.Х., Гимранов А.М., Губайдуллин Х.М., Ванесян А.С.

Казанская государственная медицинская академия

Увеличение продолжительности жизни и показателей общей и безрецидивной выживаемости, ставит вопрос о качестве жизни пациентов, резко падающего в результате проведенного радикального лечения. Органосохранная и реконструктивно-пластическая хирургия должна являться интегрированной частью хирургического лечения рака молочной железы. Поскольку органосохранные операции показаны только определенной группе пациентов, то перед хирургом стоит вопрос о способе возмещения удаленной молочной железы. В арсенале присутствует либо использование аутологических тканей, либо реконструкция алломатериалами (экспандеры и/или импланты). У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Преимуществами аутологических тканей являются их пластичность, индивидуализация моделирования и более высокий процент достижения симметрии. Существенными недостатками реконструкции лоскутами являются травматичность операции, непредсказуемость результатов (ишемические осложнения) и относительная необратимость операций. При реконструкции молочной железы экспандерами и имплантами можно назвать следующие преимущества: простота выполнения, меньшая травматичность и минимальное количество послеоперационных рубцов (отсутствие донорской зоны). Недостатками являются дороговизна изделия, сложность достижения начальной и (или) стабильной симметрии, повышение риска фиброзной контрактуры после проведения лучевой терапии, вероятность потери протеза в условиях длительной лимфореи, вследствие нагноения, или повреждения протеза.

При реконструкции молочных желез алломатериалами применяется одноэтапная или двухэтапная методика. При одноэтапной методике можно использовать перманентный

экспандер - имплант или имплант. При двухэтапной методике подразумевается постановка экспандера на первом этапе, а после растяжения кожи до необходимых объемов – постановка импланта. Выбор методики заложен на наш взгляд в названии, одноэтапность подразумевает собой, что хирург уверен в обеспечении окончательного результата за один раз, в противном случае нужно прибегать к двух-этапной операции.

Одноэтапная реконструкция имплантом показана в следующих случаях: небольшая грудь без птоза, кожносохранная мастэктомия (без дефицита кожи, нет необходимости дермотензии). Показания к пластике перманентными экспандерами – имплантами включают показания пластики имплантами, а также: небольшой дефицит кармана (при условии сохранения инфрамаммарной складки) и неуверенность с точным определением объема импланта.

Показания к двухэтапной методике: отсроченные реконструкции (при которых субмаммарная складка отсутствует), одномоментные реконструкции при опухолях T3, T4 (субмаммарная складка разрушается в процессе мастэктомии), планирование ДЛТ (есть возможность иссечения фиброзно-измененной капсулы в процессе замены экспандера на имплант, проблемная (сложная) грудь, небольшой опыт (если, что-то не решилось на первом этапе, есть возможность исправления на втором).

Таким образом данный алгоритм, позволяет избежать хаоса в показаниях к применению алломатериалов в реконструктивно-пластической хирургии молочной железы, позволяя избежать много-этапности, в тех случаях когда результат достигается за один раз, и наоборот не формировать инфрамаммарную складку на имплантах, дискредитируя одноэтапность.

РОЛЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПОПУЛЯЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОФ «ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА» И ГОРОДСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

Кунирова Г.Ж., Кайдарова Д.Р., Шатковская О.В.

Общественный фонд «Вместе против рака»

Городской онкологический диспансер г. Алматы

По статистике ВОЗ, рак по всему миру убивает больше людей, чем СПИД, малярия и туберкулез вместе взятые. По прогнозам ожидается еще более значительный рост смертности: без кардинального улучшения ситуации к 2030 году уже не 7,5 миллионов, 17 миллионов человек будет принесено в жертву этому заболеванию по всему миру. Эта проблема требует принятия кардинальных решений. В сентябре 2011 года состоялся международный Саммит ООН, одна из тем которого, касалась проблемы неинфекционных заболеваний (к ним относятся и онкологическая патология).

По словам Эдуарда Казапа (Eduardo Cazar) Президента UICC – Международного союза по борьбе с раком: «Саммит ООН по неинфекционным болезням, представляет собой историческую возможность правительствам разных стран, принять обязательства в отношении осуществления программ, которые позволят предотвратить страдания и смерть миллионов людей от рака и других хронических болезней. Бремя неинфекционных болезней катастрофически растет, особенно в развивающихся странах, на которые приходится почти 80% случаев смерти. К сожалению, изменяющийся образ жизни, включая снижение физической активности, злоупотребление вредными привычками и т.д., отражается на здоровье людей, что, в свою очередь, делает их более уязвимыми перед такими болезнями, как рак».

Казахстан является активным участником в борьбе за здоровье людей без угрозы смерти от онкологических заболеваний. Министерством здравоохранения РК подготовлен и принят ряд важных нормативных документов для онкологической службы. Утверждено «Положение о деятельности организаций, оказывающих онкологическую помощь населению», в стадии доработки «Программа совершенствования онкологической службы до 2015 года», включая развитие ядерной медицины, вносятся изменения в систему финансирования онкослужбы и др. Для достижения поставленных целей перед онкологической службой поставлены задачи: поэтапное совершенствование системы оказания первичной и специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; усиление роли первичного звена для раннего выявления злокачественных новообразований и повышение профессионализма медицинских работников.

Решение онкологических проблем должно проводиться в совместном партнерстве между государством и обществом, что отражено в Послании Президента страны народу Казахстана «Построим будущее вместе» от 28 января 2011 года и приоритетом Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы. Цель партнерства – разработка концепции работы для определения и распространения информации, возможностей и опыта для предупреждения и контроля рака. Партнерство также направлено на привлечение широкого круга заинтересованных сторон, в частности неправительственных организаций, бизнеса, исследователей, групп пациентов, государственных структур и отраслевых руководителей, по всему Казахстану в совместном стремлении действовать против распространения онкологических заболеваний. Национальная программа борьбы против рака может помочь лицам, определяющим политику, и руководителям этой программы использовать имеющиеся ресурсы с максимальной эффективностью на благо всего населения за счет взвешенного подхода к проведению мероприятий, разработанных на основе фактических данных.

Профилактика представляет собой наиболее целесообразную с экономической точки зрения долгосрочную стратегию борьбы против рака. Профилактические мероприятия эффективны вдвойне, поскольку они также способствуют профилактике других хронических болезней, развитие которых обусловлено теми же факторами риска. По имеющимся оценкам, примерно 43% случаев смерти от рака связаны с употреблением табака, нездоровым рационом питания, потреблением алкоголя, малоподвижным образом жизни и инфекциями.

С целью выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях, в Казахстане приняты глобальные скрининговые программы – по раку шейки матки, раку молочной железы и раку толстого кишечника. Эти программы проводятся по всей стране и в том числе в г. Алматы. К сожалению, чтобы оказать существенное влияние на онкологическую ситуацию в стране, указанные выше мероприятия должны проводиться в течение нескольких лет, причем, уровень информированности населения, о необходимости проходить профилактические осмотры, должен быть максимально высоким.

Привлечение внимания общественности к вопросам профилактики рака и онкологии в целом, является основной задачей неправительственных общественных организаций. ОФ «Вместе против рака» — это некоммерческая, неправительственная благотворительная организация, призванная поддерживать все формы борьбы против рака, своей деятельностью эта организация оказывает содействие повышению эффективности работы онкологической службы в Казахстане, включая: успешную профилактику, раннюю диагностику, качественное лечение, доступную паллиативную помощь

ОФ «Вместе против рака» работает в тесном сотрудничестве с Городским онкологическим диспансером г. Алматы с 2008 года. Проведен целый ряд мероприятий:

2008 год - в рамках широкомасштабной акции «Казахстан – Эра Милосердия», под патронажем Фонда Первого Президента РК, Народно-демократической партии «Нур Отан» был собран круглый стол, в ходе которого впервые обсуждались все проблемы и аспекты помощи больным онкологическими заболеваниями. Участниками круглого стола стали общественные деятели, представители Министерства здравоохранения, врачи-онкологи Казахстана и ведущие онкологи г. Санкт-Петербурга, Россия. В первую очередь, обсуждалась численность и своевременность диагностики онкозаболеваний в Республике Казахстан. В тот же день был проведен благотворительный бал, сборы от которого составили 102 тысяч Евро. Целевое назначение средств, согласно целям и задачам Фонда – приобретение современного оборудования и обучение врачей.

2009 год - на средства Фонда было приобретено современное диагностическое оборудование для определения опухолевых маркеров и иммунного статуса больных – ИФА (иммуноферментный анализатор); а также функциональные кровати для отделения реанимации; компьютеры, вытяжные шкафы для лаборатории, все это оборудование установлено в Городском онкологическом диспансере г. Алматы. Создан сайт Общественного Фонда «Вместе против рака» для пациентов и врачей www.oncology.kz.

2010 год - Проведена серия мероприятий по профилактике рака среди населения: выпуск буклетов, листовок аудио- и видеоклипов, направленных на повышение знаний граждан о проблеме рака, факторах риска и методах самообследо-

вания и профилактики. Произведена организация выездов онкологов Городского онкологического диспансера г. Алматы на предприятия города, для проведения профилактических осмотров. Осуществлено сотрудничество с авторитетными международными организациями – ESMO (Европейская ассоциация онкологов) и ASCO (Американская ассоциация онкологов). Организованы несколько конференций: «Рак шейки матки - скрытая угроза обществу», «Проблемы ранней диагностики рака легкого». Практическим продолжением всех мероприятий явились тренинги и лекции (более 15) для специалистов Алматы и Алматинской области, а так же «дни открытых дверей» с участием врачей онкологов.

2011 год- 4 февраля проведена пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы против рака, с участием видных политических деятелей г. Алматы и Казахстана, спортсменов, артистов, врачей. Цель мероприятия – объединенными усилиями самых разных представителей казахстанского общества в очередной раз привлечь внимание населения к проблеме роста онкологической заболеваемости и призвать к посещению регулярных осмотров с целью профилактики

раковых болезней. На конференции были отмечены преимущества здорового образа жизни и отказа от табакокурения, а также важность психологического и духовного здоровья. В тот же день в ТРЦ «Мега-Алма-Ата» прошла акция по сбору подписей под всемирной противораковой декларацией и информированию населения о том, какие простые меры должен предпринимать каждый человек, чтобы защитить себя и своих близких от рака. Данное мероприятие высоко оценено UICC – Международным союзом по борьбе с раком – и удостоено бронзовой медали, предназначенной для членов организации. В сентябре 2011 года принято участие в «Марше Эйвон против рака груди», с организацией мобильной бригады маммологов с аппаратом УЗИ, а так же проведен круглый стол, с участием урологов г. Алматы, по проблемам диагностики рака предстательной железы.

На сегодняшний день работа ОФ «Вместе против рака» продолжается. Такие общественные организации являются важным социальным явлением, неотъемлемой частью стабильного и здорового общества, которое может решить многие проблемы, связанные с онкологическими заболеваниями.

СИСТЕМНАЯ РАДИОНУКЛИДНАЯ ТЕРАПИЯ КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ САМАРИЕМ-153 ОКСАБИФОРМ: ПРИНЦИП, ПОКАЗАНИЯ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Расулова Н.В., Арыбжанов Д.Т.

Республиканский Специализированный Центр Хирургии им. акад. В. Вахидова, Ташкент, Узбекистан. Южно – Казахстанский областной онкологический диспансер, Шымкент, Казахстан.

Метастатические поражения костей скелета, распространенная клиническая проблема в онкологии. У 60-90% онкологических больных на поздней стадии заболевания развиваются костные метастазы. Метастатический процесс в костях в большинстве случаев имеет множественный характер, что ограничивает возможность выполнения хирургического лечения или дистанционной лучевой терапии. В этих случаях целесообразно использовать радиотерапевтические остеотропные препараты.

Принцип: Остеотропные радиотерапевтические препараты, при внутривенном введении накапливаются в остеобластических или смешанных формах костных метастазах и одновременно облучают все очаги поражения. Радионуклид Sm-153 имеет период полураспада 46,2 часа, излучает бета-частицы с энергией 203,229 и 268 кэВ с выходами 35,43 и 21% соответственно, что достаточно для локального лучевого воздействия на очаги поражения, и гамма-кванты с энергиями 69,7 и 103 кэВ с выходами 5,4 и 28% соответственно. Соответствующее гамма-излучение дает возможность регистрировать накопление и распределение препарата с помощью гамма-камеры, а низкая энергия бета-частиц самария-153 приводит к значительному уменьшению нежелательной дозовой нагрузки на костный мозг. Отмечено, что при радионуклидной терапии не только снижается болевой синдром, но также отмечается снижение количества и интенсивности метастатических очагов.

Показания: Множественные метастазы в кости скелета (подтвержденные при сканировании костей скелета), болевой синдром.

Подготовка больного: Для выявления показаний и противопоказаний, а также определения приоритета терапии при позитивном сканировании костей скелета: 1.Общий расширенный анализ крови: с обязательным определением: гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, лимфоцитов, СОЭ; 2. Биохимический анализ крови с обязательным определением: АЛТ, АСТ, креатинина, мочевины, билирубина общего, билирубина прямого, ЛДГ, щелочной фосфотазы, кальция. Данные анализы должны быть определены до лечения, через 2 недели и 3 месяца от начала лечения. 3. При подозрении на угрозу или наличие патологического перелома позвоночника – МСКТ, в случае подтверждения диагноза – необходимо провести перкутанную вертебропластику, и после этого можно проводить

лечение Самарием-153 оксалиформом.

Противопоказания: абсолютное - беременность, лактация, относительные: почечная и/или печеночная недостаточность, тромбоцитопения (ниже 100 тыс./мкл), лейкопения (ниже 2 тыс./мкл), снижение уровня гемоглобина – ниже 90 гр/л, угнетение костномозгового кроветворения, предварительная массивная миелосупрессивная терапия, угроза компрессионного перелома позвоночника.

Возможные побочные действия: в течение первых 3 сут - тошнота (проходит самостоятельно или при приеме 1-2 таблеток метоклопрамида); в течение первых 2 нед - усиление болей за счет лучевой реакции тканей в очагах поражения (могут быть купированы приемом метамизола натрия или НПВП). Транзиторная миелосупрессия в течение 6-8 недель после введения Самария-153 оксалифора.

Сочетание с другой терапией: хорошо сочетается с бисфосфонатами, гормонотерапией, локальной лучевой терапией (8 грэй), биотерапией и таргетной терапией. Не рекомендуется проводить химиотерапию в течение 6-8 недель после радионуклидной терапии, а также начинать радионуклидную терапию раньше чем через 4 недели после проведенной химиотерапии. В случае, если необходимо проводить миелосупрессивную терапию после Самария-153 оксалифора раньше чем через 6-8 недель, такая терапия должна проводиться под строгим контролем и коррекцией гематологических показателей крови.

Мы имеем опыт лечения 185 больных с распространенными метастазами в кости скелета, из них 98 с раком молочной железы, 30 с раком простаты, рак легкого у 40, рак почки у 15 больных, у одного рак желудка и одна больная с меланомой. У всех пациентов после комбинированного лечения основного очага (операция + химиотерапия и/или лучевая терапия на первичном очаге) от 1 года до 7 лет отмечены метастазы в костях подтвержденные путем МРТ, КТ и скинтиграфии. Все больные получили системную радиотерапию Самарием-153 в сочетании с бисфосфонатами (Зомеи, Бонифос, Болдронат), часть больных получили химиотерапию и локальную лучевую терапию по показаниям. У 45% больных отмечена частичная регрессия или стабилизация костных метастазов, у 30% значительная регрессия, у 25% больных полная регрессия костных метастазов.

Считаем, что на сегодняшнем современном этапе терапии

больных с различными ЗНО с метастазами в кости применением системной радиотерапии Самарием-153 в сочетании с бисфосфонатами и химио-лучевой терапией является эффективным методом лечения этой сложной категории больных,

которая увеличивает выживаемость и качество жизни больных. Однако подход к лечению костных метастазов должен быть мультидисциплинарным и комплексным с обязательным участием, как врачей радиологов, так и онкологов.

СЛУЧАЙ ЭНДОМЕТРИОЗА ЛЕГКИХ, ИМИТИРУЮЩИЙ МЕТАСТАТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ

Махметов Б.Б., Кравчук В.А., Черняков С.С.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

Эндометриоз легких встречается крайне редко, в литературе единичные упоминания о случаях поражения легких. Упоминаемые в литературе симптомы и синдромы в нашем случае места не имели.

Пациентка Ж. 1967г.р. находилась в торакальном отделении ПООД с диагнозом: Экстрагенитальный эндометриоз с поражением ткани обоих лёгких. Артериальная гипертензия II, риск IV. НК I. Сахарный диабет II типа, средней степени тяжести.

Из анамнеза: выявлена при проф. осмотре, когда на ФГ ОГК выявлено образование в левом лёгком. Консультирована в ОПТД.: Киста? Заболевания левого лёгкого?. КТ ОГК: Признаки mts-поражения обоих лёгких, незначительного двустороннего плеврита. На предмет выявления первичного очага в ПООД проведено: осмотр онкогинеколога: Эндометриоз шейки матки. Киста левого яичника? УЗИ ОБП: Признаки жирового гепатоза, хронический бескаменный холецистит, хронический панкреатит, признаков плеврита нет. ФГДС: Хронический гастрит с гипотрофией слизистой, дуоденогастральный рефлюкс, обострение. Решением ЛКК направлена на ПЭТ. ПЭТ: ПЭТ-КТ картина выявила множественные округлые образования лёгких. RRS: Полип верхне- и нижеампулярного отделов прямой кишки, хронический наружный геморрой. Гистологическое заключение №12744 от 16.08.11г.: аденоматозный полип толстой кишки. Решением ЛКК направлена на диагностическую операцию. Прошла догоспитальное обследование: Консультация ЛОР: Хронический гайморит справа, вне обострения. Спирография: Нарушение функции внешнего дыхания по обструктивному

типу I степени. Консультация терапевта – Артериальная гипертензия II, риск IV. НК I. Сахарный диабет II типа, средней степени тяжести. Абсолютных противопоказаний к операции нет.

В 2003г. оперирована по поводу миомы матки, в 2007г. по поводу Грыжи позвоночника.

При поступлении общее состояние относительно удовлетворительное. Жалобы на умеренные боли между лопаток, иррадиирующие в левую руку. Физикально патологии не выявлено.

В плановом порядке произведена операция: Торакотомия слева, прецизионная резекция левого лёгкого. Гистологическое заключение: экстрагенитальный эндометриоз с поражением ткани лёгкого (Описание макропрепарата: 2 фрагмента ткани лёгкого с серыми плотными образованиями размером 1х1 см и 0,8х 0,5 см. На разрезе полости диаметром до 0,3 см. Микроскопическое описание: операционный материал представлен фрагментами ткани лёгкого с участками рыхлой волокнистой соединительной ткани. Среди соединительной ткани расположены множественные железы преимущественно округлой формы. Просвет большинства желёз кистозно расширен. Однорядный цилиндрический эпителий желёз без признаков атипии).

В нашем наблюдении было не типичное течение процесса, имитирующее метастатическое поражение легких. Проведенное обследование даже такое тщательное установить диагноз не позволило, только диагностическая торакотомия разрешила ситуацию.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ АДЕНОМИОЗА

Анфиногенова А.Г.

ГККП Лечебно-диагностический центр, Алматы, Казахстан

В диагностике эндометриоза как заболевания всего организма значение имеет информация, получаемая как общеклиническими методами обследования (нарушения самочувствия, их длительность, периодичность, цикличность, конкретная симптоматика, связанная с поражением того или иного органа как внутри малого таза, так и в других локализациях), так и специальными гинекологическими обследованиями, инструментальными, лабораторными и гистологическими методами.

Жалобы на диспареунию предъявляют 26-70% пациенток, страдающих генитальным эндометриозом, бесплодие-46-50%, анемия-70-80%. Признаками внутреннего эндометриоза являются: маточное кровотечение, дисменорея и изменения размеров матки. В настоящее время также признается, что одним из основных симптомов аденомиоза является нарушение менструальной функции: полименорея (у 56,1 % больных), скудные кровянистые выделения в пред- и постменструальном периоде у 35,2% больных, длительность менструации, составляющая 10-12 дней. Альгодисменорея более выражена при узловатой форме и встречается у 77,2% больных внутренним эндометриозом.

Одним из наиболее важных методов диагностики эндометриоза несмотря на широкое внедрение в практику сонографии и лапароскопии, является наряду с учетом особенностей клиники бимануальное объективное гинекологическое обследование.

Бимануальное исследование позволяет оценить величину матки, ее консистенцию, форму, характер поверхности, заподозрить наличие опухолевидных образований в области придатков матки, уплотнения в позадишеечной области и болезненность стенок малого таза при исследовании, а также спаечного процесса в малом тазу и обеспечивает ценную диагностическую и дифференциально-диагностическую (особенно от онкологических заболеваний) информацию. При эндометриозе влагалищной части шейки матки при осмотре видны эндометриозидные образования различной величины и формы (от мелко-точечных до кистозных полостей 0,7-0,8 см в диаметре темно-красного цвета). Использование кольпоскопии позволяет уточнить место и форму поражения эндометриозом влагалищной части шейки матки и слизистой оболочки дистального отдела цервикального канала. При локализации эндометриоза в проксимальной части слизистой цервикального канала наиболее ценные данные может дать цервикоскопия, произведенная с помощью фиброгистероскопа.

Одним из наиболее доступных и широко распространенных методов диагностики эндометриоза является ультразвуковой метод исследования. При внутреннем эндометриозе (корпорально-истмической локализации) диагностическая ценность сонографии составляет в зависимости от распространенности процесса 57-93%. При ретроцервикальной локализации эндометриоза точность правильного определения

наличия или отсутствия заболевания равняется 95%. При сочетании качественного и количественного (компьютерного) анализа гистеросальпингограмм точность диагностики узловой формы аденомиоза повышается до 93%.

Рентгенологическая картина при диффузной форме внутреннего эндометриоза характеризуется наличием «законтурных теней» различной длины и формы, которое зависит от локализации эндометриозных очагов. Длина теней может составлять от 2-4 мм до 1-2 см.

Из других рентгенологических методов наибольшую ценность имеет метод компьютерной томографии, позволяющей точно определить характер патологического процесса, его локализацию, взаимосвязь с соседними органами, а также уточнить анатомическое состояние полости малого таза, в частности при эндометриозных инфильтратах ретроцервикальной зоны и параметриев (79 и 77% соответственно), диагностика которых другими, в том числе и инвазивными методами затруднена. При внутреннем эндометриозе диагностическая ценность КТ существенно ниже -53% соответственно.

Наиболее информативными из неинвазивных методов является магнитно-резонансная томография, обеспечивающая благодаря высокой разрешающей способности МР-томографа отличную визуализацию органов малого таза и их структуры. Что особенно важно при аденомиозе.

Аденомиоз на Т1-взвешенных изображениях характеризуется изоинтенсивностью с окружающими тканями, однако, при этом четко обнаруживается некоторое количество пятен с высокой интенсивностью сигнала. Поражение с малой интенсивностью сигнала часто бывает изоинтенсивным с полосой низкой интенсивности и выглядит как локальное или диффузное утолщение этой полосы, т.е. поражение распространяется вдоль эндометрия и не деформирует полость матки.

МРТ позволяет правильно диагностировать внутренний эндометриоз и степень его распространения. Магнитно-резонансная томография позволяет правильно диагностировать внутренний эндометриоз и степень его распространения. С помощью МР-томографии выявлены нарушения маточной зональной анатомии. Определены диффузные и узловые формы аденомиоза. Узловая форма аденомиоза выглядит как образование в толще миометрия с сигналом низкой интенсивности без четких границ. Диффузная форма определяется как равномерное или неравномерное с гетерогенной интенсивно-

стью сигнала (зона усиления сигнала переплетается с зонами снижения, окружающие последние) увеличение вплоть до серозной оболочки зоны соединения, что не противоречит данным литературы. Поражение с малой интенсивностью сигнала часто бывает изоинтенсивным с полосой низкой интенсивности без четких границ в толще миометрия. В наших исследованиях степень распространения внутреннего эндометриоза мы определяли по утолщению переходной зоны и гетерогенности интенсивности сигнала последней.

Одним из самых точных методов диагностики эндометриоза в настоящее время считается лапароскопия. При диагностике эндометриоза яичников, например, этот метод обеспечивает точность 96%. При локализации гетеротопий на поверхности брюшины точность лапароскопической диагностики достигает 100%. Лапароскопия обеспечивает при этом возможность определения величины имплантатов, их количество, зрелости (по цвету и форме), активности. Недостатком метода являются трудности диагностики глубины инфильтративных форм гетеротопий, а, например, при внутриматочном эндометриозе его наличие лапароскопически может быть диагностировано только при поражении всей толщи матки с вовлечением серозной оболочки.

Все большее значение в диагностике эндометриоза приобретает определение в крови различных опухолевых маркеров. Наиболее доступным в настоящее время являются определение онкоантигенов СА-15, РЭА и СА-19-9, анализ которых осуществляется относительно несложным и безвредным методом иммуноферментного анализа (ИФА), а также определение РО-теста (универсального диагностического теста на опухолевый рост, основанный на фиксировании изменении параметров гемагглютинации, определяемой в реакции иммуно-СОЭ). Установлено, что в сыворотке крови у здоровых лиц концентрации онкомаркеров СА-15, СА-19-9 и РЭА составляют в среднем 8,3, 13,3 и 1,3 нг/мл соответственно.

Однако в некоторых нетипичных случаях, когда все другие данные отрицательны, диагноз эндометриоза устанавливается только на основе гистологического исследования тканей, полученных путем биопсии, например, при лапароскопии или в ходе хирургического удаления очагов.

Продолжение разработок новых органосохраняющих и функционально-щадящих радикальных методов лечения, является одним из их основных направлений современного развития отечественной онкологии.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ

Анфиногенова А.Г.

ГККП Лечебно-диагностический центр, Алматы, Казахстан

Сегодня для диагностики патологии миометрия в арсенале врача имеются все современные методы диагностики. Кроме сбора анамнеза и исследования местного статуса, среди методов инструментальной диагностики патологии миометрия (миомы матки, аденомиоза) широко применяются:

- ультразвуковое сканирование,
- гистероскопия,
- гистеросальпингография,
- компьютерная томография,
- компьютерная томография,
- магнитно-резонансная томография,
- лапароскопия.

Ультразвуковое сканирование представляет наиболее информативный метод диагностики миомы матки. Патогномоничными акустическими критериями миомы матки являются:

- увеличение ее размеров (84,5%),
- деформация контуров (66,7%),
- появление в стенках матки (или в ее полости) округлой или овоидной формы структур с меньшим волновым сопротивлением, чем у миометрия (100%).

Трансвагинальная ультразвуковая диагностика миомы матки подбрюшинной локализации не представляет значительных трудностей. Однако ее следует дифференцировать от опухоли придатков матки. Опухоль идентифицируется в виде образования округлой формы с повышенным уровнем звукопроводимости, плотно спаянного с маткой. Подбрюшинные узлы миомы матки на широком основании характеризуются следующими эхографическими признаками: акустическое отражение от поверхности опухоли, обращенной в брюшную полость, отличается повышенной звукопоглощаемостью и, следовательно, визуализируется менее отчетливо по сравнению с маточной поверхностью миоматозного узла. Кроме того, подбрюшинная миома матки осложняет сканирование расположенных за ней структур (яичников, петель кишечника, измененных маточных труб). При сканировании подбрюшинных узлов миомы использование высокочастотного трансвагинального эхоизлучателя с зоной фокусирования лучей в пределах 70-80 мм позволяет достаточно проследить снижение «видимости» изображения на экране ультразвукового прибора от маточной поверхности опухоли к брюшной стенке.

Отличительными особенностями подбрюшинных узлов яв-

ляются отсутствие эффекта «врастания» опухоли в миометрий, который регистрируется при опухолях на широком основании, а также подвижность опухоли по отношению к матке.

Ультразвуковая диагностика подслизистой или межмышечной миомы матки с центрипетальным ростом основывается на выявлении деформированного или смещенного М-эха. Для подслизистых узлов миомы характерно появление внутри расширенной полости матки округлой или овоидной формы образования с ровными контурами и средней эхогенностью. В отличие от полипов эндометрия узлы миомы обладают более высоким уровнем звукопроводимости.

Ультразвуковая диагностика межмышечной миомы матки с центрипетальным ростом основывается на визуализации деформированной полости матки в виде полумесяца с ровными контурами. При этом вблизи вогнутой поверхности маточного эха определяется образование с более низким акустическим импедансом, чем у неизмененного миометрия. В отличие от подслизистой миомы матки при центрипетальном росте опухоли наблюдается деформация М-эха, а патологическое образование идентифицируется на значительном протяжении мышечного слоя матки.

При миоме матки часто наблюдаются изменения микроциркуляции в кровеносных и лимфатических сосудах, отек и т.п. На эхограммах указанные процессы отражаются появлением в зоне локализации опухоли многочисленных «кистозных» структур, разделенных эхопозитивными перегородками. Также наблюдаются: появление внутри опухоли зоны с повышенной эхогенностью и без четких границ, визуализация анэхогенного образования, окруженного каймой с повышенным уровнем звукопроводимости, обнаружение по периферии опухоли феномена акустического усиления.

При пролиферирующих миомах матки на эхограммах визуализируются образования округлой формы с плотной капсулой и неоднородной внутренней структурой: в проекции фрагментов средней эхогенности регистрируются акустические зоны с диаметрально противоположной звукопроводимостью (эхонегативные участки чередуются с элементами плотной ткани). Анализ эхограмм показывает, что соотношение кистозного и плотного компонента этих опухолей варьирует в зависимости от степени выраженности пролиферативных процессов.

Сопоставление результатов ультразвукового сканирования и результатов морфологического исследования удаленных препаратов обнаружило высокую информативность (96,5%) этого метода. В 95,7% ультразвуковое сканирование способствовало выявлению подслизистой и межмышечной миомы матки с центрипетальным ростом, в 92%-узлов миомы с подбрюшинной локализацией.

В последнее десятилетие с целью уточнения характера внутриматочной патологии широко используется метод гистероскопии. Большинство авторов указывает на высокую диагностическую ценность этого метода для выявления подслизистых миоматозных узлов и узлов с центрипетальным ростом. Кроме того, с лечебной целью при помощи гистерорезектоскопии возможно удаление этих образований.

Гистеросальпингографию наиболее часто проводят у больных с подозрением на миому матки с центрипетальным ростом и при миоматозных узлах подслизистой локализации. При миомах с подслизистой локализацией получают характерные, ясные картины. Полость кажется большого размера, деформированной, с отчетливыми, но неправильными контурами. Внутри полости матки, центре или по краю, отмечается одна или несколько лакунарных картин, округленных, с четкими контурами, разных размеров.

При интерстициальных или субсерозных миомах рентгенологические картины менее убедительны.

Компьютерная томография применяется для дифференциальной диагностики субсерозных узлов миом с опухолями яичников, или для оценки миом больших размеров.

Компьютерно-томографическая картина миомы матки

может быть разнообразной и зависит от таких вторичных изменений, как гиалиновая дегенерация, кальцификация и некроз узлов. Наиболее частым симптомом миомы матки на компьютерном томографе является деформация контуров матки. Специфичный признак миомы – кальцификация, выявляющаяся на компьютерной томограмме в виде точечных участков с плотностью до $+800 + 1000$ Ед.Н.

Для определения внутренней архитектуры образования осуществляется построение гистограмм. Гистограмма отражает плотностную характеристику исследуемой ткани. Основные параметры, по которым анализируются гистограммы – это ширина основания графика, а также количество и высота пиков. Чем однороднее ткань, тем основание гистограммы уже и выше единственный пик. Если внутренняя структура неоднородная, то основание гистограммы занимает почти всю горизонтальную ось графика.

Миома матки обычно имеет однородную структуру, плотность которой колеблется от $+40$ до $+60$ Ед.Н. При отсутствии нарушения питания в узле, гистограмма характеризуется очень узким «основанием» и высоким «пиком» с плотностью около 45 Ед.Н.

Магнитно-резонансная томография позволяет получать изображения в 3-х взаимно-перпендикулярных проекциях – поперечной, фронтальной и в косых проекциях. МРТ хорошо определяет вид миом, количество узлов, их локализацию и вторичные изменения. При наличии лейомиомы на МРТ наиболее частая находка – деформация контуров матки, выраженное отграничение узлов от окружающего миометрия (ясно видна капсула узла). Лейомиома имеет на всех пульсовых отведениях умеренное снижение интенсивности сигнала. В случае кальцификации миома выглядит как образование с равномерно высокой интенсивностью сигнала, четко отграниченная кольцом низкой интенсивности от окружающего миометрия. Сниженная интенсивность сигнала на T2 – пульсовых отведениях, но средняя – на T1-взвешенных изображениях гистологически верифицирована как гиалиноз. Лейомиомы с высоким сигналом интенсивности на всех пульсовых отведениях морфологически похожи на некротическую ткань. Наиболее информативным для выявления лейомиом явились сагиттальные и фронтальные срезы.

Таким образом, МРТ диагностика при сочетанной патологии является высокоинформативным, неинвазивным методом диагностики, дающим четкую визуализацию органов и максимально свободным от субъективизма исследующего и позволяющая нам в 98,4% случаев поставить правильный диагноз.

Лапароскопия весьма эффективна при дифференциальной диагностике опухолей матки и придатков. Во время осмотра при подбрюшинных миоматозных узлах видны матка с гладкой ярко-розовой поверхностью и множественные миоматозные узлы, которые несколько бледнее, чем матка. Данный метод позволяет осуществить консервативную миомэктомию при наличии одного или нескольких субсерозно расположенных узлов, локализация которых позволяет удалить все узлы при лапароскопии. При проведении задней кольпотомии можно извлечь узел миомы до 7-8 см в диаметре. Миоматозные узлы диаметром более 7-8 см невозможно извлечь целиком через кольпотомное отверстие. Для их удаления применяются специальные инструменты – морцелляторы. Эти инструменты предназначены для фрагментации доброкачественной опухоли и удаления ее из брюшной полости по частям.

Таким образом, диагноз миомы матки на сегодняшний день можно поставить после проведения ректовагинального обследования и ультразвукового сканирования, особенно с цветовым доплеровским картированием. В трудных диагностических случаях, таких как субсерозный узел миомы, или миома больших размеров со вторичными изменениями в узле, которые нужно дифференцировать от опухоли яичника, применение компьютерной томографии и лапароскопии позволяют поставить правильный диагноз на дооперационном этапе.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНО-РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКОВ И ТЕЛА МАТКИ

Шакирова А.Ф., Дзюбина Т.С.

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан
ГКГП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан

Задачи исследования. Выявить и установить факторы, определяющие инвалидизацию и реабилитационный потенциал (РП) при раке тела матки и яичников.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 240 медицинских дел освидетельствования 129 больных раком тела матки и 310 медицинских дел освидетельствования 94 больных злокачественными опухолями яичников, пролеченных в ГКГП «КООЦ» за пять лет (2001-2005 гг.), 578 историй болезней данных пациенток, специально разработанных кодификаторов, включающих 81 позицию, касающиеся возраста, социального статуса, анамнестических данных, вопросов самого заболевания, его лечения, реабилитации и прогноза. Нами был применен корреляционный анализ всех параметров друг с другом с определением коэффициентов корреляции, направленностью связи и оценкой статистической достоверности, многофакторный дисперсионный анализ в программе ANOVA/MANOVA STATISTICA 5,0.

Результаты. Нами разработан принцип оценки ограничения жизнедеятельности в зависимости от выраженности функциональных нарушений при злокачественных опухолях яичников и тела матки согласно функциональным классам (ФК 1-4). При раке тела матки ФК1-2 имели 409 больных (63,2%), ФК3 – 204 пациенток (31,6%), ФК4 – 34 больных (5,2%). При злокачественных опухолях яичников ФК1-2 имели 60 больных (13,8%), ФК3 – 270 пациенток (62%), ФК4 – 106 больных (24,2%)

У больных раком тела матки высокий реабилитационный потенциал выявлен в 55,7% случаев, в то время, как у больных злокачественными опухолями яичников – всего 0,7% случаев. И наоборот, при раке тела матки процент низкого РП в два раза ниже, чем при опухолях яичников. Таким образом, у больных с опухолями яичников имеет место очень низкий РП.

Согласно проведенному корреляционному анализу по Спирмену группа инвалидности при раке тела матки достоверно зависела от стадии опухолевого процесса ($r=0,18$; $p<0,001$) и регионарных метастазов ($r=0,25$; $p<0,005$).

На основании проведенного корреляционного анализа по Спирмену реабилитационный потенциал при раке тела матки достоверно зависел от социальной категории ($r=0,15$; $p<0,018$), группы инвалидности ($r=0,13$; $p<0,003$), профессиональной реабилитации ($r=0,31$; $p<0,003$), ограничения трудовой деятельности ($r=0,35$; $p<0,00001$), поддерживающего лечения ($r=0,1$; $p<0,029$).

Согласно проведенному корреляционному анализу по Спирмену, группа инвалидности при опухолях яичников достоверно зависит от размера опухоли ($r=0,3$; $p<0,02$).

Согласно проведенному корреляционному анализу по Спирмену, реабилитационный потенциал при новообразованиях яичников достоверно зависит от наличия регионарных метастазов ($r=0,29$; $p<0,012$), хирургического лечения прогрессирования ($r=0,14$; $p<0,036$).

Выводы. При раке тела матки преобладают больные, имеющие ФК1-2 (63,2%), то при злокачественных опухолях яичников – пациентки, имеющие ФК3-4 (86,2%). Вышеизложенный анализ показал, что реабилитационный потенциал при раке тела матки, в основном, зависит от группы инвалидности, социального статуса больной и профессиональной пригодности, а также от терапии при прогрессировании опухолевого процесса. Реабилитационный потенциал при злокачественных опухолях яичников зависит от стадии заболевания, которая определяется наличием и количеством пораженных лимфатических узлов, и выполнения циторедуктивных вмешательств при прогрессировании опухоли и носящих паллиативный характер.

ВЛИЯЕТ ЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАНЦЕРОГЕННЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ?

Каримов М.А., Доскеева Р.А., Кенжалин Ж.Ш., Койшекенова Г.А.

Изучена заболеваемость злокачественными новообразованиями (ЗНО) населения в Восточно-Казахстанской области (ВКО), по данным областного онкодиспансера за 2004-2008 гг и загрязнение окружающей среды (ЗОС) канцерогенами двух классов: полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ) и тяжелыми металлами (ТМ). ЗНО изучалась по картам извещения о впервые зарегистрированных ЗНО (ф.090/У); ПАУ определялись по бенз(а)пирену (БП) на аппарате Флюорат-02-2М; ТМ, в частности кадмий (Cd), никель (Ni), свинец (Pb), кобальт (Co) на спектрофотометре С-301. Всего изучено 227765 карт первичных извещений, 82 пробы воды, 74 пробы почвы, 82 пробы растений, употребляемых населением области в пищу (пшеница, овес, ячмень, рожь, гречиха, кукуруза, подсолнух, картофель, свекла, морковь).

Общая ЗНО в ВКО составляла за пятилетие 276,7-264,5‰, тогда как по республике она составляла 192,6-182,6‰. Заболеваемость раком легких была -39,5-38,5‰ (по РК-25,5-22,4‰), раком кожи -42,3-37,3‰ (по РК-18,4-17,5‰), раком МЖ -22,3-28,3‰ (по РК-19,5-20,5‰), раком желудка -22,5-20,4‰ (по РК-18,9-16,8‰). За изученное пятилетие общая ЗНО и заболеваемость раком легких, кожи, желудка снизились, а раком молочной железы - повысилась.

Из всех изученных канцерогенов в зерне и овощах, употребляемых населением, предельно допустимые концентрации

(ПДК) превышали БП, Cd и Pb. Содержание БП в пшенице составляло 9,1-20,9 мкг/кг (9-20 ПДК), Cd - 0,19-0,27 мкг/кг (6-9 ПДК), Pb - 5,9-19,8 мкг/кг (8-9 ПДК). В овсе соответственно БП - 11-20 ПДК, Cd - 8-9 ПДК, Pb - 10-11 ПДК. В ячмене - БП содержалось в пределах 15 ПДК, Cd - 10 ПДК, Pb - 12 ПДК. Рожь «накопила» в себе БП на уровне 10 ПДК, Cd - 3 ПДК, Pb - 13 ПДК. В гречихе - БП - 11 ПДК, Cd - 6 ПДК, а свинца около 14 ПДК. Особо следует подчеркнуть, что в растениях (зерно), содержащих больше жира, БП был значительно больше, так как этот канцероген лучше растворяется в жирах. Так, в кукурузе содержание БП составляло 22 ПДК, а в подсолнухе - 24 ПДК, тогда как содержание Cd было примерно таким же, как и в других видах зерна - 9 ПДК, а свинца выше до 27 ПДК. Содержание БП в овощах также превышало его допустимый фоновый уровень, равный 5,0 мкг/кг и составляло: в картофеле - 5,6-20,3, в моркови - 2,1-15,5 мкг/кг, в свекле - 3,5-14,7 мкг/кг. Cd было в картофеле - 7 ПДК, в моркови - 4-7 ПДК, в свекле - 3-8 ПДК, Pb - в картофеле - 12-15 ПДК, в моркови - 12 ПДК, в свекле - 11-14 ПДК.

Проведенный расчет индивидуального и популяционного канцерогенного риска показал, что загрязнение воды, почвы и растений БП, Cd, Pb является источником канцерогенного риска низкого (10-4) и среднего (10-3) уровней. На первом месте по значению канцерогенного риска находится загрязнение овощей. Веществами, создающими максимальный канцерогенный риск, являются свинец и кадмий.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОПУХОЛЯХ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ

Култаев А.С., Ержанова Т.З., Сарсембаева С.А.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Для диагностики опухолей мочевого пузыря и предстательной железы применяются различные варианты ультразвуковой томографии – трансабдоминальная, трансректальная, трансагинальная и трансуретральная. Наиболее распространенным при диагностике опухолей мочевого пузыря является трансабдоминальное исследование. Ультразвуковая томография при раке предстательной железы должна применяться в комплексе с пальцевым ректальным исследованием и иммунологическими методами диагностики.

Цель работы: Эффективность применения ультразвуковой диагностики при опухолях мочевого пузыря и предстательной железы.

Материалы и методы: Исследование проводилось 75 пациентам с раком предстательной железы, и 58 пациентов с раком мочевого пузыря. Все пациенты осмотрены до начала лечения на аппарате «Viking 2400» (Дания), с использованием трансабдоминального датчика 3.5 мГц, трансректального датчика и трансуретрального датчика. Наиболее информативным методом при раке предстательной железы является трансректальное исследование с одновременной секстантной биопсией из 6 точек. Трансректальная биопсия под контролем УЗИ является общепринятым методом верификации. Трансуретральное УЗИ более информативно для определения глубины инвазии опухоли при раке мочевого пузыря. Обязательным этапом диагностического процесса при раке предстательной железы является трансабдоминальное и трансректальное исследование. Трансабдоминальное исследование не всегда дает полноценное изображение структуры предстательной железы, однако оно необходимо для оценки состояния печени, забрюшинных лимфатических узлов, состояния паравезикальной клетчатки, верхних мочевых путей, позволяет судить об объеме остаточной мочи. УЗИ является не только основным скрининговым методом, но и позволяет оценить первичную опухоль, регионарные лимфатические узлы, зоны отдаленного

метастазирования (печень, парааортальные лимфоузлы), а так же состояние верхних мочевых путей. Эти данные ультразвуковой томографии необходимы при поздних стадиях процесса, однако, кроме этого они совершенно необходимы для предлучевой подготовки и установления противопоказаний к лучевой терапии. Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальным датчиком позволяет получить информацию о структуре простаты, окружающих ее тканей и органов, наличии опухолевых очагов, их размерах, количестве и локализации, с помощью амплитудной гистографии определить плотность опухоли, а также прицельно взять биопсию из измененного участка железы. Ультразвуковая томография получила значительное распространение ввиду доступности аппаратуры и возможности применения при планировании лучевой терапии. Можно получить целесообразное распределение энергии излучения в облучаемом объеме только при помощи объемного планирования. Это дает возможность не только оптимизировать очаговую дозу, но и значительно уменьшить лучевую нагрузку на здоровые ткани. В нашем институте проводится научно-исследовательская работа с целью повышения эффективности лучевого лечения при раке мочевого пузыря и предстательной железы путем интенсификации лучевой терапии в режиме динамического фракционирования дозы облучения.

Результаты: 75 больным с раком предстательной железы выполнена трансректальная ультразвуковая томография в начале, в середине и в конце лечения. У 47 больных диагностировали полную резорбцию опухоли, у 28 дали частичную регрессию в конце лучевого лечения. 58 больным с раком мочевого пузыря у 50 больных дали полную резорбцию опухоли, а 8 пациентам выставили частичную регрессию процесса.

Вывод: Таким образом, ультразвуковая томография позволяет выбрать оптимальный план лечения и при необходимости его скорректировать.

ПРИМЕНЕНИЕ HIFU-ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ибраимбаев А. Д., Култаев А. С., Ахметжанова Б. С

Мед. центр АЛАС и К., Астана

КазНИИОиР

По прогнозам ВОЗ заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований до 2020 года во всем мире увеличится в 1,5-2 раза.

Рак предстательной железы (РПЖ) - злокачественное заболевание, занимающее 4 место среди всех онкологических заболеваний у мужчин. Чаще всего РПЖ болеют мужчины в возрасте старше 50 лет.

Одним из высокотехнологичных радикальных методов лечения РПЖ является HIFU-терапия — высокоинтенсивный фокусированный ультразвук. Это современная технология нового поколения, которая использует энергию ультразвуковых колебаний для нагревания глубоко лежащих тканей, не затрагивая при этом прилежащие здоровые ткани. Температура ткани в зоне фокусировки достигает 70-100°C менее, чем за одну секунду (!), что позволяет произвести абляцию пораженной ткани. Хотя термическое энергетическое воздействие происходит в течение менее одной секунды, оно хорошо управляется и регулируется в дозах. Окружающие ткани в радиусе 2 мм от зоны фокусировки остаются неповрежденными. Зоны фокусировки небольшие (2 мм x 3 мм 30 мм), выполняемые одно за другим воздействия позволяют увеличить объем опухолевой ткани, подвергшейся абляции (повреждению).

В медицинском центре АЛАС и К., г. Астана, за менее чем 2 года на установке FEP-BY 02 (Китай), с 2 преобразователями: «верхний» и «нижний», пролечено 15 больных РПЖ. Например: 1) больной Пасечник А. В, 69 лет, с д-зм: Рак предстательной железы (ПСА 13,9 нг/мл, болевой синдром, затрудненное мочеиспускание); После лечения (ПСА- 0,24нг/мл, мочеиспускание свободное, боли не отмечает)

2) больной Сабиров Б, 73 лет, с д-зом: Рак предстательной железы. Мтс в костях таза. До лечения - (V- предстательной железы - 41,1см3, ПСА 457 нг/мл, болевой синдром, затрудненное мочеиспускание, дизурия); После лечения (V- 15,9см3, ПСА- 0,2нг/мл, мочеиспускание свободное, боли не отмечает)

HIFU технология имеет ряд преимуществ: боль минимизирована (процедура неинвазивная), стоимость процедуры гораздо ниже в сравнении с другими методами, нет очевидных шрамов на теле, период восстановления несравнимо быстрее, чем после обычной хирургической операции, нет кровоточивости, ультразвук останавливает кровоточивость, терапия может быть применена необходимое количество раз, без ограничений по времени и дозировке.

Для организации HIFU-центра не требуется специализированных больших помещений, сложной технической подготовки

и развертывания стационара. Это означает, что для создания HIFU-центра достаточно помещения 25,0 – 75,0 кв.м. В день на одной установке FEP-BY (в АЛАС и К), в амбулаторных условиях возможно проведение лечения 10-15 пациентов.

HIFU терапия - бурно развивающаяся технология, которая быстро охватывает новые области применения в медицине, благодаря своей высокой эффективности, отсутствием побочных эффектов и невысокой стоимости. В ряде случаев HIFU-терапия является единственным методом лечения, который позволяет сохранять жизнь пациенту.

Список литературы:

1. Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Thun MJ. Cancer statistics,

2009. CA Cancer J Clin 2009; 59: 225-249

2. The Freedonia Group. Cancer therapies to 2009 – Market research, market share, market size, sales, demand forecast, market leaders, company profiles, industry trends, 2009.
3. Mylonas N, Ioannides K, Hadjisavvas V, Iosif D, Kyriacou PA, Damianou C. Evaluation of fast spin echo MRI sequence for an MRI guided high intensity focused ultrasound system for in vivo rabbit liver ablation. J Biol Sci Eng 2010; 3: 241-246
4. Beerlage HP, Thüroff S, Debruyne FM, Chaussy C, de la Rosette JJ. Transrectal high-intensity focused ultrasound using the Ablatherm device in the treatment of localized prostate carcinoma. Urology 199; 54: 273-277
5. Thüroff S, Chaussy C, Vallancien G, Wieland W, Kiel HJ, Le Duc A, Desgrandchamps F, De La Rosette JJ, Gelet A. Highintensity focused ultrasound and localized prostate cancer:

ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПО ОБЛАСТЯМ РЕСПУБЛИКИ

Сейтказина Г.Д., Имангалиева Н.Т., Сейсенбаева Г.Т.,

Ажмагамбетова А.Е., Петухов А.В.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗН) по областям Республики проведен за период 2000-2008 гг по трехлетним интервалам: первый – 2000-2002 гг., второй – 2003-2005 гг, третий – 2006-2008, а также по четырём регионам страны.

В Северный и Центральный регионы РК включены четыре области: Костанайская, Северо-Казахстанская, Ақмолинская и Карагандинская. В Западный регион вошли четыре области: Ақтөбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская и Мангистауская. Южный регион представлен четырьмя областями: Алматинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской. Восточный регион – это две большие области: Восточно-Казахстанская и Павлодарская.

За исследуемый период зарегистрировано 227765 больных онкопатологией. Изучение экстенсивных показателей злокачественных новообразований по регионам выявило, что удельный вес был неодинаковым и колебался в пределах с 15,9% (Восточно-Казахстанская область) до 1,8% (Мангистауская область). Анализ данных по распространению заболевших онкопатологией показал, что наибольший удельный вес ЗН был в Северном и Центральном регионах, составив 35,1%, затем в Южном – 25,6%, третьим определился Восточный – 23,7% и наименьшее число первично заболевших ЗН было в Западном регионе – 15,5%.

При изучении интенсивных показателей (ИП) выявлено иное ранжирование онкоситуации в регионах по заболеваемости ЗН. Самые высокие показатели заболеваемости злокачественными опухолями зарегистрированы в Восточном регионе, составив 271,9 на 100 тысяч населения (‰). Вторым рангом стоят Северный и Центральный регионы с интенсивным показателем 240,3‰, третьим рангом – показатели Западного – 201,3‰ и самая низкая заболеваемость была в Южном регионе – 128,6‰. Изучение заболеваемости ЗН по 3-летним периодам показало по Центральному региону: в Ақмолинской обл заболеваемость снизилась с 229,3 до 220,4‰, в Карагандинской обл – с 225,1 до 217,8‰; по Северному региону: в Костанайской обл заболеваемость повысилась с 233,5 до 254‰, в СКО – с 233,0 до 234,2‰, по Западному региону: в Атырауской обл – понижение ИП со 148,5 до 134,1‰, в Ақтөбинской обл – повышение со 156 до 163,7‰, ЗКО – с 208,7 до 209,1‰, в Мангистауской обл – понижение со 135,2 до 118,9‰, по Южному региону: в ЮКО – понижение с 99,7 до 90,9‰, по КЗО – 150,7 до 145,9‰, в Жамбылской обл – 132,9 до 122,4‰, по Алматинской обл – 142,6 до 128‰, по Восточному региону: ВКО – стабильно ИП 262,1 - 261,6‰, по Павлодарской обл понижение ИП с 233,0 до 264,8‰.

ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

М.А.Каримов

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Как известно, существует два основных вида профилактики заболеваний злокачественными новообразованиями (ЗН): первичная - предупреждение возникновения ЗН, связанное с этиологическим фактором, и вторичная – выявление ранних стадий ЗН и предупреждение предраковых заболеваний. Второй путь профилактики зависит от ранней диагностики, связанной с обращаемостью больных, т.е. их информированностью, организованностью, и квалификации врачей, диагностирующих болезнь. Первичная профилактика – это выяснение причин, вызывающих ЗН и их устранения. Последнее зависит во многом от руководителей предприятий, загрязняющих окружающую среду канцерогенами, для чего необходимо выделять средства для создания дымоуловителей и очистных сооружений, сточных вод. Контроль должен осуществляться природоохранными учреждениями, министерством экологии и здравоохранения, правительством.

Изучалось содержание канцерогенов в питьевой воде в Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Ақмолинской областях. Река Иртыш загрязнена канцерогенами классов полициклических ароматических углеводородов, (ПАУ по БП) и тяжелыми металлами (ТМ, индикаторный Cd), превышающими ПДК 3-6 раз. Источниками интенсивного загрязнения реки являются малые реки - Шарафка (БП6ПДК), Глубочанка (12ПДК), Березовка (29ПДК). Уровень загрязнения вод Восточного региона ВКО выше, чем Семейского. Река Ишим в регионе Астаны загрязнена БП (6ПДК), ТМ-Cd (8ПДК). Исследования воды до и после прохождения через очистные сооружения показали, что во всех случаях содержание канцерогенов двух классов ПАУ и ТМ после очистки питьевой воды было не меньше, а даже больше, чем до очистки. Это свидетельствует о роли применяемых адсорбентов очистки воды, которые необходимо периодически заменять. Во всех областях, по-

видимому, очистные сооружения долгие годы не заменялись, и накопившиеся в адсорбентах канцерогены, поступают из них в протекающих через них воду. Необходимо требовать от

собственников очистных сооружений модернизировать их, а это обязанность природоохранных органов и министерств.

ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ФОРМАМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПО ОБЛАСТЯМ РЕСПУБЛИКИ

Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И., Имангалиева Н.Т., Сейсенбаева Г.Т.,

Ажмагамбетова А.Е., Петухов А.В.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Заболеваемость основными формами (рак легкого и кожи, рак молочной железы и рака шейки матки) злокачественных новообразований (ЗН) изучена в динамике за 2000-2008 гг по четырем регионам РК.

Уровень заболеваемости ЗН представился следующими рангами:

Западный регион: При раке легкого на 1-ой позиции по рангу Западно-Казахстанская область (29,5‰); 2-ой – Актыбинская (26,3-19,9); 3-ей – Атырауская (18,7-16,9) и 4-ой – Мангыстауская (13,7-10,8). При раке кожи 1-ой была Актыбинская (12,6-13,6); затем – ЗКО (15,3-12,2); Атырауская (7,4-5,6) и Мангыстауская (5,0-4,1). При РМЖ 1-ый ранг за Западно-Казахстанской областью (17,1-21,5‰); затем – Актыбинской (14,4-19,6); Атырауской (7,6-14,9) и Мангыстауской (16,8-12,2). При РШМ на 1-ой позиции Атырауская область (13,2-20,1); затем – Актыбинская (12,8-16,1); ЗКО – (12,7-14,9) и Мангыстауская (6,9-10,4‰) области.

Южный регион: При раке легкого 1-ый ранг за Кызылординской (24,4-17,1‰) затем – Жамбылская (17-15,9); Алматинская (19,4-15,5) и ЮКО (13,0-6,0). При раке кожи 1-ой была Жамбылская (13,4-10,4); затем Алматинская (14,8-9,8); ЮКО (7,2-8,2) и Кызылординская (8,6-7,7‰) области.

При РМЖ ранговое расположение было: Алматинская (19,1-14,5); затем Жамбылская (14,5-13,7); Кызылординская (7,5-11,6), ЮКО (9,7-9,6‰). При РШМ 1-ый ранг за Алматинской (13,6-16,2); затем Жамбылской (14,9-13,4); Кызылординской (8,8-12,0) и ЮКО (8,1-11,0‰).

Северный регион: При раке легкого 1-ой была СКО (49,3-36,8); затем Акмолинская (43,8-35,4); Костанайская (34,5-32,6). При раке кожи Костанайская (20,1-25,2); затем СКО (18,1-24,8); Акмолинская (15,5-21,7). При ранжировании РМЖ большая распространенность наблюдалась в Акмолинской (19,1-23,5); затем Костанайской (18,1-26,5); СКО (16,0-21,8). При РШМ – Костанайской (15,6-19,7); затем СКО (12,8-11,7); Акмолинской (18,6-16,3‰) областях.

Восточный и Центральный регионы: Ранжирование при раке легкого было следующим: 1-ой была ВКО (41,8-37,3); затем Павлодарская и Карагандинской (32,4-36,5) и (33,7-27,8) области. Рак кожи был высоким в ВКО (35,9-37,3); затем в Карагандинской и Павлодарской (26-35,9) и (23,6-22,1‰) областях. При РМЖ - в Павлодарской (24,5-33,7); затем Карагандинской (21,9-26,1) и ВКО (22-30,3). РШМ - в Павлодарской (16,3-19,7); затем ВКО (12,8-17,0); Карагандинской (13,2-17,3‰) областях.

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСERA, КАК ЗАЛОГ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Рынкевич Н.В.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

Укрепление материально – технической базы, внедрение новых, передовых технологий и разработок в онкологических диспансерах позволит улучшить основные онкологические показатели и эффективность проводимой онкологами работы.

За годы независимости Республики Казахстан, когда в жизнь активно воплощаются программы развития и реформирования здравоохранения, материально-техническая база онкологического диспансера Павлодарской области заметно укрепилась. Онкологические заболевания относятся к социально-значимым, поэтому приоритетное развитие получил процесс обновления аппаратов для диагностики и лечения злокачественных новообразований.

За период 2006 - 2010гг. полностью обновлен парк аппаратов для проведения лучевой терапии. Так, в 2006г. введена пристройка к радиологическому корпусу, в которой смонтирован ротационный гамма-терапевтический аппарат «Рокус АМ», приобретенный из средств Республиканского бюджета. В 2009г. из средств Республиканского бюджета радиологическое отделение оснащено рентгеновским симулятором Terasix (Чехия). Аппарат предназначен для определения локализации очагов злокачественных новообразований при составлении плана облучения и для проведения симуляции индивидуальных планов. Кроме того, в отделении смонтирован аппарат для близкофокусной рентгенотерапии GULMAY D3150 (Великобритания), использующийся для лечения поверхностно расположенных опухолей кожи и мягких тканей. Система аппарата включает в себя интегрированную систему безопасности для минимизации возможных ошибок, гаранти-

рует выдающийся клинический эффект. Аппарат для внутриполостной терапии MULTISOURCE, поступивший в отделение также в 2009г., позволяет проводить лечение опухолей шейки и тела матки, влагалища и прямой кишки, а также даёт новые возможности для брахитерапии при раке молочной железы, языка, пищевода, бронхов. Наличие в отделении клинического дозиметра «DOSE 1», также приобретённого в рамках централизованного закупа Министерством здравоохранения Республики Казахстан, позволяет проводить лучевую терапию в соответствии с международными требованиями с технологическому процессу. Ежегодно в отделении проходят лечение свыше 1000 пациентов с наличием злокачественных опухолей различной локализации.

В отделении лучевой диагностики с 2006г. функционирует маммографический аппарат «Alpha ST». На аппарате проводится маммографический скрининг прикрепленного населения близлежащих районов области.

В июле 2011г. в диспансере начал функционировать кабинет компьютерной томографии. Аппарат также приобретён из средств Республиканского бюджета.

Компьютерный томограф «Philips Brilliance CT» (16-срезовый) – мультисрезовый компьютерный томограф, позволяет проводить исследование различных органов и систем человеческого организма путём послойного сканирования.

В патоморфологической лаборатории с 2010г. проводятся иммуногистохимические анализы при раке молочной железы, которые позволяют проводить таргетную терапию.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СЕМИОТИКА МАГИСТРАЛЬНЫХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ

Сирота В.Б., Цаюкова Н.А., Чапаган Д.А.,

Евстафьев Е.Б., Дзюбина Т.С., Панибратец А.П., Шерстов С.Ю.

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан

КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан

Задачи исследования: выявление информативности результатов УЗ-методов исследований с целью ранней диагностики флеботических осложнений полихимиотерапии (ПХТ) рака молочной железы (РМЖ).

Материалы и методы исследования. В исследование включены 62 пациентки РМЖ, средний возраст 56,2 года, получавших лечение в Карагандинском ООД в 2011 году. Первая стадия РМЖ диагностирована у (43,5±6,3)% больных, IIa стадия – у (37,1±6,1)%, IIb стадия – у (12,9±4,3)%, IIIa стадия – у (4,8±2,7)%, IIIb стадия – у (1,6±1,6)% пациенток. На момент обследования (53,2±6,3)% больных получали неоадьювантную ПХТ от одного до трех курсов, (30,6±5,9)% пациенток были после комбинированного, (16,1±4,7)% – после комплексного лечения. Инструментальное исследование включало ультразвуковое дуплексное и триплексное сканирование сосудов, которое выполнялось на УЗ-сканерах SonoAse (Medeson) с использованием конвексных датчиков 3,5-6,5 МГц и линейных датчиков с частотой 5-9 МГц. Ультразвуковое исследование выполнялось как минимум трижды во время нахождения в стационаре, а также спустя 2, 3 и 6 мес. после выписки. При ультразвуковом обследовании вен нижних конечностей больных РМЖ определяли следующие параметры: увеличение просвета вены и толщины стенки более, чем в два раза, компрессивность вены, визуализацию тромба, пробу Вальсальвы.

Результаты. Из 62 обследованных больных у 22 пациенток диагностировали тромбоз вен нижних конечностей. При ультразвуковом дуплексном сканировании в норме вены нижних конечностей характеризовались эхонегативным просветом. В некоторых случаях при медленной скорости кровотока наблюдали эффект «спонтанного контрастирования просвета» в виде перемещения скоплений форменных элементов крови. Толщина стенок вен не превышала 2 мм, их внутренняя поверхность была гладкой, без пристеночных наложений. Часто

в просвете вен визуализировались створки клапанов. Диаметр просвета вены при спокойном дыхании в положении лежа был больше диаметра корреспондирующей артерии, но превышал ее двух диаметров. Просвет крупных вен немного изменялся в соответствии с дыхательными движениями. Спонтанный кровоток регистрировался в крупных и средних венах нижних конечностей. В мелких венах, таких как вены голени и стопы спонтанный кровоток в большинстве случаев отсутствовал и регистрировался только при дистальной компрессии или компрессии датчиком. В венах нижних конечностей регистрировался фазный кровоток, соответствующий дыхательным циклам.

Практически у всех больных выявлены ультразвуковые характеристики сосудистой патологии вен нижних конечностей: у (35,5±6,1)% пациенток – увеличение просвета и толщины вены более, чем в два раза и положительная проба Вальсальвы, у (38,7±6,2)% – визуализация тромба и у (66,1±6,0)% – компрессивность вены.

У больных РМЖ на фоне проводимой комплексной терапии выявлена достоверная прямая корреляционная зависимость между возникновением тромбоза вен нижних конечностей и стадией опухолевого процесса ($p < 0,0000006$), группировкой по системе TNM ($p < 0,000009$), химиотерапией по схеме CMF ($p < 0,0003$) и лучевой терапией ($p < 0,00004$), а также при увеличении просвета вены более, чем в два раза ($p < 0,002$), утолщении стенки вены более 2 мм ($p < 0,002$), положительной пробе Вальсальвы ($p < 0,002$), отрицательная корреляционная зависимость – при положительной компрессивности вен ($p < 0,003$).

Выводы: Показатели УЗТ исследования сосудистой стенки являются информативными УЗ-критериями тромботических осложнений вен нижних конечностей у больных РМЖ.

ФАКТОРЫ РАССТРОЙСТВ АДАПТАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ КОРРЕКЦИИ

Афонин Г.А., Толстикова А.Ю.

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии МЗ РК

Онкологические больные представляют собой особую группу пациентов, обнаруживающих нарушения адаптивных механизмов, возникающие в ответ на диагноз злокачественного новообразования или как следствие длительного противоопухолевого лечения. Соответственно подход к коррекции таких состояний должен быть дифференцированным, но всегда ориентированным в первую очередь на личность пациента и его ближайшее окружение. Терапия расстройств психической сферы определяется принципами паллиативной медицины, где учитывается ряд факторов: стадия заболевания, перспективы для больного и улучшение качества жизни. Психотерапевтическая работа с данной группой пациентов может касаться экзистенциального полюса рассматриваемой проблемы, поведенческого звена, телесно-ориентированной направленности, развития духовных практик.

Терапия психотических вариантов изменений в психике с наличием расстройств сознания имеет соматогенную направленность. Это в первую очередь дезинтоксикационная терапия, применение гормонов при явлениях отека мозга и ней-

ролептиков для снятия возбуждения и тревоги. Применяются и препараты, купирующие болевые пароксизмы. Поскольку большинство онкологических больных беспокоят психосоциальные нарушения, очевидна необходимость информационной и психологической поддержки этого контингента пациентов. Такая поддержка может заключаться в следующем:

- Принятие адекватных решений в отношении скрининга и лечебных процедур.
- Управление (там, где это возможно) нежелательными и побочными эффектами лечения.
- Изменение связанных со здоровьем особенностей поведения (таких как отказ от курения, рациональная диета или физическая активность),
- Улучшение психосоциального благополучия.

Большинство психологических вмешательств сосредотачивает внимание на улучшении эмоционального благополучия пациента путем модификации факторов нарушения адаптации. Пациенты могут получать возможность по-разному оценивать стрессовые ситуации, тем самым фокусируя внимание на

только на негативных аспектах болезни, но также обращая внимание на позитивные стороны жизни. Вместо концентрации внимания на неконтролируемых аспектах заболевания (таких как течение опухолевого процесса и его прогноз) пациентов можно стимулировать к поиску ситуаций, или переключения внимания на другие сферы жизни (такие как работа или семья) – включение экзистенциального и когнитивно-поведенческого звеньев.

Доказано, что психосоциальные вмешательства – как индивидуальные, так и групповые, эффективны в улучшении психоэмоционального благополучия пациента. Большинство вмешательств основываются на образовательных и познавательных поведенческих перспективах, тем самым фокусируя

внимание больного на текущих проблемах, позитивно воздействуя на мысли, эмоции и поведение, устраняя тем самым иррациональные мысли и модели поведения. У пациентов онкологического профиля психоэмоциональные нарушения, возникающие в результате заболевания и лечения, часто взаимодействуют с существующими проблемами индивидуального характера (особенности личности, наличие травмирующих психических ситуаций в прошлом, наличие в анамнезе депрессий, сопутствующих тяжелых соматических заболеваний). Эти факторы также необходимо принимать во внимание при рассмотрении вопроса коррекции психоэмоционального и реабилитационного потенциала онкологического больного.

ФИБРОЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ГЛОТКИ

Мустагалиева А.С.

Атырауский онкологический диспансер. Махамбетская ЦРБ

Цель исследования: провести анализ фиброэндоскопического (ФЭС) исследования опухолей глотки.

Материалы и методы исследования: фиброэндоскопическое исследование проведено у 126 больных.

Результаты: злокачественные опухоли ротоглотки составили – 37 случаев (29,4%), носоглотки – 31 (24,6%) и гортаноглотки – 58 (46,0%). Средний пик заболеваемости находится в возрастной группе 51-60 лет, а средний возраст составляет 49,4±4,4, соотношение мужчин и женщин 3:1.

ФЭС исследование при новообразованиях ротоглотки нет необходимости проводить, за исключением случаев с подозрением на поражение задней поверхности небной занавески. Исследование носоглотки позволило определить форму роста опухоли (23,73% – экзофитная, 18,64% – эндофитная, 57,63% – смешанная). У 4 больных обнаружена клинически не определяемая опухоль при наличии шейных метастазов и у 2 исключен диагноз злокачественного новообразования. ФЭС исследование у больных опухолями гортаноглотки показало, что данная методика позволяет в деталях оценить состояние слизистой оболочки перепончатого (проксимального) отдела – состояние передней, медиальной и наружной стенок, дна грушевидного синуса, отделить дифференцировать от новообразования шейного отдела пищевода. Однако хрящевой (дистальный) отдел, зажатый между печаткой перстневидного

хряща и телами шейных позвонков, недоступен для данного вида исследования.

Закключение:

Показаниями для проведения фиброэндоскопического исследования могут служить:

- подозрение на злокачественную опухоль в той фазе, когда она не имеет выраженных субъективных и объективных симптомов;
- необходимость проведения четкой топической диагностики и определения формы роста;
- возможность определения границ распространения опухоли, что позволяет спланировать рациональную тактику лечения;
- исключить наличие злокачественной опухоли или от дифференцировать злокачественный процесс от других заболеваний.

Фиброэндоскопическое исследование может широко использоваться при любом подозрении на «злокачественную опухоль» и решает ряд серьезных задач:

- о наличии или отсутствии патологического процесса;
- оценить форму роста опухоли;
- оценить исходное место роста опухоли и распространение на различные элементы глотки;
- выявить изъязвление и другие параметры.

ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА ЛЕГКОГО В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шериева Т. М.

ЦЦЛ, КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда

Задачи исследования: анализ цитоморфологической верификации рака легкого (РЛ) в Карагандинской области.

Материалы и методы исследования. Проанализированы данные медицинской документации 1989 больных РЛ, обследованных и пролеченных в условиях ООД за период 1981-2005гг. Применялись клиничко-лабораторные, рентгенологические, эндоскопические, ультразвуковые и цитоморфологические исследования. По мере необходимости больным назначались трансторакальные, плевральные пункции, пункции л/узлов и др. (при подозрении на метастазы РЛ). Все больные, направленные в ООД с диагнозом РЛ (подозрение на РЛ) на первом этапе проходили обследование в поликлинике ООД с целью подтверждения диагноза – верификацией опухолевого процесса. При невозможности верификации, больные госпитализировались и материал с опухоли бронхов (легкого, л/узлов) брался интраоперационным методом во время операции.

Результаты. За последние 3 года (2008-2010гг.) заболеваемость РЛ по области составила 27,6; 27,1 и 25,4 на 100 тысяч населения. За 2008-09гг. процент цитоморфологической

верификации РЛ на нашем региону составил 75,5 и 79,4%, заняв первые места по РК, тогда как по Казахстану показатели составили всего 57,7 и 55,8% соответственно. За последние годы цитоморфологическая верификация всех опухолевых процессов по КООД занимает первые места в рейтинге ООД РК по верификации рака.

Среди перечисленных методов исследований больным с центральными формами РЛ назначались ФБС с цитоморфологическим исследованием материала. ФБС проводилась 1014 больным РЛ, 27 – ФБС была противопоказана, 31 больной отказался от исследования. Из числа обследованных, в 459 случаях верифицированы раки (23,1%). Самым распространенным был плоскоклеточный рак – 321 случай (16,1%). Редко встречался солидный рак – 3 случая (0,2%), в 9 случаях высказано подозрение на рак (0,5%). Процесс распада выявлен у 4 больных РЛ, в 542 случаях материал оказался неинформативным (27,3%).

При трансторакальных пункциях из 317 случаев (15,9%) в 184 выявлены раки (9,3%), в 127 (6,4%) материал оказался неинформативным. Исследование интраоперационного материала

в 317 случаях (14%) при РЛ показало наличие злокачественного процесса у 263 пациентов (13,2%), во всех остальных случаях в ЦЦЛ доставлялся некачественный материал (14 - 0,7%). Исследование л/узлов и др. материала (другое легкое, кожа, мягкие ткани, печень и т.д.) выявило из 343 случаев (19,3%) в 267 наличие опухоли (13,5%).

Всего в 1173 случаях (59,1%) доказаны злокачественные процессы. Бесспорно, что процент цитоморфологической верификации при РЛ оказался бы намного выше, если бы исследуемый материал был адекватного образца и хорошего качества, и брался именно с опухолевой ткани (подозрительного очага). Но, как показывает практика, численность некачественного материала, к сожалению, увеличивается из года в год, что снижает процент

верификации и соответственно показатели работы не только ЦЦЛ, но и всего ЛПУ. Качество материала ведь зависит не только от опыта и навыка врача-эндоскописта и цитоморфолога, но и от наличия соответствующего высококачественного оборудования, условий работы, отсутствия перегруженности врачей и др., что не всегда соблюдается в повседневной работе.

Выводы: цитоморфологическое исследование является доступным, технически несложным методом исследования и помогает верифицировать злокачественный процесс. Для увеличения эффективности верификации необходимо в первую очередь улучшение качества материала, доставляемого в лабораторию на исследование.

ЭНДОВИДЕОТОРАСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Макаров В. А., Нурманов С. Р.

Городской Онкологический Диспансер, г. Алматы

Актуальность: современные клинко-инструментальные методы исследования в большинстве случаев позволяют поставить точный топический диагноз, но выбор тактики лечения может основываться только при морфологическом подтверждении диагноза.

Цель: улучшить результаты лечения больных с патологией органов грудной клетки.

Материалы и методы: в отделении торако-абдоминальной хирургии (зав. отд. – к.м.н. Нурманов С. Р.) – в период 2009-2010 гг. Произведено 35 эндовидеотораскопических оперативных вмешательств.

Возраст больных варьировал от 23 до 75 лет.

С диагностической целью – проведено 22 операции. Удаление лимфоузла средостения или его биопсия – 8 случаев. Ревизия плевральной полости с биопсией плевры – 10 случаев. Биопсия опухолей легкого – 4 случая.

За описанный период с лечебной целью проведено – 13 оперативных вмешательств.

Прецизионных резекции по поводу периферических образований легкого – 5, краевая резекция легкого – 1, резекции образования париетальной плевры – 3. Удаление кисты средостения – 1. При этом морфологическая характеристика составила: доброкачественная опухоль – 2 случая, метастатический опухолевый процесс 3 случая, продуктивное воспаление – 6 случаев, геморрагический инфаркт легкого – 1 случай, кистозное образование легкого – 1 случай.

В 2-х случаях у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией, и при непереносимости одноклеточной вентиляции, эндовидеотораскопию выполняли под местной инфильтрационной анестезией. В одном случае в положении пациента на боку, в другом в полусидящем положении. Самочувствие пациента оценивалось вербально, и при необходимости местная анестезия потенцировалась внутривенным введением анальгетиков (метамизол 50% 2,0). В 3-х случаях из описанных 35 произведен лечебный плевродез инсуффляцией порошка талька.

Причинами перехода к открытой операции были: внутриплевральное кровотечение – 1, неинформативность биопсии – 1, невозможность тораскопического удаления опухоли вследствие ее распространенности.

Выводы: Более широкое внедрение в практику эндовидеотораскопии позволяет максимально точно определить стадию онкопроцесса и соответственно – тактику лечения. При периферических доброкачественных опухолях легкого произвести радикальное удаление патологически измененной ткани различными оперативными методами (прецизионная или краевая резекция). При выявлении распространенного процесса, канцероматоза плевральной полости осложненного злокачественного плевритом или без него – удается произвести паллиативную лечебную процедуру в виде плевродеза, техники наложения которого различны, при этом наиболее эффективным является инсуффляция порошка талька.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ

Ормонова Ж.А., Жумабаев А.Р.

Ошский межобластной центр онкологии, г. Ош Кыргызская Республика

В последнее десятилетие рак шейки матки (РШМ) стал ведущей формой онкологической патологии у женского населения Кыргызской Республики. РШМ по частоте поражения занимает первое место среди новообразований женских половых органов. Частота выявляемости этой локализации среди лиц с впервые в жизни установленным диагнозом выросло с 8,8 % в 2003г. до 12,1 % в 2007г., а стандартизованные (мировой) показатели с 11,0 до 15,60/0000 населения.

Материалом для проведения ретроспективного анализа результатов комбинированного лечения (хирургическое и лучевое лечение) РШМ послужили данные 33 больных, находящихся на диспансерном учете и лечении в Ошском межобластном центре онкологии. По возрастным группам распределились следующим образом: до 29 лет – 3(9,1%); от 30 до 39 лет – 7(21,2%); от 40 до 49 лет – 19(57,6%); от 50 до 59 лет – 3(9,1%);

от 60 до 69 лет – 1(3,%). Диагнозы злокачественного процесса подтверждены морфологически. Из 33 больных, получивших полный курс комбинированного лечения, РШМ Ia (T1aNoMo) стадии был выявлен у 1 (3,03%) женщины, Ib (T1bNoMo) стадии – у 4 (12,1%) женщин, IIa (T2aNoMo) стадия – у 23 (69,7%) женщин, IIb (T2bNoMo) стадия – у 2 (6,06%) женщин и IIIa (T3aNoMo) стадия – у 3 (9,1%) женщин. Наилучшие одно-, трех- и пятилетние отдаленные результаты достигнуты при раке I стадии составляя 99+0,06%. При II стадии заболевания пятилетняя выживаемость составила 82,5+0,08% и III стадии заболевания – 78,5+0,07%.

Таким образом, полученные нами отдаленные результаты лечения РШМ свидетельствуют о преимуществе использования комбинированного метода лечения.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Чингисова Ж.К., Оспанов М.А.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

За изучаемый период зарегистрировано 15585 больных злокачественными новообразованиями (ЗН) в Акмолинской области, что составляет 5,9% по отношению данных республики, из них 7300 ЗН среди женского населения.

Проведен анализ заболеваемости ЗН и отдельных форм (РМЖ, РШМ и РТМ) по трехлетним интервалам за 2000-2008 гг. Общая заболеваемость имела тренд снижения с 234,6‰ (2000-2002 гг.) до 219,4‰ в последнем периоде (2006-2008 гг.). Аналогичные изменения отмечены при стандартизации показателей заболеваемости мировым стандартом (СП- 221,0‰- 202,8‰).

Однако анализ интенсивных (ИП) и стандартизованных (СП) показателей заболеваемости женского населения выявил, что ИП выросли с 151,9‰ до 208,6‰ в 2005-08 гг, тогда как СП снизились с 248,0‰ до 162,0‰.

Заболеваемость раком молочной железы. Заболевших РМЖ в этот период было 1517 женщин. ИП заболеваемости РМЖ женского населения области за период исследования свидетельствуют, что в первые 3 года ИП колебались, имея высокие данные в 2000 году 19,4‰ и ростом до 21,3‰ в 2003 году. Последующие 3 года показатели выросли до 27,3‰ в 2004 году с последующим снижением до 19,9‰

в 2006 г, и вновь рост до 23,5 в 2008 году.

Заболеваемость раком шейки матки. Число заболевших РШМ было 629 больных. В первый временной период (2000-2002 гг) заболеваемость РШМ по среднегодовым ИП снизилась с 18,6 до 15,2‰. Во второй период ИП составили 19,3‰, в динамике наблюдается рост показателей с 15,8 до 24,0‰ в 2005 году. Заболеваемость РШМ имеет тенденцию к снижению с 19,1 до 16,3‰ в 2006-08 гг, со средними данными ИП 17,4‰.

Заболеваемость раком тела матки. Число заболевших РТМ было 484 больных. В первый временной период (2000-2002 гг) ИП заболеваемости по РТМ стали снижаться с 17,2 до 13,1‰, СП составили 14,8-11,0‰. Во второй временной период заболеваемости РТМ в области интенсивные показатели выросли с 11,1 до 16,0‰ и по СП – с 8,3-18,3‰. В 2006-2008 гг по РТМ они выросли до 11,7‰, и его СП составил 9,4‰.

Таким образом, уровень ЗН населения области в среднем за изучаемый период (2000-2008 гг.) был 228,6‰, СП (мировой) -213‰. Среднегодовые ИП заболеваемости среди женского населения составили 220,8‰. СП были ниже – 186,2‰.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА В 2010 ГОДУ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Мукушева А.Х.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

Актуальность: рак шейки матки прочно занимает 2 место в структуре онкологической заболеваемости женского населения области. За последние 5 лет наметилась тенденция к увеличению заболеваемости раком шейки матки, которая в 2010 г. составила 11,4 на 100000 населения. Смертность от рака шейки матки за последнее пятилетие существенно не изменилась и составила в 2010г. 4,0 на 100000 населения при Республиканском показателе 4,4. Показатель ранней диагностики увеличился по сравнению с 2010 г. на 15,3% и составил 71,8%. Показатель поздней диагностики за 2010г. понизился по сравнению с 2008г. на 3,2%. С учётом III стадии показатель понизился с 41,9 % в 2008 г. до 28,2% в 2010 г. Проведение цитологического скрининга с целью раннего выявления рака шейки матки в ранних стадиях его развития является единственным шансом улучшить онкологическую ситуацию по этой нозологии.

Материалы и методы: годовые статистические отчёты, отчёты цитологической лаборатории за 2010 год.

Цель работы: проанализировать эффективность проводимого в области профилактического осмотра в целях раннего выявления рака шейки матки путём цитологического скрининга.

В 2010 г. цитологический скрининг в Павлодарской области проведён 17923 женщинам в возрасте 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет и 72155 женщинам других возрастов. Обследовано 94403 женщин с профилактической целью и 6418 женщин с диагностической целью. Всего выявлено 24122 случаев патологии, что составляет 25,5% от общего количества обследованных. 5 случаев рака шейки матки выявлены при профилактическом цитологическом скрининге в рамках Республиканской программы по ранней диагностике рака шейки матки, 13 – у женщин других возрастов. Кроме того, выявлено дисплазий

лёгкой степени 2788, средней степени – 488, тяжёлой степени – 31, эрозий шейки матки – 648, инфекций, передающихся половым путём – 784, воспалительных заболеваний шейки матки – 19360. При анализе запущенных случаев рака шейки матки выявлено, что 64% запущенных случаев регистрируются в возрастной группе женщин старше 50 лет. Цитологическое исследование цервикальных мазков по Папаниколу остается основным методом скрининга заболеваний шейки матки. Метод дает возможность оценить структуру и клеточный уровень повреждения тканей, попавших в мазок-отпечаток. Основной целью цитологического исследования является выявление морфологических особенностей клеток, характеризующих конкретный процесс. Учитываются клеточные, структурные и функциональные признаки злокачественного перерождения клеток. Ложноотрицательные ответы гораздо чаще связаны не с погрешностями работы цитоморфолога, а с нарушениями техники сбора и обработки цитологического материала. При этом выявилась зависимость качества мазков от характера используемых инструментов. Мы добиваемся, чтобы техника забора Пап – мазков была строго регламентирована. Лучшим методом сбора клеток признано использование комбинации шпателя Эйра и эндоцервикальной щетки. Такая комбинация может способствовать более эффективному выявлению атипического эпителия.

Результаты и выводы: в связи с высоким уровнем заболеваемости раком шейки матки цитологический метод занимает главенствующую роль в ранней диагностике, позволяя повысить выявляемость рака шейки матки на ранних стадиях, увеличить число больных с 5-летней выживаемостью до 90% и снизить смертность от этого заболевания. Необходимо более активно проводить цитологический скрининг женщинам в возрасте старше 50 лет.

ЭРЕКТИЛЬНЫЕ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ*Кабилдина Н.А.**Карагандинский государственный медицинский университет*

Актуальность. Рак предстательной железы (РПЖ) – один из наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований у мужчин среднего и пожилого возраста. Лечение больных раком предстательной железы – сложная и многоступенчатая задача. В онкоурологии используют хирургическое, лучевое и лекарственное лечение. Важно, чтобы онколог-уролог использовал в лечебной практике, прежде всего, онкологические подходы, которые направлены на сохранение и продление полноценной жизни пациента.

Цель исследования – оценить наличие половой дисфункции у больных раком предстательной железы в зависимости от проведенного лечения.

Материалы и методы. В исследование включено 62 больных раком предстательной железы в стадии T1-3 N0-1 M0. В основу работы были положены результаты исследований уродинамики, качества жизни, данных самоопросника, составленного автором.

Больные местнораспространенным раком предстательной железы были распределены на 3 группы. Возраст больных колебался от 39 до 69 лет. Средний возраст составил 54 года.

I группа из 33 больных местнораспространенным РПЖ, получивших ДГТ по радикальной программе. Дистанционная лучевая терапия проводилась пациентам, которым противопоказано хирургическое лечение, и тем, кто отказался от операции. Стандартная доза облучения: РОД 2 Гр, СОД 65-70 Гр на предстательную железу и 44 Гр на таз. Чаще всего применяется облучение до СОД 40 Гр с последующим перерывом на 3 недели и продолжением курса до достижения необходимой суммарной дозы.

II группа - 21 больных местнораспространенным РПЖ, получивших гормонотерапию. Основное место в лечении диссеминированного рака предстательной железы принадлежит гормональной терапии. Билатеральная орхэктомия является «золотым» стандартом в лечении больных метастатическим раком предстательной железы. С открытием агонистов LHRH-гормонов появилась возможность замены хирургической

кастрации на медикаментозную.

III группа - 8 больных, которым после проведенного хирургического лечения в объеме радикальной простатэктомии по поводу локализованного рака предстательной железы, выявлен местнораспространенный процесс, по поводу чего пациентам была проведена ДГТ на малый таз. Радикальная операция включает удаление всей предстательной железы, семенных пузырьков, простатического отдела уретры и шейки мочевого пузыря. Обязательным является выполнение тазовой лимфодиссекции со срочным гистологическим исследованием. Последняя включает удаление наружных и внутренних подвздошных и запирающих лимфатических узлов от бифуркации общей подвздошной артерии до запирающего отверстия.

Результаты и обсуждение. При обследовании после проведенного лечения получены следующие данные. У пациентов с диагнозом рак предстательной железы ухудшение эректильной функции отмечалась во всех трех группах. Однако следует отметить, что в группе больных, которым было проведено лечение в объеме радикальной простатэктомии с последующей дистанционной лучевой терапией эректильная дисфункция тяжелой степени наблюдалась у всех пациентов.

Причем, разницы между больными с эректильной дисфункцией, получавших ДГТ и РПЭ+ДГТ и между больными получавших гормонотерапию и РПЭ+ДГТ являются достоверно значимыми ($p < 0,05$). А разница между больными с нарушениями эрекции, получавших ДГТ и гормонотерапию оказалась не достоверной ($p > 0,05$).

Выводы. У пациентов с диагнозом рак предстательной железы, получивших ДГТ ухудшение эректильной функции отмечалась в 46,55 %, гормонотерапию – в 33,3%. А в группе больных, которым было проведено лечение в объеме радикальной простатэктомии с последующей дистанционной лучевой терапией эректильная дисфункция тяжелой степени наблюдалась у 100% пациентов.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЛЕГКОГО ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ*Шериева Т. М.**КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан*

Задачи исследования: анализ заболеваемости раком легкого (РЛ) в Карагандинской области за 3 года (2008-2010гг.).

Материалы и методы исследования. Проанализированы данные медицинской документации (годовые отчеты, стационарные и амбулаторные карты, стат. карты, стат. талоны, извлечения, выписки и др.). Применялись клинические, лабораторные, ультразвуковые, рентгенологические, эндоскопические, цитоморфологические, социальные, эпидемиологические, статистические, математические методы исследования с использованием частотного анализа в программе «Statistica 5.». Дополнительно больным назначались трансторакальные, плевральные пункции, пункции лимфатических узлов и т.д. Все больные, направленные в ООД с диагнозом РЛ (подозрение на РЛ) проходили обследование в поликлинике ООД для подтверждения диагноза - верификацией опухолевого процесса. При невозможности верификации, больные госпитализировались и материал с опухоли брался интраоперационно. После верификации злокачественного процесса больным РЛ назначались различные виды специализированного с учетом все показаний и противопоказаний.

Результаты. В современном обществе РЛ является важ-

ной не только медицинской, но и социально-экономической проблемой. Это можно объяснить повсеместным ростом заболеваемости, инвалидизации и смертности, малой эффективностью и высокой стоимостью лечения, реабилитационных и превентивных мероприятий, длительной и часто необратимой утратой трудоспособности больными, значительными затратами на социальное обеспечение и страхование, приводящие к определенным экономическим затратам. Также к этому можно добавить трудности ранней диагностики, зачастую скрытое и агрессивное течение заболевания, многообразие морфологических форм и бурное метастазирование. В этой связи РЛ обретает особую важность и актуальность, и несомненно, своевременная диагностика, лечение, профилактика и организация противораковой борьбы при данной онкопатологии обретает первостепенное значение.

Всего за последние 3 года (2008-2010 гг.) в КООД выявлено 8668 больных со злокачественными новообразованиями, из них 1030 составили больные с опухолевыми процессами органов дыхания. Все они обследованы и пролечены в диспансерном и торакальном отделениях ООД. Заболеваемость РЛ по области за 2008-2010гг. составила 27,6; 27,1 и 25,4 на 100

тысяч населения. При этом запущенные стадии РЛ составили 51, 45,8 и 43,9%. Казалось бы, заболеваемость и запущенность РЛ имеют тенденции к снижению, тем не менее, эти показатели достаточно высокие, и РЛ продолжает занимать лидирующие позиции в ранге онкопатологии.

За этот период на учете с впервые установленным диагнозом РЛ на конец года состояли 1662 больных, умерли 964. У 107 пациентов имелись противопоказания к проведению специализированной терапии, 55 пациентов отказались от лечения и 103 не завершили лечение. Проведены следующие виды лечения: 50 больным хирургическое, лучевая терапия

- 23, химиотерапия - 41, комбинированное лечение - 40, комплексное - 42 и амбулаторное - 9 больным.

Выводы: Изучение динамики заболеваемости и смертности от РЛ имеет большое значение для принятия обоснованных решений и планирования тенденции противораковой борьбы. Работа в тесной параллели врачей-диагностов и клиницистов, направленная на раннюю диагностику и эффективную терапию рака легкого, способствует в конечном итоге снижению заболеваемости, инвалидности и смертности. Это позволяет улучшить реабилитацию, качество жизни и прогноз заболевания у каждого больного.

СПОСОБ ДЕРИВАЦИИ МОЧИ ПОСЛЕ ЦИСТЭКТОМИИ У ПОЖИЛЫХ

Дудяк О.В.

«Областной онкологический диспансер», СКО, г. Петропавловск

Проблема деривации мочи после радикальной цистэктомии у пациентов пожилого возраста в настоящее время становится все более актуальной, поскольку именно этот контингент является основным в структуре пациентов, страдающих инвазивным раком мочевого пузыря. Методы ортотопической пластики применяются для этих больных с большой осторожностью, так как частота рубцовых стриктур резервуарно-уретрального анастомоза весьма велика. Своевременная коррекция этого осложнения не всегда возможна, особенно для сельских жителей.

Мы применили следующий способ. После выполнения радикальной цистэктомии выполняется мобилизация правой половины ободочной кишки и выключение сегмента, состоящего из 10 см терминального отдела подвздошной, слепой и восходящей кишки с питанием из подвздошно-ободочных сосудов. Сегмент разворачивается илеоцекальным углом вверх и наружу. Отрезок подвздошной кишки используется для формирования сухой уростомы в правом гипогастрии. Мочеточники анастомозируются с восходящей кишкой. Формируется резервуарно-уретральный анастомоз отдельными швами. Восстанавливается непрерывность кишечника (илеотрансверзоанастомоз).

Суть способа в том, что в послеоперационном периоде после извлечения мочеточниковых стентов на 10-12 сутки пациент обучается технике самокатетеризации и выводит мочу из

резервуара самостоятельно. Через 20 дней после операции извлекается катетер из уретры, а уростомы блокируется перекрытым катетером Фоли. Пациенты обучаются удерживать мочу. Мочеиспускание осуществляется через уретру. Промывание резервуара - через катетер Фоли (в уростоме).

Контроль проводится через 3 месяца, если у пациента не наступает стенозирование резервуарно-уретрального анастомоза. В этом случае больному выполняется бужирование. К сожалению, далеко не все пациенты имеют возможность своевременно явиться на эту процедуру. Через 3 месяца принимается решение о закрытии уростомы. Если же естественное мочеиспускание не восстановилось, то пациент возвращается к использованию уростомы (самокатетеризация).

Результаты: по описанной методике прооперировано 8 пациентов в возрасте старше 65 лет. Отбор пациентов для операции - стандартный, оценивалась возможность перенести травму в объеме радикальной цистэктомии. Наличие уретерогидронефроза без выраженных клинических и биохимических проявлений почечной недостаточности не являлось показанием к пересмотру плана операции. У 5 из прооперированных больных мочеиспускание происходит через уретру, четверым уростомы закрыты. У троих деривация мочи осуществляется через сухую уростому в связи со стенозированием резервуарно-уретрального анастомоза на фоне стойкой и несвоевременно бужуемой рубцовой стриктуры.

АСҚАЗАН РАҒЫНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ

Игісінов С.И., Қайдаров Б.К., Есенқұлов Ә.Е.

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

Асқазан рагының (АР) эпидемиологиялық ерекшелігін анықтау үшін Қазақстандағы 2006-2008 жылдар арасындағы мәліметтер сарапталған.

Жер шары бойынша АР аурушандық көрсеткіші әртүрлі деңгейде тіркелген, оның ең жоғарғы аурушандық көрсеткіші Жапонияда анықталған, онда еркектер арасында бұл көрсеткіш 69,2‰; әйелдерде - 28,6‰ тең болған, ал ең төменгі көрсеткіш Солтүстік Африкада қатталған.

АР дүние жүзі бойынша барлық қатерлі ісіктердің ішіндегі меншікті үлесі 8,7% тең болған, ал Ресейде - 10,2% құрап, ол өкпе, тері рагынан кейін үшінші орында тұр. Қазақстанда бұл көрсеткіш бірқалыпты деңгейде: 10,0 — 10,2% құрап, барлық қатерлі ісіктердің ішінде 4- орынды алады. Еркектер арасында асқазан рагы (2006-2008 жж.) өкпеден кейін (22,0-28,0%) нақты екінші орында (12,7-13,2%), ал әйелдерде - сүт безі (19,8%), - тері (11,9%), жатыр мойны (8,3%) қатерлі ісіктерінен кейін 4- орында (7,4%) тұр.

АР аурушандық көрсеткіші Қазақстанның әрбір облыстарында бір қалыпты тарамған, ең жоғарғы аурушандық көрсеткіші Шығыс-Қазақстан (22,2‰), Қарағанды (21,5‰), Павлодар (27,0‰) және Ақмола (22,0‰)

облыстарында тіркелген, сонымен қатар ең төменгі көрсеткіш Жамбыл (13,4‰), Оңтүстік Қазақстанда (12,1‰), Атырау (13,4‰), Маңғыстау (12,4‰) облыстарында және Астана қаласында (12,9‰) анықталған.

АР Қазақстанның аймақтары бойынша аурушандық ерекшелігі осы заңдылыққа сәйкес келеді. Асқазан рагының ең жоғарғы аурушандық көрсеткіші Қазақстанның Шығыс (24,6‰), Орталық (21,8‰) және Солтүстік (16,8‰) өңірінде және Алматы (19,2‰) мен Астана (19,0‰) қалаларында анықталса, ең төменгі көрсеткіші Оңтүстік аймақта (14,4‰) тіркелген. Жалпы Қазақстан бойынша орташа асқазан рагының аурушандық көрсеткіші 18,3‰.

Жас пен жыныс аралық аурушандық ерекшеліктерінде, еркектер (13,2‰) әйелдерге қарағанды (7,4‰) екі есе жиі ауырады. Жас адамдарда асқазан рагы сирек кездеседі де, жас өскен сайын аурушандық көрсеткіші едәуір өсе түседі, әсіресе 60 пен 65 жас аралығындағы адамдарда.

Қазіргі таңда АР мен созылмалы ойық жарасы бар науқастарда жұқпаның рөлі, соның ішінде - *Helicobacter pylori* (Нр) бактериясы негізгі себептің бірі ретінде қаралып, бұл феномен ісіктің морфологиялық құрылысына байланыс-

сыз екені анық болып отыр. Бұдан да басқа себептердің де маңызы зор, соның ішінде - жайылмалы клеткалы ракта - тұқым қуалаушылықтың және тағамның рөлі басымырақ, Түйінді (интестинальды) ракта тағаммен бірге түсетін, не асқазанда пайда болатын канцерогендік заттардың (нитрозамин, афлотоксин, т.б.) және де, ұлтабардан асқазанға келетін өт қышқылының рөлі ерекше болып отыр.

АР сақтану шараларына - тағамдану ережесін дұрыс сақтау, канцерогендерді тағаммен бірге түсуді шектеу, олардың зиянды іс-әрекеттерін тежейтін витаминдерді қабылдау – ең

негізгі сақтану шара деп саналады.

Осындай негізгі шараларға жататындар:

- көкөністерді күніне 4-5 рет қолдану,
- күйдірілген, ысталған, тұзды астардан және майлы тағамдарды аз қолдану,
- арақты аз ішу,
- темекі тартпау,
- азотты тыңайтқыштарды (нитрит, нитрат, аммиак) ауыл шаруашылығында, бақшаларда аз пайдалану.

КОЛОРЕКТАЛЬДЫ РАКТЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ

Игісінов С.И., Қайдаров Б.К., Есенқұлов Ә.Е.

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

Колоректальды рақтың эпидемиологиялық ерекшелігін анықтау үшін Қазақстандағы 2006-2008 жылдар арасындағы мәліметтер сарапталған.

Тоқ ішектің жиекті бөлігінің рагы (ТЖР) барлық қатерлі ісіктердің 9,4% құрайды. Ең жиі кездесетін жерлерге - Шығыс Еуропа, Австралия, Солтүстік Америка, Израиль, Жапония елдері жатады. Оңтүстік, Орталық Америкада, Африка және Азия елдерінде бұл ісік сирек кездеседі.

Ресейде тоқ ішек рагы реттік саны бойынша 5-орында тұр, ал оның өзіндік үлесі жалпы қатерлі ісік ішінде 6,0% тең де, ал аурушандық көрсеткіші еркектер ішінде 16,9%ооо, ал әйелдер арасында - 15,9%ооо.

Жалпы Қазақстан бойынша ТЖР аурушандық орташа (2006-2008 жж.) көрсеткіші 7,6%ооо-ке тең болса, ал оның әрбір облыстарында бір қалыпты тарамаған, ең жоғарғы аурушандық көрсеткіші Батыс Қазақстан (10,5%ооо), Қарағанды (11,6%ооо), Шығыс-Қазақстан (11,8%ооо), Қостанай (12,1%ооо), Солтүстік Қазақстан (12,1%ооо), Павлодар (14,3%ооо) және Ақмола (14,3%ооо) облыстарында тіркелген, сонымен қатар ең төменгі көрсеткіш Оңтүстік Қазақстанда (2,3%ооо), Қызылорда (2,4%ооо), Алматы (3,3%ооо), Жамбыл (3,6%ооо), Атырау (4,2%ооо), Маңғыстау (4,2%ооо) облыстарында және Астана қаласында (7,5%ооо) анықталған.

ТЖР Қазақстанның аймақтары бойынша аурушандық ерекшелігі, жоғарыдағы заңдылыққа сәйкес келеді. Оның ең жоғарғы аурушандық көрсеткіші Қазақстанның Шығыс (13,0%ооо), Орталық (10,3%ооо) және Солтүстік (12,1%ооо) өңірінде және Алматы (11,0%ооо) мен Астана (7,5%ооо) қалаларында анықталса, ең төменгі көрсеткіші - Оңтүстік (2,9%ооо) пен Батыс (6,3%ооо) аймақтарда тіркелген. ТЖР Шығыс аймақтағы аурушандық көрсеткіші, Оңтүстік өңірмен салыстырғанда 4,5 есе артық болған.

Тік ішек рагы (ТР) - жер шарында көп тараған ісік ауруы, оның жиі кездесетін жерлері Австралия, АҚШ, Канада,

Израиль, кейбір Еуропа елдері, соның ішінде Ресейде де бар. Тік ішек рагы, Ресейде барлық қатерлі ісіктердің 6,0% құрайды. Еркектерде 1,5 есе жиі байқалады. Жалпы Орта Азия елдері бұл аурумен сирек зақымданады.

Республика бойынша орта есеппен (2006-2008 жж.) ТР аурушандық көрсеткіші – 7,4%ооо тең, ең жоғарғысы - Қарағанды (10,3%ооо), Шығыс Қазақстан (10,9%ооо), Солтүстік Қазақстан (12,6%ооо), Қостанай (12,9%ооо), Ақмола (13,4%ооо) және Павлодар (13,4%ооо) облыстарында. Төменгі деңгейдегі көрсеткіштері - Қызылорда (2,5%ооо), Оңтүстік Қазақстан (2,7%ооо), Жамбыл (3,5%ооо), Алматы (4,5%ооо) және Маңғыстау (4,8%ооо) облыстарында тіркелген. Алматы қалаласындағы ТЖР орташа аурушандық көрсеткіші 11,0%ооо тең болса, ол – Астанамен (6,7%ооо) салыстырғанда 1,6 есе жоғары.

Қазақстан аймақтары бойынша ТР орташа аурушандық көрсеткіші де біркелкі емес, ең жоғарғы көрсеткіш - Орталық (9,4%ооо), Шығыс (12,2%ооо) және Солтүстік (12,7%ооо) аймақтарда анықталса, ал ең төменгі көрсеткіші Оңтүстік өңірде (3,3%ооо) тіркелген. Оңтүстік өңірдегі елдердің ТР аурушандық көрсеткіші, басқа Қазақстан аймақтарымен салыстырғанда 3 есе аз. Ресейде де, Қазақстанда да тік ішек рагымен ауырған адам саны кейінгі жылдарда сәл де болса өсуде. ТР жас өскен сайын, оның меншікті үлесімен аурушандық көрсеткіші де өсуде, әсіресе 70-тен асқандарда, 40-49-дағыларға қарағанда, ісік 10 есе сирек анықталынады. Бұл айырмашылық сол өлкелердегі этностардың құрамы мен тағамдану ерекшелігіне байланысты, себебі Шығыс, Орталық және Солтүстік аймақтарда жергілікті ұлтың өзіндік салмағы, Оңтүстік және Батыс аймақпен салыстырғанда 2 есеге жуық аз, ал керісінше аурушандық көрсеткіші жоғары аймақтарда басқа еуропалық ұлтар басым болып отыр. Осыған байланысты тағам түрлерінің рөлі айқын көрініп тұр.

ОНКОМАММОЛОГИЯДАҒЫ ДӘРІГЕРЛЕРДІҢ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ҚАТЕЛІКТЕРІ

Есенқұлов Ә.Е., Қайдаров Б.К., Есенқұлова С.Ә., Игісінов С.И.

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

Сүт безінің рагы (СБР) Қазақстанда жыл сайын өсуде, өсу қарқыны 3-5,0% тең, ал ол әйел ағзасындағы барлық ісіктердің 19-20,0% құраа, қазір ең бірінші орында. Жыл сайын бұл ісік ауруының Ш-1У- сатысында анықталатын үлесі Республика бойынша 28,7%. Соның ішінде алғашқы рет 1У- сатысындағысы 6,4%. Сондықтан бұл ауруды алғашқы сатысында анықтау медицина ғылымымен тәжірибелік денсаулық сақтау мекемелерінің негізгі мақсаты болып саналады, себебі жыл сайын алғаш рет тіркелген науқастың асқынған сатысының өсуі тек жалпы дәрігерлердің қателігінен туындап отыр. Осыған байланысты бұл мақалада дәрігерлік қателіктердің неден туындайтыны туралы сөз болмақ. Өкінішке орай бұл мәселе арнайы әдебиеттерде аз кездеседі және жан-жақты талқыланбаған. Сонымен бұл мақаланың мақсаты мыналарға

сүйенеді: 1- сүт безі рагында дәрігерлердің диагностикалық қателіктерін, олардың жиіліктерін, себептерін анықтау; 2- Клиникалық әдістердің құндылығын дәлелдеу; 3- қателіктерді жою мүмкіншіліктерін қарастыру және оларды тәжірибелік медицинаға ұсыну.

Зерттеудің мақсаттарына сәйкес 1124 науқастың даму тарихын сүйене отырып, көру сипау кезіндегі көрністері, 550 морфологиялық зерттеулердің қортынды нәтижелері мен салыстырылып, олардың клиникалық, диагностикалық әдістің құндылығы анықталды. Зерттеу жұмыстарының нәтижелеріне байланысты, тек науқастың анамнезі бойынша 55,0±2,4% жағдайда, ал ісікті көру арқылы - 55,0±2,1%, оны сипап анықтауда 60,0±2,0% диагноз дәл қойылған. Ал енді бұл әдістер қосарланып қолданса, онда диагностикалық дәлдік

70,0±1,9% жеткен.

Осы талдаудың нәтижесінде анықталған дәрігерлік қателіктер:

Дәрігерлердің науқаспен сұхбаттасу кезінде, анамнезін толық жинамауы (10,0%);

Әйел ағзасындағы табиғи қызметтерінің (етеккір, жыныстық қатынас, бала көтеру және оны емізу) жан-жақты жиналмауы (5,0%);

Ағзадағы созылмалы ауруларды және тұқым қуалаушылық факторды ескермеуі (7,0%);

Иммунды, эндокринологиялық бұзылыстарды дұрыс анықтай алмауы (5-10,0%);

Науқасты тексеру кезінде емшекті сипау дұрыс жүргізілмей, оны жарық емес бөлмеде өткізуі (3,0%);

Өр әдістің нәтижелері бір-бірімен салыстырылмауы (20,0%);

Дәрігердің білімі жеткіліксіздіктен клиникалық белгілерді қате есептеуі (15-20,0%);

Сонымен дәрігерлердің диагностикалық, клиникалық

әдістерді қолдану кезінде қателесуі 50-60,0% жағдайда орын алған, ал тек әдістердің барлығын қосарлана қолданғанда ғана дәрігерлік қателіктердің үлесі 20-30,0% кеміген.

Барлық диагностикалық қателіктер объективті, субъективті факторларға байланысты болғандықтан, осы қателіктердің үлесін азайту үшін дәрігерлердің онкологиялық білімдерін ұдайы жетілдіріліп отырылуы керек.

Клиникалық диагностикалық әдістер (анамнез, көру, сипау) стандартты жүйеде орындалатындықтан оларды дұрыс қолдану, СБР анықтаудың негізі болады.

СБР дер кезінде дәл анықтаудың негізі- осы көрсетілген әдістерді кешенді түрде жүргізіп, олардың нәтижелерін салыстыра отырып талдау онкологиялық қағидалардың орындалуына мүмкіндік тудырады және оның алғашқы сатысында анықтауға мүмкіндік береді.

Дәрігерлік қателіктер жалпы дәрігерлік мәжілісте дер кезінде талқыланып, одан раққа қарсы ұйымдастыру шаралары жасалса, сонда ғана көздеген мақсатқа жетуге болады.

ӨҢЕШ РАГЫНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ

Игісінов С.И., Қайдаров Б.К., Есенқұлов Ә.Е.

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

Өңеш рагының (ӨР) эпидемиологиялық ерекшелігін анықтау үшін Қазақстандағы 2006-2008 жылдар арасындағы мәліметтер сарапталған.

Жер шары бойынша ӨР көп тараған жерлеріне - Солтүстік Иран, Қытайдың кейбір аудандары, Оңтүстік Африка, Түрікменстан және Өзбекстан жатады. Қазақстан бойынша барлық қатерлі ісік ауруларының ішінде ӨР өзіндік салмағы еркектерде -5,6%, әйелдерде - 4,5% құраса, ал жалпы үлесі бойынша 5- орында, өкпе, тері, сүт безі және асқазан рақтарынан кейін тұр. Ерлер арасында 4-орынды, ал әйелдер арасында 7-орынды алады.

1980 жылдан бастап, Қазақстанда ӨР аурушандық көрсеткіші төмендеуде. 1980 жылғы көрсеткіші – 20,3‰ болса, 1990 жылы – 15,0‰, 2000 жылы – 11,2‰, ал 2005 жылы – 9,3‰ дейін төмендеп, соңғы 2006-2008 жылда - 8,9‰ тен болған. Мұндай қарқын республиканың барлық облыстарында да байқалып отыр. 1989 жылы аурушандық көрсеткіші жоғары болған Батыс аймағындағы – Атырау (30,1‰), Ақтөбе (23,1‰) және Батыс Қазақстан (25,6‰) облыстарында тіркелсе, ал осы баламалы көрсеткіш 2008 жылы – 14,0‰, 14,5‰ және 17,5‰, сәйкестікте, тең болып, шамамен 1,5-2,0 есе төмендеп отыр. Республика бойынша (2006-2008 жж.) ӨР ең жоғарғы аурушандық көрсеткіші - Қызылорда (23,0‰), Батыс Қазақстан (17,2‰), Маңғыстау (13,9‰), Атырау (13,8‰) және Ақтөбе (14,1‰) облыстарында тіркелсе, ал өте сирек кездесетін жерлерге - Алматы (6,2‰), Астана (4,2‰) қалалары мен Жамбыл (7,2‰), Солтүстік Қазақстан (7,1‰) және Оңтүстік Қазақстан (7,7‰), соның ішінде орташа аурушандық көрсеткіш – Ақмола (8,2‰), Павлодар (8,2‰) және Шығыс Қазақстан (9,3‰) облыстарында анықталған. Өңеш рагының Республикамызда жиі тараған аймақтарына - Батыс (14,7‰) пен Оңтүстік (11,1‰) өңірінің тұрғындары орын алады, ал ең төменгі көрсеткіші Орталық (7,3‰) пен Солтүстік (7,3‰) өңір мен Алматы

(5,2‰) және Астана (4,2‰) қалаларында анықталған. Сонымен Қазақстанда жиі кездесетін аймақтардағы қазақ ұлтының тұрғындары, басқа ұлттармен салыстырғанда, өңеш рагымен 5-10 есе жиі ауырады. Әлемдік стандарт бойынша анықталған еркектер арасындағы аурушандық көрсеткіш, әйелдерге қарағанда 6 есе жиі болған. Жас ұлғайған сайын аурушандық көбейе береді де, - ең жоғарғы көрсеткіш егде жастағы адамдарда кездеседі, ал 60 жастан асқандар, 40-49 жастағыларға қарағанда 10 есе жиі ауырады.

Соңғы жылдары онкоэпидемиологиялық зерттеулердің нәтижесінде ӨР таралу ерекшеліктері де анықталып отыр. Соның ішінде көршілес Қырғызстанда жүргізілген ғылыми жұмыс бойынша (С.И.Игісінов), ӨР таулы аймақтағы ерекшелігі байқалып, оның аурушандық көрсеткіші теңіз деңгейіне байланыстығы анықталған. Халықтардың теңіз деңгейінен бастап, одан төмен және биікті жерлерде қоныстануына қарай, өңеш рагының аурушандық көрсеткіші әрбір 200- 500 метрге биіктеген сайын төмендей берген. Қазақстандағы Атырау облысындағы (-28,5 тен 100 м. дейін) тұрғындардың ӨР аурушандық көрсеткіші, Қырғызстандағы Нарын облысымен (2500 м) салыстырғанда 17 есе, Ыстық-Көл облысымен (1600 м.) - 9 есе, Чуй облысымен (1200 м.) - 8 есе артық кездескен. Сонымен қатар таулы жерде тұратын елдердің этникалық тобына байланысты ерекшелігі анықталған. Жергілікті қырғыздардың ӨР аурушандығы, сол жерде тұратын қазақтармен салыстырғанда 2-3 есе сирек шалдығатыны, ал Қырғызстанда тұратын қазақтар, тарихи отанында тұратын отандастарымен салыстырғанда 5 есе кем ауратыны анықталған. Бұл көрсетілген өзгешіліктер таулы жердегі гипоксиямен байланыстылығы дәлелденген. Жалпы қатерлі ісіктер, оның ішінде өңеш рағы, таулы гипоксияға бейімделген адамдарда сирек кездесетіні анықталған және де, табиғи жер бетінде ағатын, оның астындағы сулардың, топырақтың нитрозаминді құратын заттар мен ыластануына байланыстығы дәлелденген.

СҮТ БЕЗІ РАГЫНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ

СҮТ БЕЗІ РАГЫНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ АҒЫМЫН БОЛЖАУДАҒЫ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ТҮРЛЕРІНІҢ РӨЛІ

*Есенқұлов Ә.Е., Қайдаров Б.Қ., Есенқұлова С.Ә., Игісінов С.И.
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ*

Жұмыстың мақсаты: сүт безі рагын (СБР) оның морфологиялық құрылысымен байланыстыра отырып, оған болжам жасау жолдарында пайдалану.

СБР – өте қауіпті қатерлі ісіктің біріне жатады. Себебі ол негізінен бөгелме ісік (БІ) беру арқылы науқасты тез арада өлімге душар етеді.

СБР неше түрлі клиникалық ағымда кездеседі; оның кейбір түрі, кейде өте баяу өсіп, көпке дейін БІ бермейді, ал көпшілігінде тез арада өршіп, БІ ерте пайда болып асқынады, ал кейбіреулері арнайы емге төзімді болып ісік тез арада өршиді. Осы көріністерді СБР-дың морфологиялық түрлерінен анықтауға және де оның алдын-ала болжам жасауға мүмкіншілік береді.

Зерттеудің негізгі шартты мәселелері:

СБР-дың морфологиялық түрлерінің жиілігін анықтау,

Олардың өмірге қауіпті түрлерін ажырата білу,

Морфологиялық түріне байланысты бөгелме ісіктің пайда болу жиілігін және олардың морфологиялық құрылысына байланыстылығын көрсету.

Жалпы СБРмен ауғандардың өмір сүру болжамындағы морфологиялық өзгерістердің рөлін сараптау,

Тәжірибелік денсаулық сақтау жүйесіне дәйекті ұсыныс жасау.

Жұмыстың мақсатына жету және осы сұрақтарға жауап алу үшін СБР дәлелденген және емделуге келген 250 науқас тесерілген, бұлардың бәрі 30-60 жас аралығындағы әйелдер. Аурулардың барлығы морфологиялық жолмен зерттеліп, оның құрылысы анықталған (биопсия немесе хирургиялық операция арқылы) және олардың барлығына бірдей клиникалық тексеру әдістері қолданған.

Сонымен 250 СБР-дің, 225 ($90,0 \pm 2,0\%$) науқасына жайылмалы-инвазивті, ал 25-інде ($10,0 \pm 2,3\%$) жайылмалы емес рак анықталған. СБР - 41 науқаста ($16,4 \pm 2,3\%$) сүт безінің

сүт жолдарынан, 109 жағдайда ($83,6 \pm 2,3\%$) сүт өндірілетін бөлімдерінен пайда болған.

Пісіп жетілуіне сәйкес рак клеткалары жоғарғы деңгейде өніп өскені - 40 ($16,0 \pm 2,3\%$) әйелде, орташа деңгейдегісі - 70 ($28,9 \pm 2,8\%$) науқаста, ал ең төменгі деңгейдегісі - 140 ($56,0 \pm 3,0\%$) ауруда анықталған.

СБР-дың морфологиялық түрлері сан алуан: безді - 37 ($14,8 \pm 2,2\%$), солидты - 88 ($35,2 \pm 3,0\%$), скirroзды - 43 ($17,2 \pm 2,3\%$), солидты-скirroзды 57 ($22,8 \pm 2,6\%$), сүт өзегінен шыққан шашақты - 14 ($5,60 \pm 1,5\%$), медуллярлы - 4 ($1,6 \pm 0,7\%$) және жылауықты (кистозды) - 7 ($2,8 \pm 1,0\%$) түрлері дәлелденген. БІ болуы және олардың жиілігі тікелей СБР-дың морфологиялық құрылысына байланыстылығы анықталған. СБР-дың жайылмалы түрі 75,0% жағдайда, ал жайылмалы емес түрі - 25,0% БІ берген. Осыған байланысты аурулардың бес жылдық өмір сүру мерзімі де өзгерген - СБР-дың жайылмалы түріндегі аурулардың 24-26,0% ғана орташа есеппен емнен кейін бес жыл өмір сүрген, ал жайылмалы емес түрінде бұл көрсеткіш 3-4 есе жақсарған.

Сонымен СБР-дың морфологиялық түрлері көп және олар неше түрлі жиілікте кездеседі. Оның сүт өндіретін бөлімдері ($83,6\%$), сүт жолдарына ($16,4\%$) қарағанда жиі жарақаттанады. СБР-дың басым көпшілігі жайылмалы ($90,0\%$), ал сирек кездесетін түрі жайылмалы емес емес ($10,0\%$) рак. БІ беру жиілігі тікелей морфологиялық құрылысқа байланысты - бірінші орында скirroзды рак, ол 70-79,0% ауруларда, ал ісіктің таза безді түрі 32,4% жағдайда БІ береді. Тек қана морфологиялық түрлермен болжам тоқталып қалмайды, ісік клеткасының пісіп жетілуіне де тікелей клиникалық ағымға әсерін тигізеді. Рак клеткасы 16,0% жағдайда жоғары деңгейде пісіп жетіледі. де ол 30,0%, ал пісіп жетілмеген рак ($56,0\%$) - 80,0% жағдайда БІ пайда болады, сондықтан оның бұл түрі өте қауіпті болып саналады.

ПРИМЕНЕНИЕ МАБТЕРЫ ПРИ ЛИМФОМАХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

*Каракулов Р.К., Габбасова С.Т., Джазылтаева А.С., Сагиндыков Г.А., Насипов Б.А.
РГП на ПХВ Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы.*

Лимфомы желудочно-кишечного тракта является наиболее частым вариантом экстранодальных лимфом. Среди всех злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта НХЛ желудочно-кишечного тракта составляют около 10%. Прогноз благоприятный и в основном зависит от локализации процесса: 10-летняя выживаемость превышает 50% при поражении желудка (51%), тонкого кишечника (54%), толстого кишечника (35%). Чаще лимфома ЖКТ встречается у взрослых (средний возраст заболевших 61 год), несколько чаще у женщин (проф. Волкова М.А. 2007).

В работе приведены предварительные результаты лечения 6 больных с экстранодальным вариантом НХЛ желудочно-кишечного тракта, из них с поражением желудка - 3, тонкого кишечника - 2, толстого кишечника - 1 пациент с множественными метастазами в печень.

Критерии включения: Состояние пациента в момент осмотра, размеры опухолевого узла, данные рентгеномографических исследований, КТ и МРТ.

Критерии исключения: у пациентов выявлена гиперчувствительность к мабтере, возраст пациента свыше 70-80 лет, декомпенсация сердечной деятельности III-IV степени, печеночно-почечная недостаточность.

В группе наблюдаемых, было женщины-1, мужчины-5. У

пациентов с НХЛ желудка была проведена гастрэктомия, спленэктомия с лимфодиссекцией. У пациентов с поражением тонкого кишечника была проведена резекция тонкого и толстого кишечника с наложением анастомоза. Гистологически у всех больных была установлена диффузная крупноклеточная лимфома, иммуногистохимическое исследование показало присутствие во всех случаях CD 20+ антигена.

В условиях отделения гемобластозов всем пациентам было проведено 6-8 курсов химиотерапии по протоколу R-CHOP 21 в стандартных дозировках. У 5 пациентов отмечалась частичная регрессия процесса, полная регрессия процесса - 1 пациент. У 1 пациентки с НХЛ толстого кишечника с множественными метастазами в печень зарегистрировано частичная регрессия процесса. Состояние пациентов после лечения удовлетворительное, качество жизни по шкале Карновского составляет 3 бала. Отмечались эпизоды тромбоцитопении и лейкопении, которые были купированы введением колониестимулирующих факторов, переливанием тромбоконцентрата.

Таким образом, применение МаБтеры у больных с НХЛ желудочно-кишечного тракта показало хороший результат в виде частичной регрессии (70%) периферических лимфатических узлов и забрюшинного пространства и метастазов в печени.